



Презентация занятия по теме № 3

Организация ухода за больными соматического и инфекционного профилей. Организация и работа детского соматического отделения многопрофильной больницы, инфекционного отделения. поддержание гигиены тела пациентов. Роль среднего и младшего медицинского персонала.



Некоторые психологические особенности больных



Матвей Яковлевич
Мудров
1776-1831

“Чтобы правильно лечить больного, надобно узнать, во-первых, самого больного во всех его отношениях, потом надобно стараться узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, надобно объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, откроет внутреннее свойство свое и покажет наружный вид свой”

Осведомленность в вопросах медицины



- Знание о своем заболевании;
- Информированность о болезни проявляется по-разному (просьба применить какие-то диагностические или терапевтические методы быстрое и уверенное перечисление всех «своих» субъективных симптомов, характерных для какого-то заболевания);
- Наличие медицинского / смежного образования;
- Родственники – медицинские работники



Внутренняя картина болезни



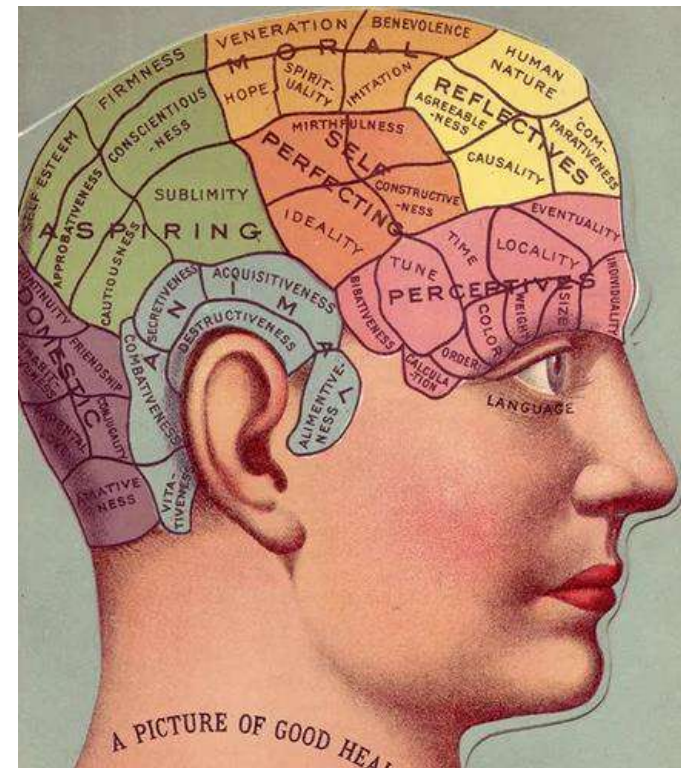
- это отражение болезни в переживаниях человека.
- Понятие объединяет в себе все то, «что чувствует и переживает больной, всю массу его ощущений, его общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах – весь тот огромный мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм» (Р.А. Лурия).
- ВКБ определяется не нозологической единицей, а личностью человека!



Внутренняя картина болезни



- ▶ Отношение к болезни состоит из трех компонентов: **когнитивный, эмоциональный и поведенческий** (Л.И.Вассерман).
- ▶ **Когнитивный** включает знание о болезни, ее осознание, понимание влияния болезни на жизненное функционирование больного, предполагаемый прогноз;
- ▶ **Эмоциональный**: субъективные ощущение и переживание болезни и всей ситуации, с ней связанной;
- ▶ **Поведенческий**: связанные с болезнью реакции, способствующие адаптации или дезадаптации к ней и выработку определенной стратегии поведения в жизненных ситуациях в связи с болезнью (принятие роли больного, активная борьба с болезнью, игнорирование, пессимистические установки и пр.).



Внутренняя картина болезни



Внутренняя (аутопластическая) картина болезни включает:

- ▶ переживания больного, связанные с его болезнью,
- ▶ значение ранних симптомов заболевания,
- ▶ особенности изменения самочувствия в связи с усложнением заболевания,
- ▶ представление о начинающемся улучшении самочувствия на этапе обратного развития болезни,
- ▶ представление о восстановлении состояния здоровья после болезни,
- ▶ представление о возможных последствиях болезни для себя, для семьи, для дальнейшей профессиональной деятельности,
- ▶ представление об отношении к нему в период болезни членов семьи, сотрудников по работе, медицинских работников,
- ▶ субъективное отношение к заболеванию.



Типы реакции личности на болезнь в зависимости от отношения к болезни (Л.Л. Рохлин)



1. **Астено-депрессивный тип.** Наблюдается эмоциональная неустойчивость, невыносливость к раздражителям, снижение трудовой мотивации, ощущение разбитости и подавленности, удрученности и тревожности.
2. **Психастенический тип.** Больной полон тревоги, страхов, убежден в худшем исходе, ждет тяжелых последствий. Одолевает врачей вопросами, ходит от одного к другому. Вспоминает симптомы болезни, бывшие у родных и знакомых, находит их признаки у себя и т.д.
3. **Ипохондрический тип.** Сходен с психастеническим типом, но меньше места отводится тревогам и сомнениям. Больной просто убежден в наличии у него болезни.
4. **Истерический тип.** Больной оценивает свою болезнь с преувеличением, чрезмерно эмоциональные, одевают болезнь в ореол исключительности, неповторимого мученичества, требуют к себе повышенного внимания, часто обвиняют окружающих в «недопонимании» их.
5. **Эйфорически-анозогнозический тип.** Наблюдается приподнятое настроение, невнимание к своему здоровью, отрицание наличия болезни, отказ от обследований и медицинских назначений.
6. **Анозогнозический тип.** Полностью отрицается наличие болезни. Такое «вытеснение» болезни чаще всего бывает при тяжелых опасных заболеваниях (злокачественные опухоли, психические заболевания, наркомания, алкоголизм и др.).
7. **Нормальный (адекватный) тип.** Больной адекватно оценивает серьезность своего заболевания, подчиняется требованиям лечебного процесса и активно участвует в нем.

Возраст и болезнь



- У **детей дошкольного возраста** собственная оценка заболевания еще не сформирована, у **детей младшего школьного возраста** она недостаточно полная и только **в пубертатном возрасте** приближается к оценке взрослых.
- **Дети** более тяжело переносят боль и страдания, боятся больничной обстановки, медицинских инструментов и манипуляций, хирургического вмешательства. Но все зависит от родителей и врачей!
- Для **детей, подростков и молодежи** наиболее тяжелыми в психологическом отношении оказываются болезни, которые изменяют внешний вид человека, делают его непривлекательным.
- В **молодом возрасте (18-35 лет)** чаще встречаются переоценка своего здоровья и недооценка болезни, неверие в возможность тяжелого заболевания, инвалидизации.
- В **зрелом возрасте** наиболее выраженные психологические переживания и возможные психические расстройства связаны с хроническими, прогностически неблагоприятными, инвалидизирующими заболеваниями (нарушения кровообращения, тяжелые инфаркты, онкологические заболевания).
- Для **пожилых и престарелых людей (60 – 74 гг.)** наиболее значимыми являются болезни, которые могут привести к смерти. Инфаркт, инсульт, злокачественные опухоли страшны для них не тем, что ведут к утрате трудоспособности, а тем, что ассоциируются со смертью.
- Для **старческого возраста (75 лет и старше)** характерно преувеличение тяжести заболевания, однако достаточно часто встречается недооценка тяжести, опасности болезни из-за снижения критики, интеллектуальной несостоятельности, эйфории, появляющейся иногда вследствие недостаточности кровообращения головного мозга.

Права и обязанности пациента



Имеет право:

- ▶ На уважительное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала
- ▶ Выбор врача, больницы, в соответствии с договорами медицинского страхования
- ▶ Проведение по его просьбе консультаций других специалистов
- ▶ Облегчение боли
- ▶ Сохранение медицинской тайны
- ▶ Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
- ▶ Отказ от медицинского вмешательства
- ▶ Возмещение ущерба, в случае причинения вреда здоровью
- ▶ Допуск адвоката, священнослужителя и др. представителей защиты прав

Обязан:

- ▶ своевременно обращаться за медицинской помощью
- ▶ уважительно относиться к медработникам
- ▶ представлять достоверную информацию о здоровье
- ▶ выполнять медицинские предписания
- ▶ соблюдать правила внутреннего распорядка

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Внутригоспитальная транспортировка пациентов

Транспортировка пациента в отделение



Способ доставки в отделение определяет **врач** в зависимости от состояния пациента:

- ▶ на носилках (вручную или на каталке)
- ▶ на кресле-каталке
- ▶ на руках
- ▶ ПЕШКОМ

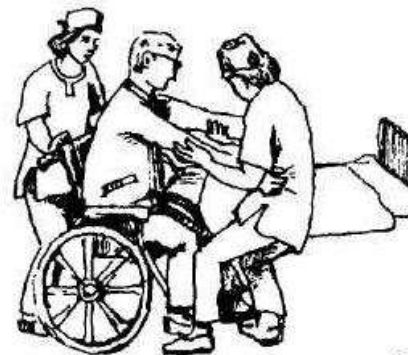
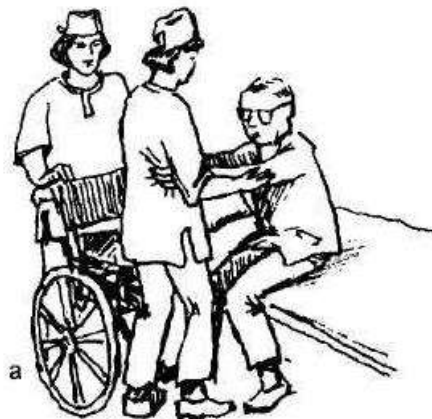


Кресло-каталка



Проводится одним медицинским работником.

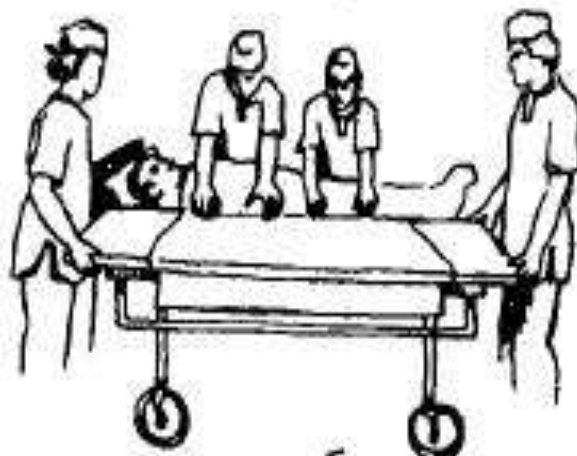
1. Проверить исправность кресла-каталки, подготовить его к работе.
2. Наклонить кресло-каталку вперед, наступив на подставку для ног.
3. Попросить пациента встать на эту подставку и усадить его в кресло, поддерживая под спину.
4. Привести кресло-каталку в исходное положение.
5. Придать пациенту необходимое положение (сидя либо полулежа) с помощью рамки, располагающейся за спинкой кресла.
6. Накрыть пациента одеялом или простыней.
7. Контролировать положение рук пациента — чтобы они не выходили за пределы подлокотников во время транспортировки.
8. По прибытии к месту назначения помочь пациенту пересесть на кровать в палате.



Каталка, носилки



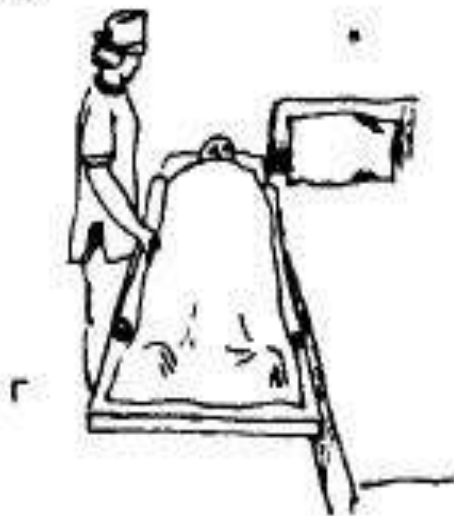
а



б



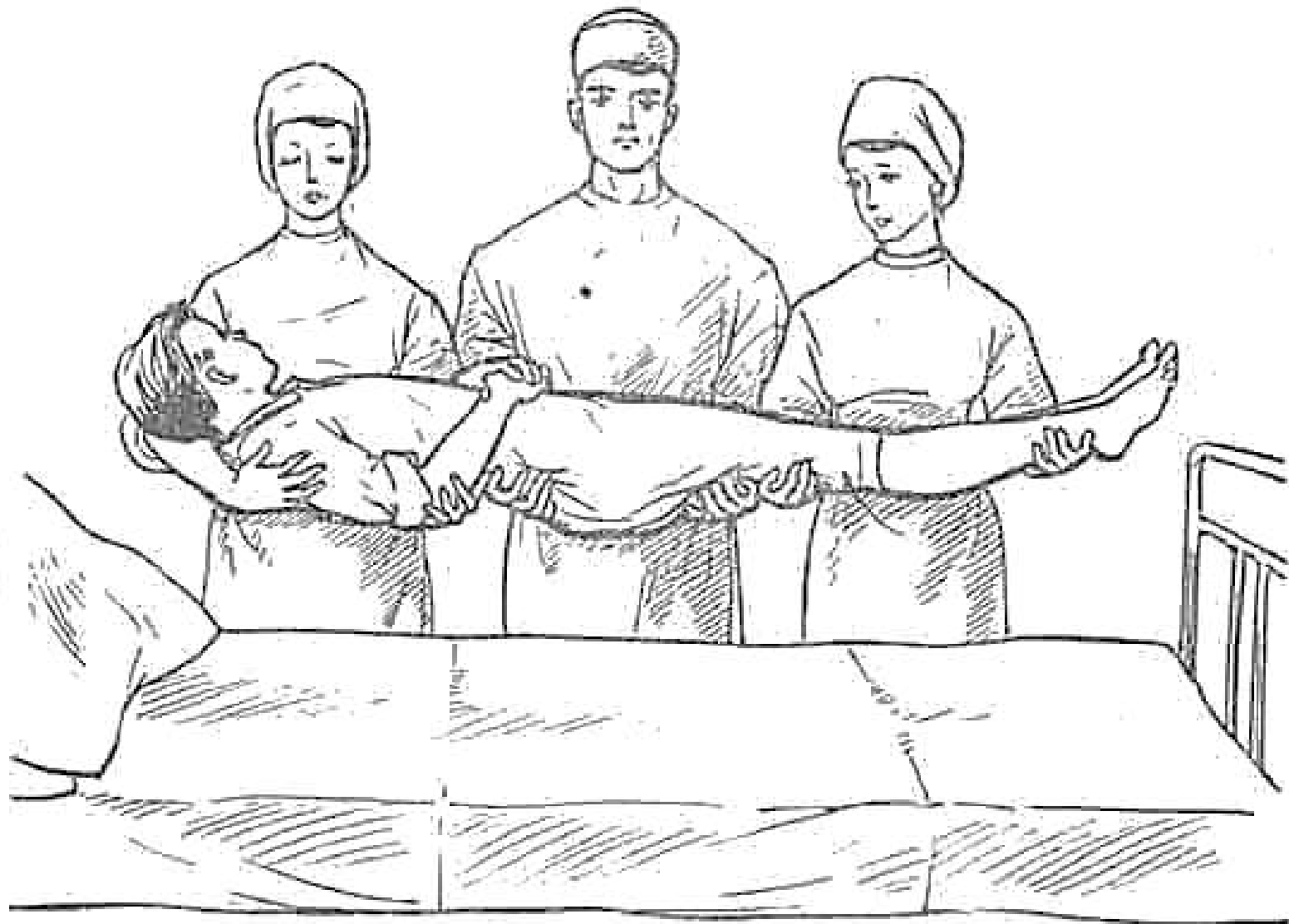
в



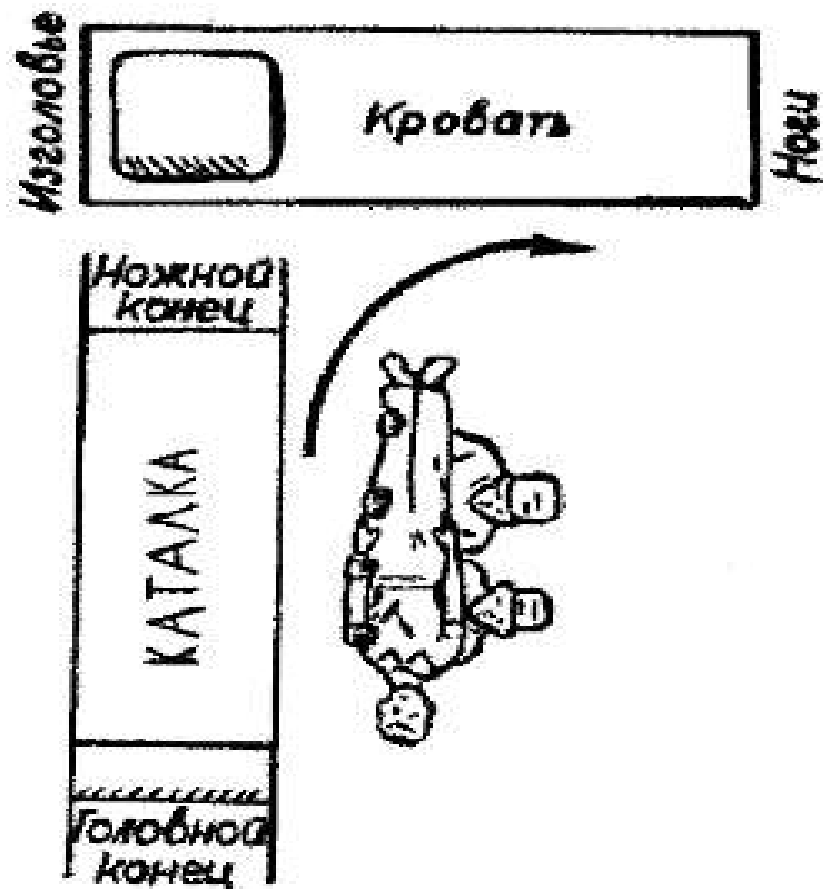
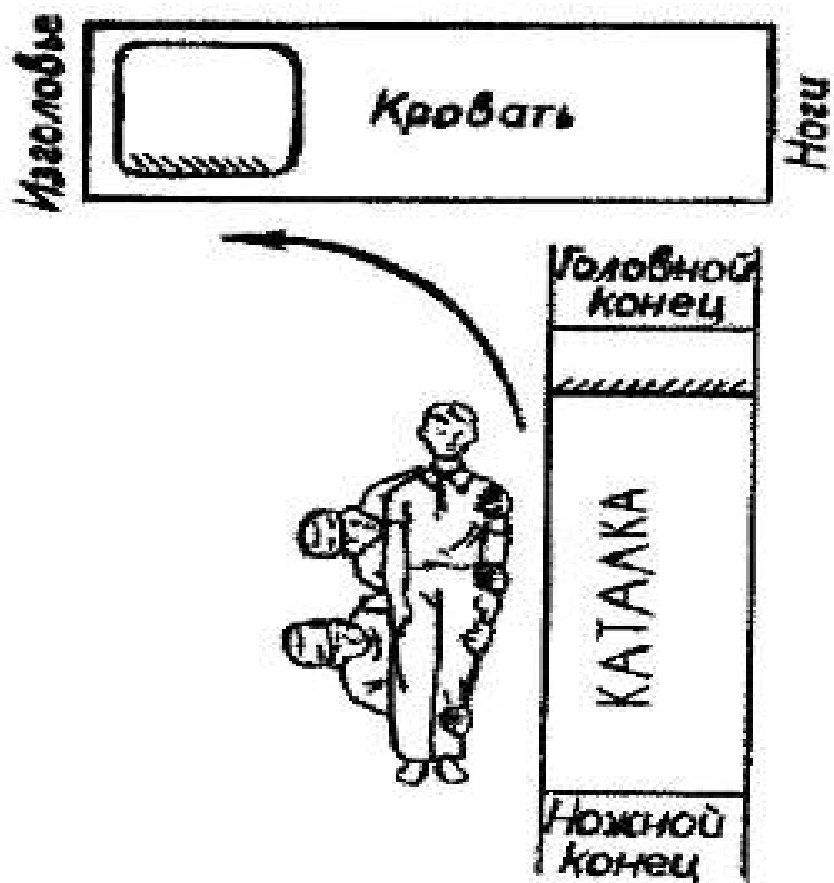
г

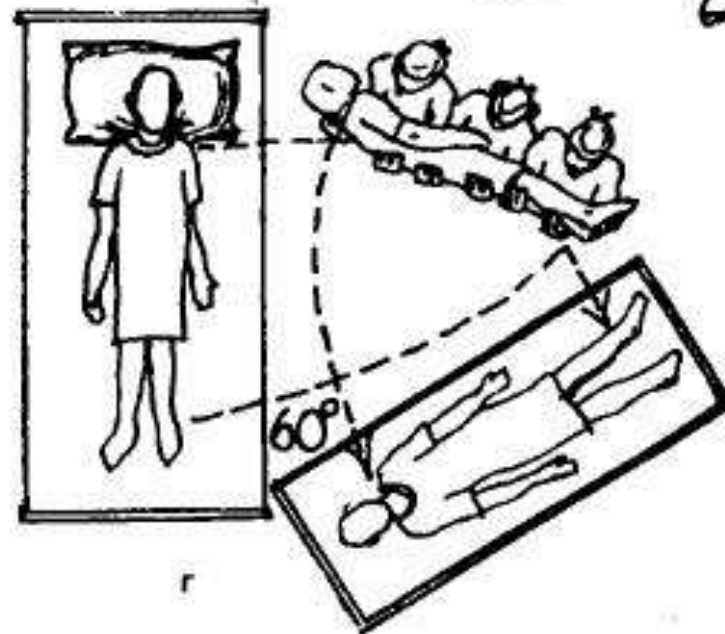


д



Перекладывание на кровать





r



Общие вопросы организации лечебных отделений

Устройство и оборудование соматического отделения



Общие

Коридор
Холл
Смотровой кабинет
Пост дежурной медицинской сестры

Палатная секция

Палата на 1 койку
Палата на 2 койки и более
Палата совместного круглосуточного (дневного) пребывания детей с матерями
Полубокс
Бокс

Помещения для матерей (в отделениях педиатрического профиля)

Комната отдыха – столовая
Помещение для сцеживания грудного молока
Помещение для мойки и стерилизации посуды, пастеризации и хранения грудного молока



Устройство и оборудование соматического отделения



Санузел

Совмещенный (унитаз, умывальник, душ)

Раздельный: уборная (унитаз, умывальник) и душевая для пациентов

Раздельный: уборная (унитаз, умывальник) и душевая для медицинских работников

Умывальная

Комната личной гигиены для больных

Санитарные комнаты

Горшечная

Для мытья и дезинфекции суден, горшков

Для мытья и сушки клеенок

Для сортировки и временного хранения грязного белья

Для хранения предметов уборки помещений (с трапом, краном и сушкой) и хранения дезсредств

Для сбора и хранения материала для анализов

Кладовые

Для хранения мягкого инвентаря

Для временного хранения списанного инвентаря

Для хранения каталок

Для хранения переносной физиотерапевтической и рентгеновской аппаратуры

Для хранения переносной аппаратуры



Устройство и оборудование соматического отделения



Служебные помещения для медицинского персонала	Кабинет заведующего отделением
	Кабинет врача (ординаторская)
	Кабинет старшей медицинской сестры с местом для хранения медикаментов
	Кабинет сестры-хозяйки с помещением для временного хранения чистого белья
	Сестринская
Лечебно- диагностические	Комната младшего медицинского персонала
	Процедурная
	Клизменная
	Перевязочная
	Физиотерапии
Столовая	Столовая
	Буфетная с моечной
Для осуществления образовательного процесса	Комната игр для детей в возрасте от 1 года до 7 лет
	Классное помещение (для пациентов педиатрического профиля)
	Учебная комната (в отделениях клинического профиля)



Специализированные кабинеты по профилям отделений



Хирургические	Перевязочный кабинет Перевязочный кабинет для гнойных ран Малая операционная с предоперационной и шлюзом
Травматологическое	Гипсовая перевязочная с помещением для хранения гипса и гипсовых бинтов
Офтальмологии	Перевязочный кабинет (манипуляционная)
Пульмонологии, педиатрии	Кабинет ингаляционной терапии
Аллергологические	Кабинет проведения аллергопроб Кабинет ингаляционной терапии
Акушерско- гинекологического профиля	Смотровой кабинет с креслом Рахманова
Гастроэнтерологии	Кабинет гастроскопии Кабинет ректороманоскопии и колоноскопии
Психиатрии	Аминазиновая (с вытяжным шкафом) Кабинет индивидуальной психотерапии Кабинет групповой психотерапии со шлюзом Помещения трудотерапии

Неинфекционные палатные отделения



По профилю:

1. **терапевтические (педиатрические)** — общетерапевтические, общепедиатрические, ревматологические, кардиологические, гастроэнтерологические, гематологические, пульмонологические, эндокринологические и др.;
2. **хирургические** — общехирургические (чистые, гнойные), травматологические, ортопедические, урологические, нейрохирургические, ожоговые, колопроктологические и др.;
3. **специализированные** — неврологические, оториноларингологические, офтальмологические, психиатрические, наркологические, дерматовенерологические, онкологические и др.;
4. **узкоспециализированные** — микрохирургические, торакальной хирургии, сосудистой хирургии, портальной гипертензии и др.

По стадиям лечебно-диагностического процесса:



1. отделения общего режима;
2. отделения интенсивного лечения;
3. отделения долечивания;
4. отделения восстановительного лечения;
5. отделения медико-социальной помощи.

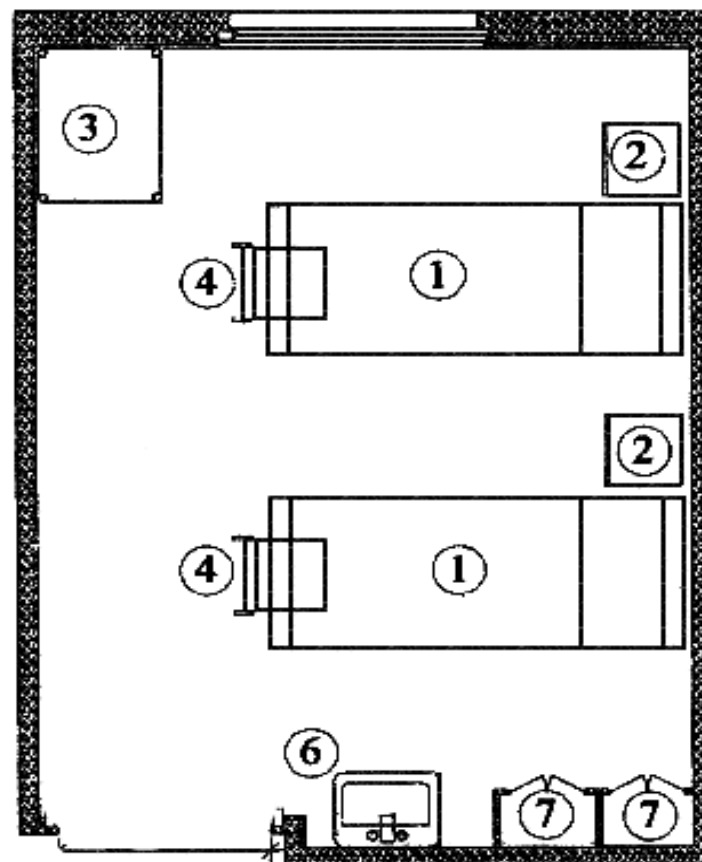
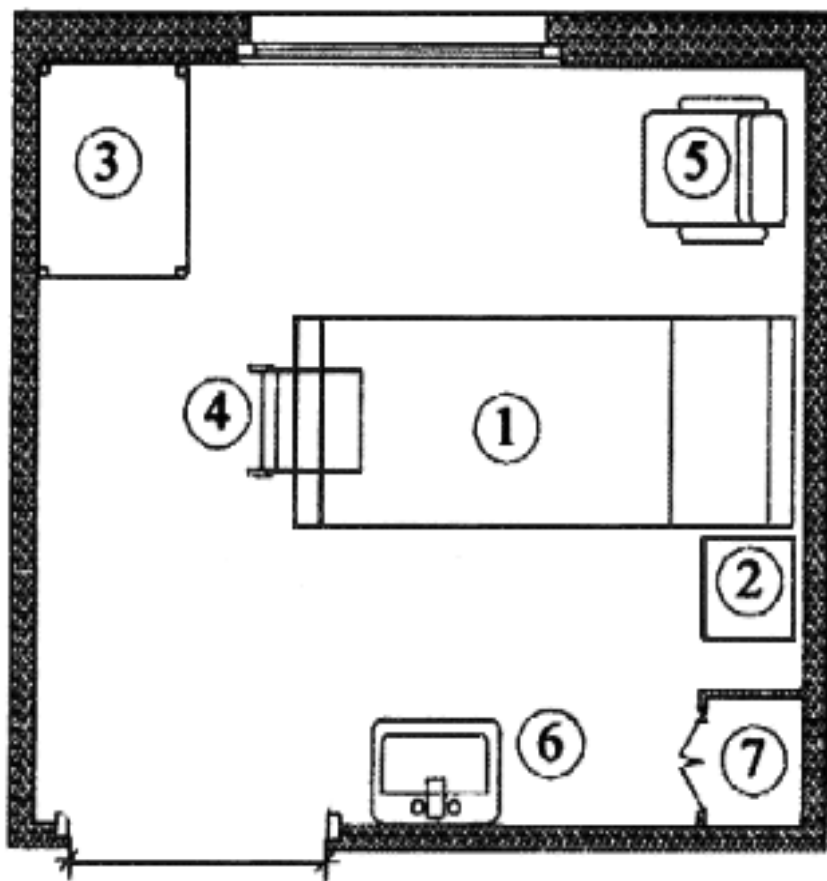


Требования к устройству палат



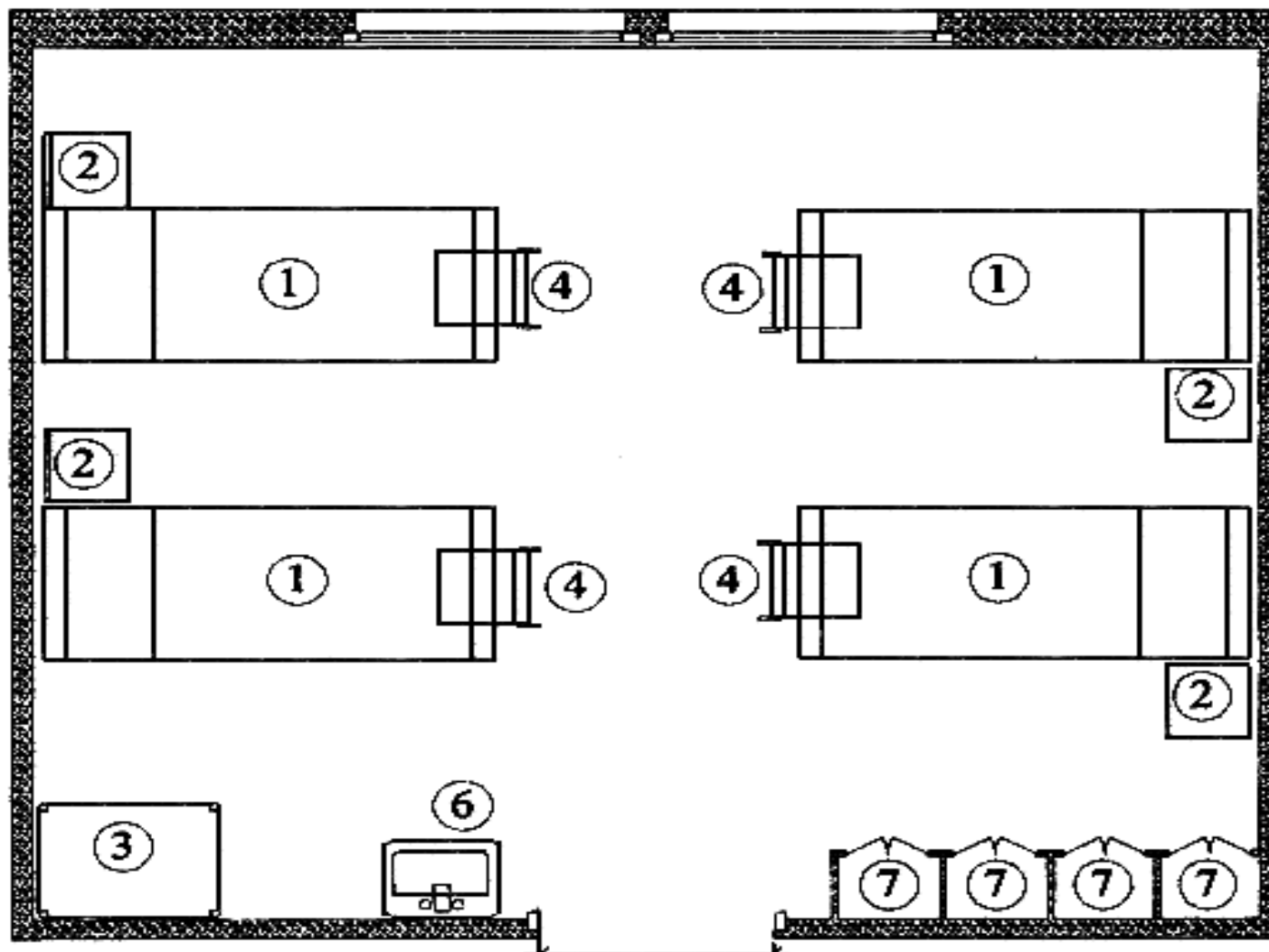
- ▶ Размеры и площадь палат (кроме палат радиологических отделений) определяются, исходя из следующих условий:
- 1. Койки в палатах размещаются рядами параллельно стенам с окнами;
- 2. Допускается размещение коек для матерей в палатах совместного пребывания детей с матерями вдоль стен;
- 3. Расстояния от коек до стен с окнами не менее 0,9 м;
- 4. Расстояния от коек до стен (или оборудования у стен), противоположных стенам с окнами, не менее 0,8 м;
- 5. Глубина палат при естественном освещении с одной стороны не более 6 м;
- 6. Отношение глубины к ширине палат не более 2;
- 7. Высота палат от пола до потолка не менее 3 м.

Палаты: одноместные, двухместные



1 – кровать, 2 – прикроватный стол, 3 – шкаф для вещей (верхней одежды),
4 – табурет, 5 – кресло, 6 – раковина с умывальником, 7 – прикроватная тумбочка

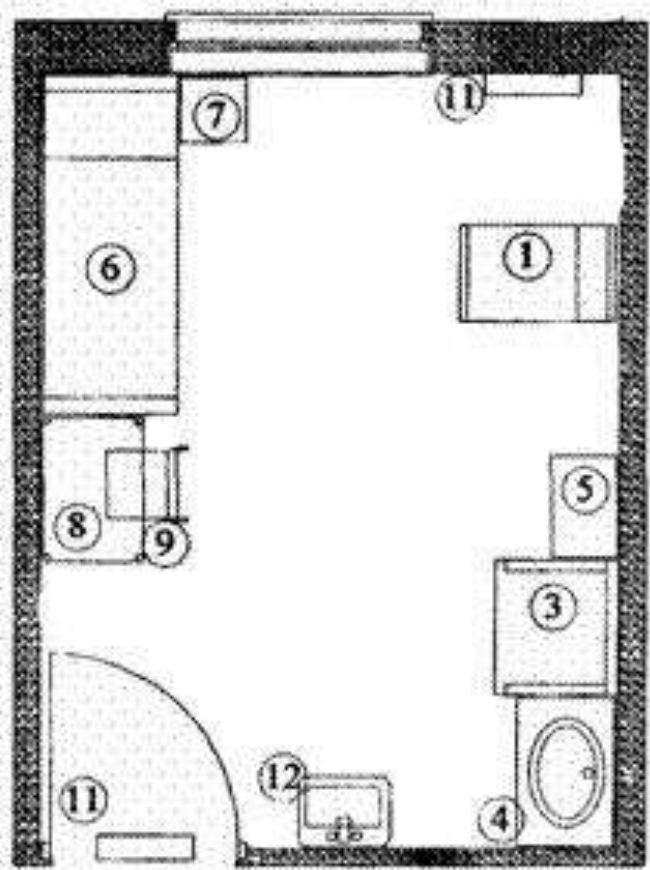
Палаты: четырехместные



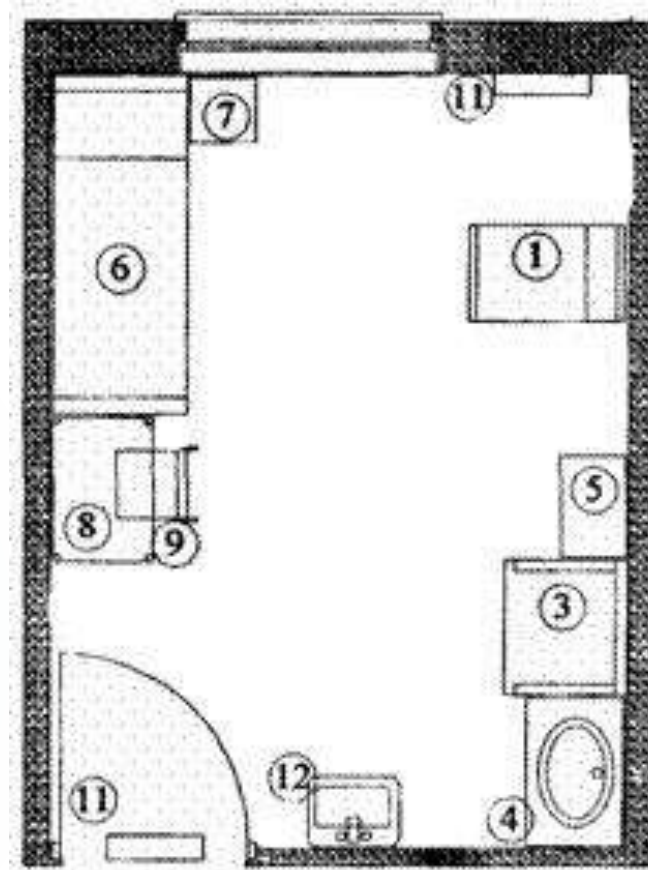
- 1 – кровать,
- 2 – прикроватный стол,
- 3 – шкаф для вещей (верхней одежды),
- 4 – табурет,
- 5 – кресло,
- 6 – раковина с умывальником,
- 7 – прикроватная тумбочка



Палаты педиатрического профиля



Палата совместного пребывания детей до 1 года с матерями



Палата совместного пребывания детей 1 – 7 лет с матерями

- 1 – кроватка для детей до 1 года с барьерами,
- 2 – кровать для детей старшего возраста,
- 3 – пеленальный стол,
- 4 – ванна для купания детей до 1 года,
- 5 – тумбочка,
- 6 – кровать для матери,
- 7 – прикроватный столик,
- 8 – стол;
- 9 – стул;
- 10 – кресло,
- 11 – выход,
- 12 – раковина

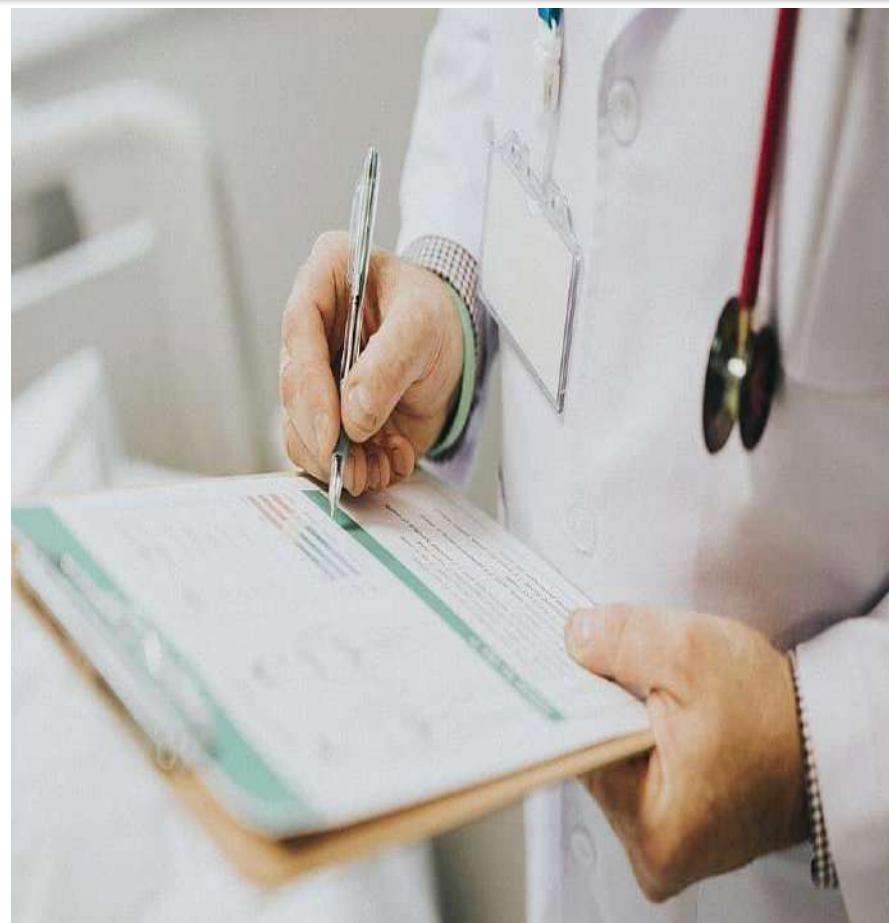


Лечебно-охранительный режим

Распорядок дня пациента



7.00-7.30	термометрия, подъем
7.30-8.00	утренний туалет
8.00-8.30	передача дежурства
8.30-9.00	прием лекарственных средств
9.00 -9.30	завтрак
9.30-10.00	обход врача
10.00-11.00	выполнение назначений
11.00-13.00	прием лекарственных средств
13.00-13.30	обед
13.30-16.50	отдых
16.50-17.30	термометрия
17.30-19.00	посещение больных родственниками
19.00-19.30	прием лекарственных средств
19.30-20.00	ужин
20.00-20.30	выполнение врачебных назначений
20.30-22.00	вечерний туалет
22.00-7.00	ночной сон



Правила внутреннего распорядка



- ▶ Правила внутреннего распорядка состоят в соблюдении установленного в отделении режима дня, который обеспечит пациентам своевременное питание, выполнение гигиенических и лечебно-диагностических мероприятий, полноценный отдых, а также способствует поддержанию соответствующего санитарного состояния в палатах.



- ▶ **Правила внутреннего распорядка включают:**
 - ▶ правила посещения пациентов в отделениях;
 - ▶ правила приема передач и хранения продуктов в отделениях;
 - ▶ правила пребывания в учреждении пациентов и родственников, осуществляющих за ними уход;
 - ▶ распорядок дня



Правила посещения пациентов в лечебном отделении



- ▶ посещения больных должно происходить в строго определенное время, указанное в режиме отделения;
- ▶ посетители должны иметь сменную обувь и медицинский халат;
- ▶ посетители не должны утомлять пациентов длительными разговорами, садиться на кровать, целовать их, сообщать неприятные новости;
- ▶ медсестра должна проверить передаваемые продукты: они должны соответствовать диете пациента, находиться в упаковке с указанием срока годности и в целлофановом пакете.



Правила приема передач и хранение продуктов



1. Палатная медсестра ежедневно проверяет санитарное состояние тумбочек и их содержимое. В тумбочке разрешают также хранить предметы туалета, журналы, конфеты печенье, варенье.
2. Фрукты и скоропортящиеся продукты хранят в холодильнике.
3. Свежие молочные продукты хранят в холодильнике в фабричной упаковке не более 1 суток, кисломолочные продукты хранят не более 2 суток. Нельзя хранить в холодильнике мясные и рыбные консервы, открытые банки с неиспользованными кисломолочными продуктами.
4. Продукты хранят в индивидуальном пакете с указанием Ф.И.О. пациента и номера палаты.
5. Холодильник размораживают и моют 1 раз в неделю (по графику).
6. Влажное протирание тумбочек дезинфицирующим раствором проводят ежедневно.



Правила пребывания в учреждении пациентов и родственников, осуществляющих за ними уход



- ▶ неукоснительно выполнять назначения лечащего врача, рекомендации и просьбы медицинского персонала;
- ▶ соблюдать правила приема передач и хранения продуктов в отделениях и распорядок дня в отделениях»;
- ▶ соблюдать чистоту и порядок в палате, коридорах, туалетах;
- ▶ бережно относиться к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба любому виду имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) родители или родственники пациента обязаны возместить все убытки.





Особенности устройства инфекционного отделения

Инфекционные отделения



- ▶ Основное структурное подразделение инфекционной больницы, а также инфекционного корпуса многопрофильной больницы.
- ▶ Могут быть общего профиля (для больных с различными инфекциями) или специализированными по определенному виду инфекций.
- ▶ Инфекционные отделения различаются **по способам выделения** возбудителя инфекционного заболевания во внешнюю среду и путям передачи (отделения кишечных инфекций, отделения воздушно-капельных инфекций, отделение гемоконтактных инфекций и т.д.), а также **по отдельным видам заболеваний** (отделения для больных менингококковой инфекцией, вирусным гепатитом, туберкулезом и т.д.).
- ▶ Отделения инфекционных больниц (корпусов) могут состоять из боксов, полубоксов (боксовые отделения) и боксированных палат (палатное отделение).
- ▶ Боксы дают возможность полной изоляции больных и предусматривают нахождение в них 1 или 2 больных с одним видом заболевания.

Вариант с 1 входом в отделение

Вход для персонала ч/з чистую зону

Сан. пропускник во входной группе в стационар
(надевание СИЗ)

Палата

Палата

Палата

Палата

Палата

Помещение
для персонала

Душ

Комнат
а
снятия
СИЗ

Надева
ние
СИЗ

Палата

Грязн
ая
зона

В отделении организована чистая зона для персонала

Сан. пропускник Чистая зона Грязная зона

Вариант с 2 входами в отделение

Вход для персонала ч/з чистую зону

Сан. пропускник во входной группе в стационар
(надевание СИЗ)

Душ

Комната
снятия СИЗ

Палата

Палата

Палата

Чистая
зона
(надевание
СИЗ)

Помещение
для
персонала

Палата

Палата

Палата

Палата

Грязн
ая
зона

Вход для пациентов ч/з грязную зону

Вентиляция инфекционного отделения



1 — Канальные обеззараживатели-очистители в вытяжной канал вентиляции. Для обеспечения безопасности людей в здании и за его пределами, воздух удаляемый из инфекционных палат и боксов, а также помещений биолaborаторий, работающих с патогенными микроорганизмами, должен подвергаться фильтрации и инактивации (полному уничтожению).

2 — Канальные обеззараживатели-очистители напольно-подвесные. Приточный воздух подается через систему вентиляции с обеззараживанием и очисткой на фильтрах.

3 — Обеззараживатель-очиститель воздуха внутри помещения.



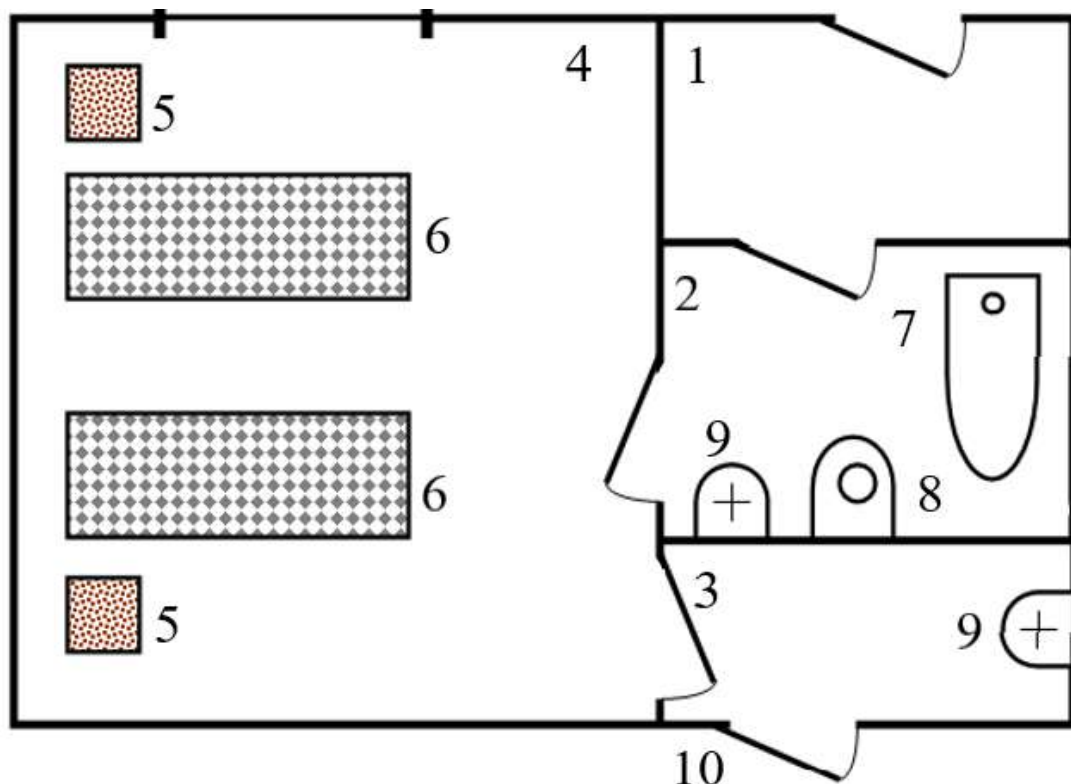
Вентиляция инфекционного отделения



- 1 — Ламинарные ячейки. Для защиты от заражения из воздуха критических операций, таких как розлив и укупорка, применяют устройства с однонаправленным потоком воздуха. Ламинарный потолок или ячейка встраивается в приточный канал вентиляции непосредственно в потолок над рабочей зоной и обеспечивается непрерывная подача очищенного и стерильного однонаправленного потока воздуха.
- 2 — Канальные обеззараживатели-очистители напольно-подвесные. В помещения ассистентской, дефектарской, заготовочной и фасовочной, закаточной и контрольно-маркировочной, стерилизационной-автоклавной и дистилляционной приточный воздух подается через систему вентиляции с обеззараживанием и очисткой на фильтрах.
- 3 — Обеззараживатель-очиститель воздуха внутри помещения.
- 4 — Компактная приточная вентиляции с очисткой воздуха, для обеспечения кратности воздухообмена и норм чистоты воздуха.

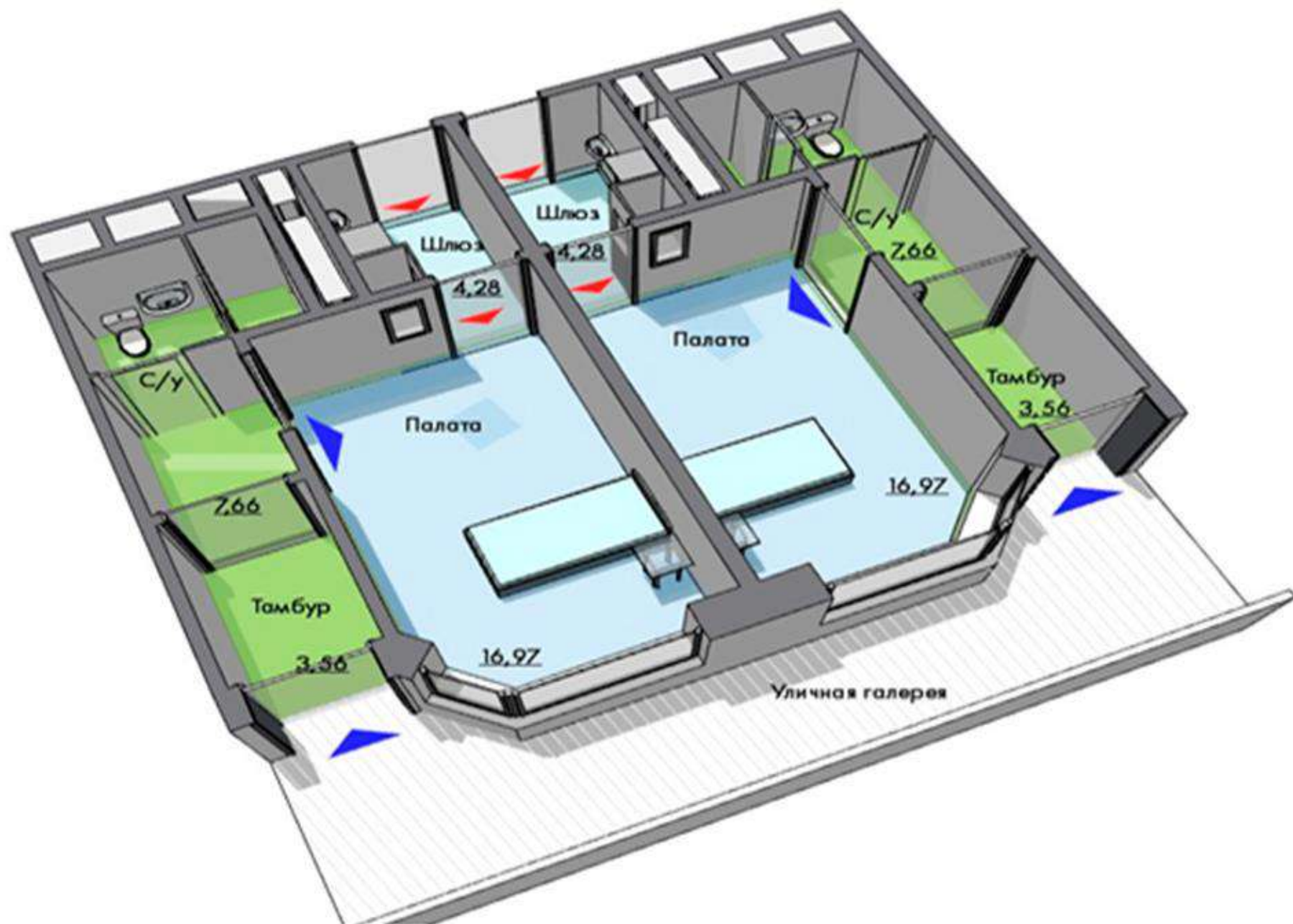


Бокс

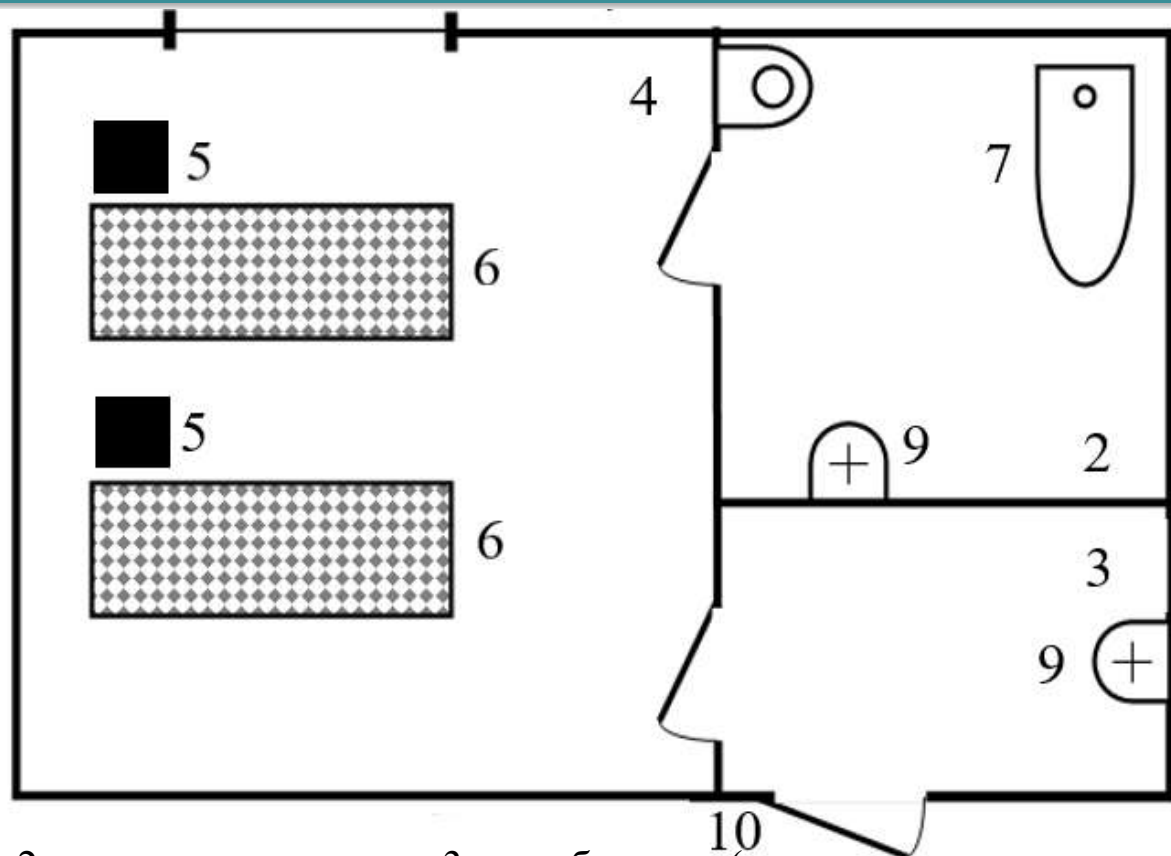


1. шлюз (для входа пациента через улицу), 2. санитарная комната, 3. предбоксник (для входа медицинского персонала из отделения), 4. бокс (палата), 5. прикроватная тумбочка, 6. кровать, 7. ванна, 8. унитаз, 9. раковина, 10. коридор отделения

- Больной поступает в бокс с уличной галереи и не выходит из него до выписки.
- На исследования, а также в различные лечебные кабинеты пациента транспортируют через наружный выход бокса.
- Вход персонала в боксы предусматривается из больничного коридора через шлюз, где персонал надевает специальную одежду и производит санитарную обработку и дезинфекцию рук.
- После окончания курса лечения больной покидает бокс также через наружный выход с тамбуром.



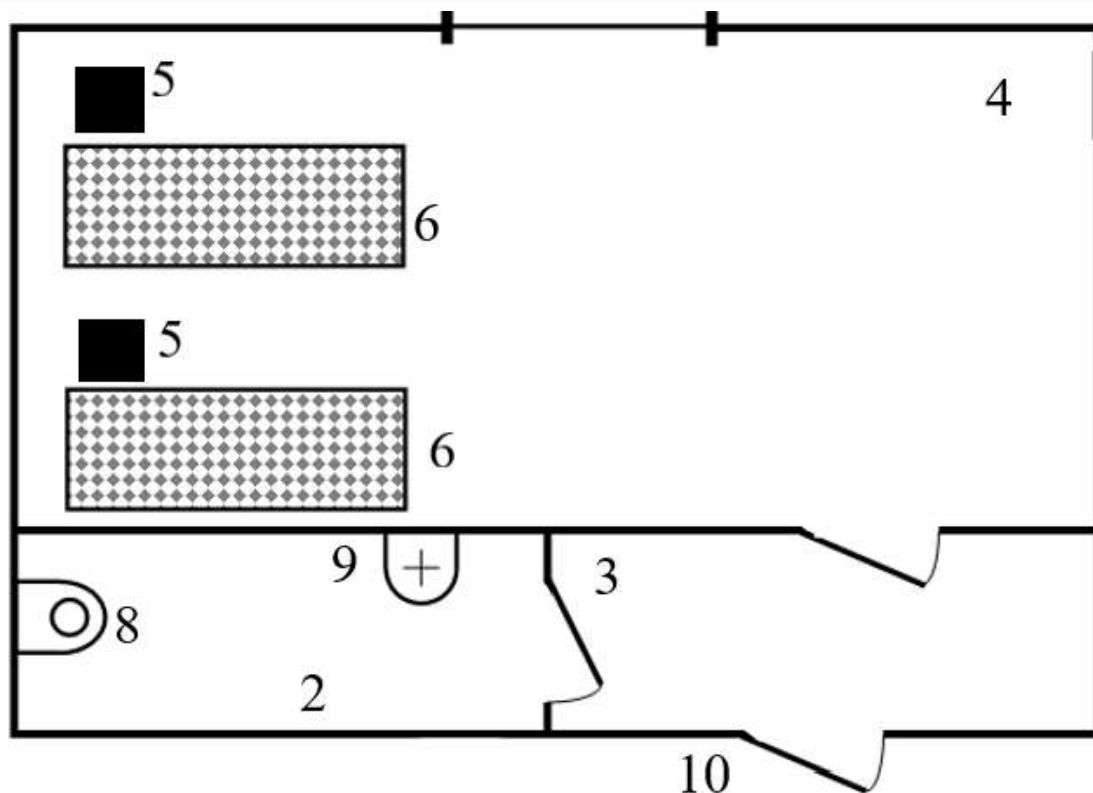
Полубокс



2. санитарная комната, 3. предбоксник (для входа медицинского персонала из отделения), 4. бокс (палата), 5. прикроватная тумбочка, 6. кровать, 7. ванна, 8. унитаз, 9. раковина, 10. коридор отделения

- Полубоксы предусматриваются на 1 или 2 койки и отличаются от боксов тем, что не имеют наружного выхода.
- Прежде чем поступить в полубоксы, больные проходят санитарную обработку в санпропускнике, после чего по коридору палатной секции через шлюз поступают в полубоксы.
- В полубоксах предусматривается частичное остекление дверей между шлюзом и палатой.

Боксированная палата



2. санитарная комната, 3. предбоксник (для входа медицинского персонала из отделения), 4. бокс (палата), 5. прикроватная тумбочка, 6. кровать, 8. унитаз, 9. раковина, 10. коридор отделения

- Боксированная палата отличается от бокса отсутствием ванны в санузле и менее жесткими требованиями к организации входа со стороны коридора.
- В шлюзе боксированной палаты допускается размещение дверей друг против друга.
- Санитарный узел боксированной палаты состоит из унитаза, умывальника и душа.
- От обычной палаты боксированная палата отличается со шлюзом и санузлом наличием передаточного шкафа.



Организация деятельности среднего и младшего медицинского персонала

Перечень персонала отделения



▶ Младший медицинский персонал:

- ▶ Сестра-хозяйка
- ▶ Санитарка
- ▶ Буфетчица
- ▶ Младшая медицинская сестра

▶ Средний медицинский персонал:

- ▶ Старшая медицинская сестра
- ▶ Палатная медицинская сестра
- ▶ Процедурная медицинская сестра
- ▶ Постовая медицинская сестра

▶ Врачебный персонал:

- ▶ Заведующий отделением
- ▶ Врачи-ординаторы
- ▶ Врачи-консультанты

Главный врач МО

**Заместители
главного врача МО
по медицинской
помощи**

**Главная
медицинская
сестра МО**

Основные должностные обязанности младшего медицинского персонала



▶ Санитарка:

- ▶ Мытье закрепленных помещений отделения (текущая, генеральная уборки)
- ▶ Помощь младшей или палатной медицинской сестре в уходе за больными
- ▶ Помощь в транспортировке больных

▶ Буфетчица:

- ▶ Получение и раздача рационов питания
- ▶ Мытье и дезинфекция посуды

▶ Сестра-хозяйка:

- ▶ Смена постельных принадлежностей
- ▶ Получение и сдача белья в прачечную
- ▶ Контроль за работой санитарок
- ▶ Получение, хранение, выдача дезинфекционных средств для уборки

Должностные обязанности палатной медицинской сестры



- ▶ Приём больных в отделении
- ▶ Осуществление ухода за больными (осуществляет или оказывает помощь ослабленным больным в умывании, кормлении и др.). Контроль санитарного содержания палат
- ▶ Контроль выполнения соблюдения правил личной гигиены больными, смены постельного и нательного белья, профилактика пролежней и др.
- ▶ Контроль снабжения больных предметами личной гигиены
- ▶ Регистрация и выполнение назначений врача (в т.ч. по уходу)
- ▶ Отчет на утренней конференции и доклад непосредственно врачу о каждом больном (в т.ч. при изменении его состояния)
- ▶ Плановая термометрия, подсчет пульса, АД, измерение суточного диуреза
- ▶ Заполнение температурного листа
- ▶ Сбор материалов для исследования (моча, кал, мокрота)

Должностные обязанности постовой медицинской сестры



- ▶ Контроль за состоянием больных
- ▶ Контроль и выполнение назначений врача
- ▶ Контроль за лекарственными средствами на посту
- ▶ Выдача лекарственных средств
- ▶ Выполнение инъекций
- ▶ Распределение больных на исследования и процедуры
- ▶ Контроль за персоналом и пациентами отделения



Организация поста медицинской сестры



Оборудование поста



- ▶ Стул;
- ▶ Компьютер и принтер;
- ▶ Телефон;
- ▶ Номера телефонов экстренных служб;
- ▶ Настольная лампа;
- ▶ Канцелярские принадлежности;
- ▶ Раковина;
- ▶ Дозатор локтевой для мыла и для антисептика;
- ▶ Диспенсер для бумажных (одноразовых) полотенец;
- ▶ Отдельные шкафы для хранения медицинской документации, изделий медицинского назначения, для хранения лекарственных средств, закрывающийся на ключ, для хранения постельного белья (на сутки);
- ▶ Холодильник для лекарственных препаратов;
- ▶ Холодильник для продуктов питания больных;
- ▶ Передвижной столик для раздачи лекарственных средств;
- ▶ Емкости для дезинфекции изделий медицинского назначения;
- ▶ Информационная доска с правилами распорядка дня;
- ▶ План эвакуации при пожаре;
- ▶ Фонарь – 2 шт.;
- ▶ Аварийно-спасательные средства – по числу медицинских работников;
- ▶ Контейнер для отходов классов «А», «Б»;
- ▶ Укладка для проведения демеркуризации;
- ▶ Укладка для проведения противопедикулезных мероприятий;
- ▶ Укладка для экстренной профилактики парентеральных инфекций.



Медицинское оборудование поста



- ▶ Механический или полуавтоматический тонометр (1-2 в зависимости от коечного фонда и профиля отделения);
- ▶ Фонендоскоп;
- ▶ Термометры (ртутные максимальные по числу коек с запасом в 10%, электронные, инфракрасные, бесконтактные);
- ▶ Пульсоксиметр;
- ▶ Мешок АМБУ;
- ▶ Весы для измерения массы тела;
- ▶ Ростомер;
- ▶ Ингаляторы;
- ▶ Термометры для измерения температуры в холодильнике – 2 шт.;
- ▶ Артериальный жгут;
- ▶ Желудочный зонд, шприц Жанэ;
- ▶ Кружка Эсмарха, резиновая груша;
- ▶ Газоотводная трубка;



Документация медицинского поста



- ▶ Алгоритмы, стандартные операционные процедуры (СОП) выполнения медицинских манипуляций;
- ▶ Алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; номера телефонов ответственных лиц; номера телефонов дежурных служб;
- ▶ Листы врачебных назначений;
- ▶ Журнал назначений пациентам;
- ▶ Журнал приема и сдачи дежурств постовыми (палатными) медицинскими сестрами;
- ▶ Журнал температурного режима холодильника, разморозки и дезинфекции холодильника;
- ▶ Журнал учета движения пациентов;
- ▶ Журнал наблюдения за пациентами;
- ▶ Журнал учета вызовов врачей-консультантов для оказания экстренной и плановой медицинской помощи;
- ▶ Журнал записи на инструментальные исследования (ЭКГ, Рентген, УЗИ, МРТ, МСКТ и т.д.);
- ▶ Журнал записи на лабораторные исследования;
- ▶ Журнал учета нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (производственного травматизма);
- ▶ Журнал учета инфекционных больных;
- ▶ Чистые бланки направлений для лабораторных исследований, листы назначений, температурные листы.



Обязательная медицинская документация медицинской сестры



- ▶ листок учета коечного фонда
- ▶ журнал учета лекарственных средств списка А и Б, дорогостоящих и остродефицитных препаратов
- ▶ журнал назначений и передачи дежурств
- ▶ температурный журнал
- ▶ журнал учета температурающих больных
- ▶ журнал учета аварийных ситуаций (уколы и др. травмы медицинскими инструментами и т.п.)
- ▶ инструкции и др. распорядительные документы



Примерный распорядок работы медицинской сестры



- Медицинская сестра будит больных, включает свет в палатах и отделении, проводит термометрию
- Оформление медицинской документации – листа учёта больных (сводки движения больных), требования на питание больных (порционника), журнала назначений постовой медицинской сестры (инструментальные и лабораторные исследования, консультации специалистов и пр.)
- Мероприятия по уходу за больными, проветривание палат, направление биологического материала больных на анализы
- Конференция («планёрка», «пятиминутка») заведующего отделением и старшей медицинской сестры с врачами и медицинскими сестрами
- Сдача медицинской сестрой дежурства дневной смене
- Выполнение врачебных назначений (раздача лекарств, инъекции и пр.)
- Раздача завтрака вместе с младшим медицинским персоналом, кормление тяжелобольных

Продолжение...



- Участие во врачебном обходе (по возможности)
- Выполнение врачебных назначений (подготовка и сопровождение больных для лечебно-диагностических процедур, уход за тяжелобольными и др.
- Выполнение врачебных назначений (раздача лекарств, инъекции и пр.)
- Раздача обеда вместе с младшим медицинским звеном, кормление тяжелобольных
- «Тихий час» у больных; контроль за состоянием тяжелобольных и соблюдением лечебно-охранительного режима в отделении
- Передача медицинской сестрой поста ночной смене
- Термометрия, проветривание палат
- Посещение больных родственниками; контроль за посещением больных родственниками и соответствием приносимых ими продуктов лечебному режиму отделения
- Выполнение врачебных назначений (раздача лекарств, инъекции и пр.)
- Раздача ужина вместе с младшим медицинским персоналом, кормление тяжелобольных
- Выполнение врачебных назначений (раздача лекарств, инъекции и пр.)
- Мероприятия по уходу за больными (вечерний туалет у тяжелобольных, смена постели, обработка полости рта и пр.)
- Обход отделения, контроль за состоянием больных, при необходимости – оказание экстренной доврачебной помощи и вызов дежурного врача

Постовая медсестра



- ▶ Проверяет по историям болезней текущие медицинские назначения, сделанные врачами. Новые назначения вносятся ею на «доску назначений» взамен отмененных.

По «доске назначений», представляющей собой сетку, в которой соответственно фамилиям больных выписаны назначенные им медицинские и гигиенические мероприятия, сестры выполняют все необходимые процедуры — выдача лекарств, инъекции, сеансы физиотерапевтического лечения, лечебной гимнастики и проч.

Постовая медицинская сестра выписывает из истории болезни на текущий день рецепты лекарств и диеты

- ▶ На основании этих рецептов и списка рационов старшая медицинская сестра делает заявку в аптеку и на центральную кухню больницы.

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Приём и сдача дежурств

Порядок приема / сдачи дежурств



- ▶ Прием и сдача медицинской сестрой поста – один из важнейших аспектов её работы.
- ▶ **В случае неявки следующей смены медицинская сестра не имеет права покидать пост.**

Порядок приема и сдачи дежурства:

- ▶ Обход палат
- ▶ Передача срочных и невыполненных назначений
- ▶ Передача лекарственных препаратов медицинских инструментов и предметов по уходу, ключей от сейфа с лекарственными препаратами
- ▶ Передача медицинской документации поста



Обход палат: знакомство со вновь поступившими больными, оценка состояния тяжелобольных (сдающая дежурство медицинская сестра должна сообщить заступающей на смену медицинской сестре об изменениях в состоянии пациентов), проверка санитарного состояния помещений терапевтического отделения.



Передача срочных и невыполненных назначений: сдающая дежурство медицинская сестра должна сообщить заступающей на смену об объёме врачебных назначений - что было выполнено, какие назначения предстоит выполнить.



Передача медицинской документации поста. Обе медицинские сестры подписываются в журнале приёма и сдачи дежурств.

Журнал приема и сдачи дежурств



Дата дежурства _____

Дежурная смена, состав (медсестры, мл.мед.персонал, ФИО): _____

Состояло	Поступило	Переведены		Выпи- саны	Состо- -ит	Свобод- ные места	Пала- ты
		из др. отд.	в др. отд.				

Поступило: _____

Выбыло: _____

Пациенты под наблюдением: _____

Лихорадящие пациенты: _____

Назначения (диагностические исследования, оперативные вмешательства, консультации): _____

Смену сдал (а): _____

Смену принял (а): _____

Старшая медсестра: _____

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Медицинская документация

Журнал учета движения больных



№ п/п	Поступлен ие		Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Постоянное место жительства или адрес родственников и № телефона	Каким учреждением бь направлен или доставлен
	дата	час				
1	2	3	4	5	6	7

№ карты стационарн ого больного (истории родов)	Диагноз направившего учреждения	Выписан, переведен в другой стационар, умер (вписать и указать дату и название стационара, куда переведен)	Отметка о сообщении родственникам ил учреждению
8	9	10	11

Согласия на обследования, лечение, операции, сбор персональных данных – заполняются лечащим врачом и подписываются больным при поступлении



Приложение № 2 к приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1177н –
Бланк (форма) добровольного согласия на медицинское вмешательство

Приложение № 2 к приказу Минздрава РФ
от 20.12.2012 № 1177н
Бланк (форма)

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи

Я, _____
(Ф.И.О. гражданина)

« ____ » _____ г. рождения, зарегистрированный по адресу:

_____ (адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

в _____
(полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником _____
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446).

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

_____ (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. медицинского работника)

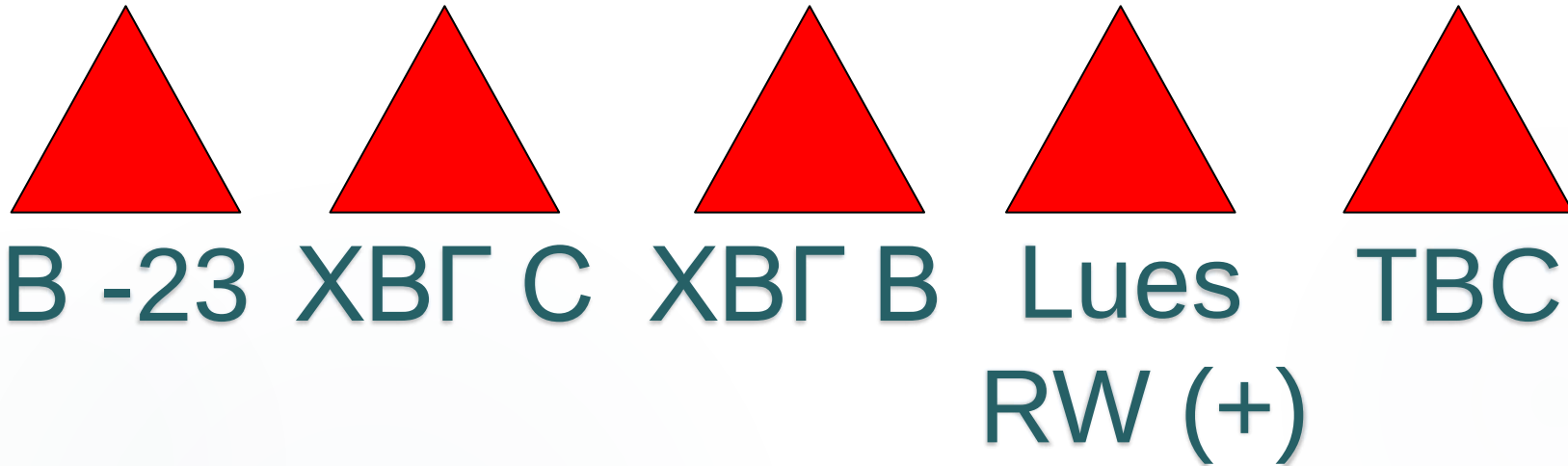
« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата оформления)



Статья 20

- Самостоятельно с 15 лет
- При наркомании – с 16 лет
- Недееспособные – законный представитель
- При отсутствии законных представителей или невозможности - консилиум

Служебные пометки



- ▶ Маркеры инфекционных заболеваний, передающихся парентеральным путем (гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис), а также социально значимые инфекционные заболевания (туберкулез) Обычно содержит название заболевания (гепатит В), год установки диагноза, иногда эпид. номер

Также на титул могут выносятся данные о наличии ФЛГ, введении протвостолбнячной сыворотки, наличии педикулеза (Pd+/-), чесотки (Sc+/-)

Сводка о состоянии больных на отделении



С целью определения количества больных, а также медицинских работников, находящихся в отделении и требующих эвакуации в случае возникновения чрезвычайного происшествия, дежурная постовая медицинская сестра **ежедневно до 20-00 и 07-00** обязана сдавать сводку (заполняется в свободной форме или с применением электронного документооборота) в **приемное отделение**, в которой указывается:

- Название или номер отделения;
- Количество пациентов, находящихся в отделении (в стационарах для взрослых – отдельно количество женщин, мужчин);
- Количество носилочных пациентов;
- Количество медицинского персонала (медицинские сестры, младшие медицинские сестры, санитарки, буфетчицы);
- Наличие дежурного врача;
- Количество вспомогательного, в том числе ухаживающего, персонала в отделении;
- В детских отделениях – лиц по уходу за пациентами.

Регистрация данных измерения температуры тела



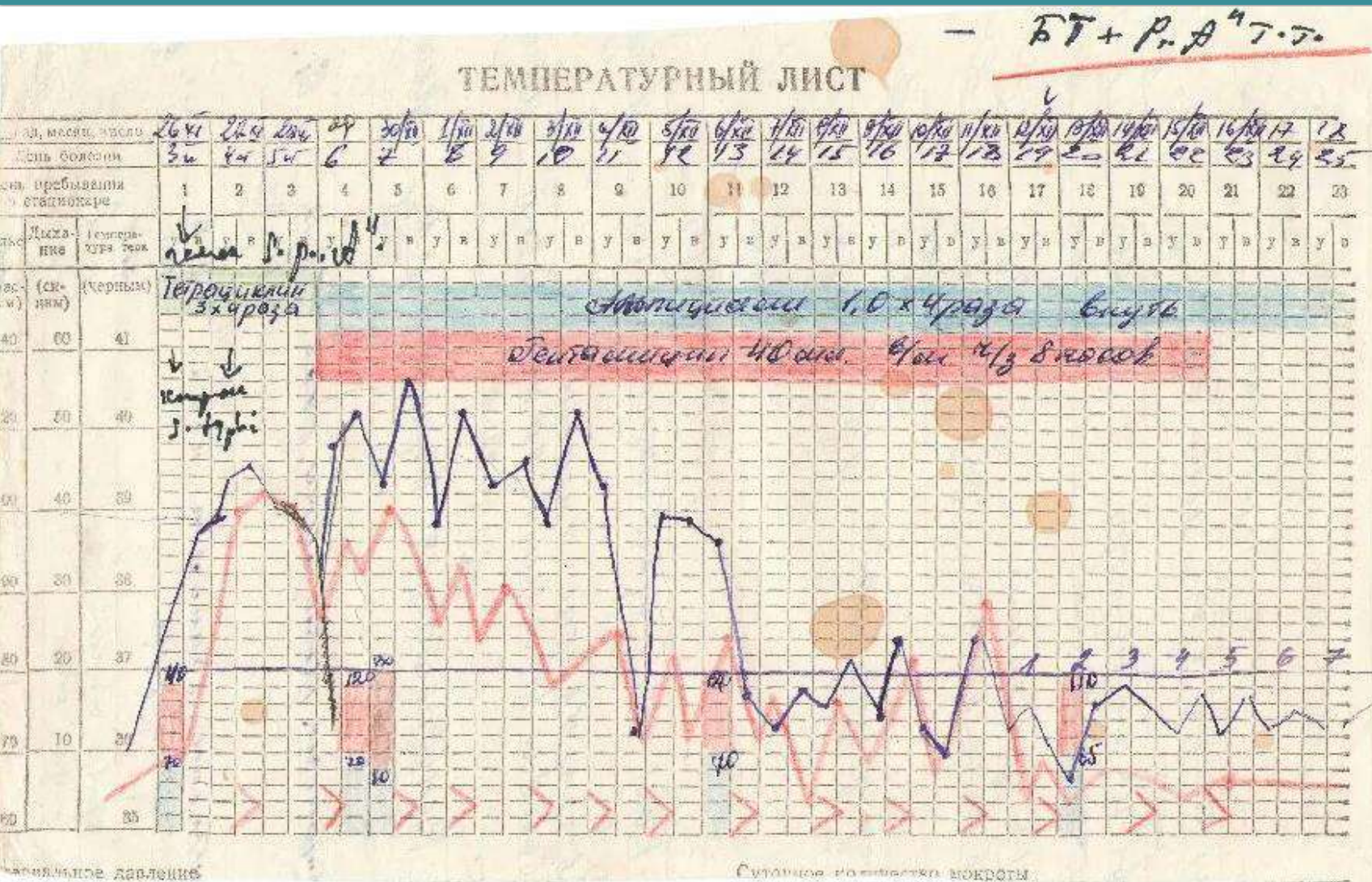
- Для записи температуры в стационаре обычно пользуются **общим постовым температурным листом**, на котором указаны фамилии пациентов, дата и время измерения (утро, вечер).
- Кроме этого, на каждого пациента заводится **индивидуальный температурный лист**, который вкладывается в историю болезни. Его заводят в приемном отделении вместе с медицинской картой на каждого пациента, поступающего в стационар.
- Показатели температуры регистрируют в температурном листе графическим способом. По оси абсцисс температурного листа отмечают дни болезни. Каждый день болезни рассчитан на двукратное измерение температуры тела. По оси координат расположена температурная сетка, каждое деление которой составляет $0,2^{\circ}\text{C}$. Соответствующими точками наносят результаты ежедневной двухразовой термометрии. Утренняя термометрия регистрируется точкой в графе «у» (утро), вечерняя – в графе «в» (вечер).
- Температура регистрируется синей или черной пастой. При последовательном соединении точек между собой, получаются **температурные кривые**, отражающие при наличии лихорадки тот или иной ее тип.

Температура **зелёным цветом**

Пульс **синим цветом**

АД **красным цветом**

Температурный лист (форма 004/у)



Общий температурный список пациентов



название отделения

« ____ » _____ 20__ г.
дата

Ф.И.О.	Утро	Вечер	Состояние	Ф.И.О.	Утро	Вечер	Состояние
1 палата				4 палата			
1				1			
2				2			
2 палата				5 палата			
1				1			
2				2			
3 палата				6 палата			
1				1			
2				2			

Подпись медицинской сестры _____

Лист основных показателей состояния больного



Министерство здравоохранения СССР

наименование учреждения

Лист основных показателей состояния больного
находившегося в отделении (палате) реанимации и
интенсивной терапии с диагнозом

Код формы по ОКУД

Код учреждения по ОКПО

Медицинская документация
форма N 011/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 г. N 1030

оборотная сторона ф. 011/у

Часы

8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

Лечение

Диурез

Белок

Сахар

Ацетон

рН

Моча

Гемоглобин

РОЗ мм/час

лейкоциты

рН

O2

Сахар

Кровь

Состояние У. СТ. Т.

8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

У - удовлетворительно
Ст. - средней тяжести
Т. - тяжелое

Подпись врача

Подпись врача

Лист назначений



ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ

Назначение лекарственных препаратов		Дата и время назначения														Отметка о выполнении
Режим	Врач															
	Медсестра															
Диета	Врач															
	Медсестра															
	Врач															
	Медсестра															
	Врач															
	Медсестра															
	Врач															
	Медсестра															

- Лист назначений является составной частью медицинской карты стационарного больного.
- Назначения записываются врачом четко, подробно, в форме, исключающей двоякое или произвольное толкование, подробно указываются доза (разовая), кратность, способ введения, дата назначения, время выполнения.
- Врач ежедневно отмечает необходимость назначений или их отмену, корректирует дозы.
- Названия лекарственных препаратов указываются на русском или латинском языке.

[illegible]

Лист назначений (обратная сторона)



Наименование исследования, консультации		Дата и время назначения Отметка о выполнении													
	Врач														
	Медсестра														
	Врач														
	Медсестра														
	Врач														
	Медсестра														
	Врач														
	Медсестра														
	Врач														
	Медсестра														

- На второй странице листа назначений указываются назначенные врачом консультации врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования, а также техника подготовки к инструментальным методам исследований, оперативным вмешательствам.

Журналы



Журнал врачебных назначений

№ п/п	Ф.И.О. пациента	Кровь на исследование	Дата взятия крови	Роспись м/с

Журнал учета взятия крови для биохимических исследований

Ф.И.О. пациента	Палата пациента	Наименование процедуры (лек. средства)	Кол-во назначенных процедур	Дата проведения процедур				

Журнал учета крови на RW

№ п/п	Ф.И.О. пациента	Возраст	№ истории болезни	Дом. адрес	Дата взятия крови на RW	Дата получения анализа	Результат

Журнал записи к врачам-специалистам



ЖУРНАЛ ЗАПИСИ ПАЦИЕНТОВ НА КОНСУЛЬТАЦИИ

Специалист _____

№ п/п	ФИО больного	Возраст	Адрес или название отделения стационара	Диагноз	Дата и время записи
1	2	3	4	5	6

и т.д. до конца станицы...

Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____

Министерство здравоохранения
СССР

наименование учреждения _____

Медицинская документация
Форма N 058/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 N 1030



ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на
прививку

1. Диагноз _____
подтвержден лабораторно: да, нет (подчеркнуть)

2. Фамилия, имя, отчество _____

3. Пол _____

4. Возраст (для детей до 14 лет - дата рождения) _____

5. Адрес, населенный пункт _____ район
улица _____ дом N _____ кв. N _____

(индивидуальная, коммунальная, общежитие - вписать)

6. Наименование и адрес места работы (учебы, детского учреждения)

7. Даты:

заболевания _____

первичного обращения (выявления) _____

установления диагноза _____

последующего посещения детского учреждения, школы

госпитализации _____

8. Место госпитализации _____

9. Если отравление – указать, где оно произошло, чем отравлен пострадавший _____

10. Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия и дополнительные сведения

11. Дата и час первичной сигнализации (по телефону и пр.) в СЭС _____

Фамилия сообщившего _____

Кто принял сообщение _____

12. Дата и час отсылки извещения _____

Подпись пославшего извещение _____

Регистрационный № _____ в журнале ф. № _____
санэпидстанции.

Подпись получившего извещение _____

Направления в процедурный кабинет



- ▶ Заполняет медсестра для извещения процедурной медсестры о том, какой препарат необходимо ввести пациенту, способ введения, дозировку и др.
- ▶ NB! Если пациенту необходимо сделать инъекцию срочно, то на направлении пишут:
- ▶ **Cito! — Срочно!**
- ▶ **Statim! — Немедленно!**

или

- ▶ **Citissimo!** — когда промедление опасно для жизни больного и требуется немедленное вмешательство

«ОФОРМЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИЮ. НА КОНСУЛЬТАЦИЮ, НА ПРОЦЕДУРЫ»



- ▶ Уточнить из амбулаторной карты пациента (медицинской карты стационарного пациента, листа назначения) назначенные пациенту обследования.
- ▶ Оформить направление, указав:
- ▶ Ф. И.О., возраст пациента;
- ▶ цель обследования;
- ▶ наименование направляющего лечебного учреждения;
- ▶ отделение, номер палаты (адрес пациента и № участка, если обследование проводится в поликлинике);
- ▶ фамилию врача, назначившего процедуру;
- ▶ диагноз;
- ▶ дату назначения.
- ▶ Поставить свою подпись.

НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ

Фамилия _____

Имя _____ Отчество _____

Диагноз _____

направлен _____

куда

для _____

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Направления на лабораторное исследование



1. Название лаборатории (клиническая, биохимическая, бактериологическая, вирусологическая);
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента;
3. Пол пациента;
4. Дата рождения и возраст пациента;
5. Диагноз (при необходимости);
6. Номер истории болезни (медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях или медицинской карты стационарного больного);
7. Название отделения, номер палаты (при амбулаторном обследовании – домашний адрес);
8. Биологический материал (кровь, моча, мокрота и т.д.);
9. Цель исследования;
10. Дата забора биологического материала;
11. Подпись медицинской сестры, оформляющей направления и выполняющей забор биологического материала.

Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____

Министерство здравоохранения СССР
наименование учреждения _____

Медицинская документация
Форма N 200/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 г. N 1030

НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗ N 168
" 7 " апреля 20 10 г.
дата взятия биоматериала

В лабораторию _____
Фамилия, И., О Белозерова Мария Генриховна
Возраст 1956
Учреждение прл-ка N 6 отделение _____
Палата _____ участок 2 медицинская карта N _____
Диагноз, группа диспансерного учета хрон. артрит
Исследовать (указать консервант) мокроту
(нужное вписать)
Подпись врача Сорокин

Подклейка результатов анализов в медицинскую карту стационарного больного

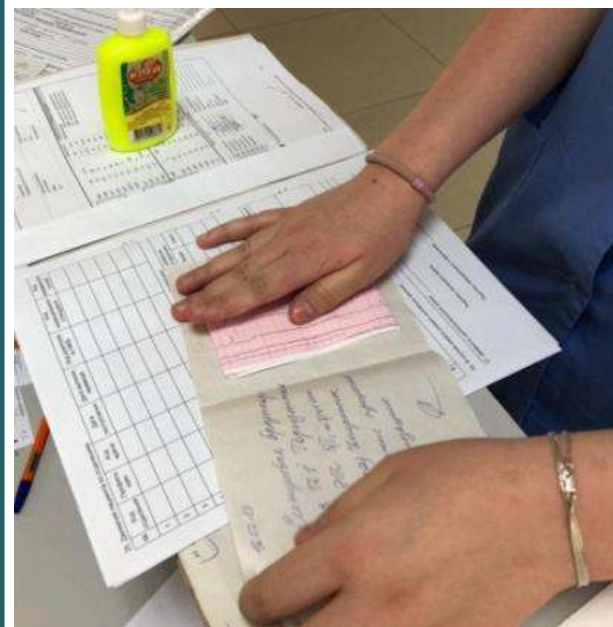


Результаты анализов **кала**

Результаты анализов **крови**

Результаты **соскобов,**
бак.исследований,
мокроты
и. др.

Результаты анализов **мочи**





Создание безопасной среды для пациента и медицинского персонала

Безопасная больничная среда



- ▶ Организация работы любого стационара направлена на то, чтобы создать безопасную среду – как для своих пациентов, так и для медицинских работников.
- ▶ **Безопасной больничной средой** называется среда, которая в наиболее полной мере обеспечивает пациенту и медицинскому работнику условия комфорта и безопасности, позволяющие эффективно удовлетворять все свои жизненно важные потребности.



Структура безопасной среды



1. Режим инфекционной безопасности

2. Мероприятия, обеспечивающие личную гигиену пациентов и медперсонала:

Личная гигиена пациента

Личная гигиена медперсонала

3. Лечебно-охранительный режим:

Режим эмоциональной безопасности для
пациентов и медперсонала

Правила внутреннего распорядка и выполнения
манипуляций

Правила безопасности при выполнении
манипуляций

Режим рациональной двигательной активности



Лечебно-охранительный режим



▶ это комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение максимального физического и психического комфорта пациентов и медицинского персонала.

Целесообразная
физическая активность

Психологический
комфорт пациента

Распорядок дня
лечебного отделения

Режим эмоциональной безопасности



Среда медицинской организации должна обеспечить пациенту психический покой, способствующий преодолению **неблагоприятных факторов госпитализации**:

- ▶ страха и беспокойства перед исследованиями и лечением,
- ▶ переживания от расставания с привычной домашней обстановкой,
- ▶ трудностей приспособления к новой среде, окружающему медицинскому персоналу, соседям по палате.

Сдержанность и внешнее спокойствие медперсонала оказывает положительное воздействие на пациента. Неосторожно сказанная фраза может нанести больному непоправимый вред, значительно снизить эффективность всех проводимых в дальнейшем лечебных мероприятий.



Режим эмоциональной безопасности



Приемы:

- ▶ поддержание тишины, спокойной и доброжелательной обстановки в отделении;
- ▶ общение с пациентом негромким голосом, только с положительной интонацией;
- ▶ создание удобного интерьера, наличие помещений для отдыха и посещений пациентов близкими;
- ▶ организация досуга пациентов, обеспечение возможности заняться какой-либо доступной деятельностью, например, чтением; вязанием, просмотром телепередач;
- ▶ устранение отрицательных эмоций, которые могут быть вызваны у пациентов видом медицинских инструментов, предметов ухода, испачканных кровью и выделениями;
- ▶ обеспечение соответствующей обстановки и психологической поддержки при проведении каждой манипуляции;
- ▶ психологическая поддержка обездвиженным пациентам, особенно при проведении мероприятий общего ухода;
- ▶ рациональное заполнение палат;
- ▶ обеспечение тишины во время дневного и ночного отдыха пациентов



Режим эмоциональной безопасности

Божественное дело – утешать боль.

Гиппократ



- ▶ Борьба с болью – одна из основных проблем пациентов. Поэтому все манипуляции должны проводиться чрезвычайно осторожно с применением во всех возможных случаях современных способов обезболивания и с предварительной подготовкой пациента.



Правила внутреннего распорядка



- Правила внутреннего распорядка состоят в соблюдении установленного в отделении режима дня, который обеспечивает пациентам своевременное питание, выполнение гигиенических и лечебно-диагностических мероприятий, полноценный отдых, а также способствует поддержанию соответствующего санитарного состояния в палатах (отделении).

Примерный распорядок дня в ЛПУ

Время	Мероприятие	Время	Мероприятие
7.00	Подъем	16.30-17.00	Измерение температуры
7.00—7.30	Измерение температуры	17.00-17.30	Полдник
7.30—8.00	Утренний туалет	17.30-19.00	Посещение родственниками
8.00—8.30	Раздача лекарств	19.00—19.30	Раздача лекарств
8.30—9.30	Завтрак	19.30—20.00	Ужин
9.30—12.00	Врачебный обход	20.00—21.30	Выполнение врачебных назначений
12.00—14.00	Выполнение врачебных назначений	21.30—22.00	Вечерний туалет
14.00—14.30	Обед	22.00	Отход ко сну
14.30—16.30	Послеобеденный сон		

Правила безопасности при выполнении манипуляций



С целью снижения риска возникновения осложнений в результате проведенных манипуляций и процедур больной должен знать о возможных последствиях при несоблюдении правил поведения после них.

Сестринские вмешательства, направленные на снижение риска падений, травм, ожогов, пищевых отравлений и поражений электрическим током во время проведения процедур, должны быть сконцентрированы на выявлении пациентов с высоким риском несчастных случаев.

Для профилактики ИСМП медицинская сестра должна соблюдать режим инфекционной безопасности и личной гигиены пациента.

СОП "Внутривенное введение лекарственных средств"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56819—
2015

НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

Издание официальное

Правила безопасности



- ▶ Кровать больного, санузел должны быть оборудованы звонками для экстренного вызова;
- ▶ Для предупреждения падений в отделениях МО не должно быть высоких порогов, проводов и других предметов на полу;
- ▶ Лестницы и коридоры должны быть хорошо освещены;
- ▶ Ослабленных больных и пациентов с нарушениями координации следует приучать пользоваться перилами, поручнями, опорными ручками, ходунками;
- ▶ Все средства передвижения больного, имеющие колеса: каталки, кресла-каталки, функциональные кровати должны иметь функционирующие тормоза;
- ▶ Следует периодически проверять состояние стекол очков у пациентов со слабым зрением и их соответствие потребности больного;
- ▶ Необходимо периодически проверять качество работы слухового аппарата у пациентов;
- ▶ Ослабленные пациенты должны пользоваться туалетом, не закрывая дверь на задвижку;
- ▶ Чтобы избежать падения с кровати, пользуются кроватями, имеющими боковые бортики;
- ▶ Пациентам, страдающим недержанием мочи и кала, нельзя пользоваться электрической грелкой, во избежание электротравм;
- ▶ Пациенты с нарушениями глотания должны есть и пить в присутствии второго лица;
- ▶ Следует прятать спички от пациентов, страдающих слабоумием;
- ▶ Нельзя курить, включать электроприборы рядом с больными, использующими кислородную подушку.



Режимы двигательной активности



Строгий постельный



Постельный



Палатный



Общий

СТРОГИЙ ПОСТЕЛЬНЫЙ



Строгий постельный режим



- ▶ Назначают пациентам в остром периоде тяжелых заболеваний;
- ▶ Пациенту категорически запрещается не только вставать, но и садиться, а в некоторых случаях и поворачиваться в постели;
- ▶ Все санитарно-гигиенические мероприятия (санитарная обработка пациента, смена белья, подача судна и мочеприемника), а также кормление осуществляется только с помощью медицинской сестры;
- ▶ Особенно осторожными и аккуратными должны быть действия медперсонала при транспортировке таких пациентов и выполнении лечебных и диагностических мероприятий.
Длительность строгого постельного режима каждому пациенту индивидуально устанавливает врач, в зависимости от особенностей течения его заболевания.

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ



Характеризуется несколько большей активностью пациента в постели:

- ▶ разрешается поворачиваться,
- ▶ под наблюдением врача или медицинской сестры выполнять легкие гимнастические упражнения,
- ▶ все санитарно-гигиенические мероприятия осуществляются медицинскими сестрами,
- ▶ может присаживаться на краю кровати, опустив ноги или на стул для приема пищи, проведения утреннего туалета.

ПАЛАТНЫЙ РЕЖИМ



- ▶ Пациент много времени проводит в постели, но разрешается сидеть, вставать, ходить по палате.
- ▶ Туалет, кормление, физиологические отправления осуществляются в палате.



ОБЩИЙ РЕЖИМ



Разрешается ходьба по коридору, подъем по лестнице, прогулки по территории больницы. Пациенты самостоятельно себя обслуживают: принимают пищу в столовой, ходят в туалет, принимают гигиеническую ванну или душ и т.д.



Основные понятия об эргономике

Биомеханика и эргономика



- ▶ **Биомеханика** – наука, изучающая правила механического движения тела в пространстве.
- ▶ **Эргономика** – наука о взаимосвязи людей и окружающей среды в целях безопасного труда.



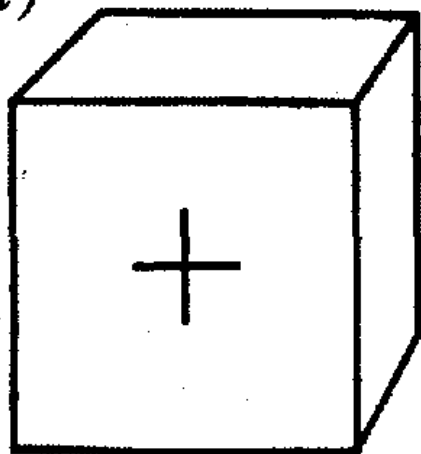
Физика...

правила эргономики

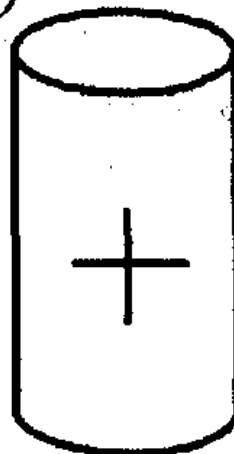


1. Равновесие тела обеспечивает центр тяжести тела к площади опоры

а)



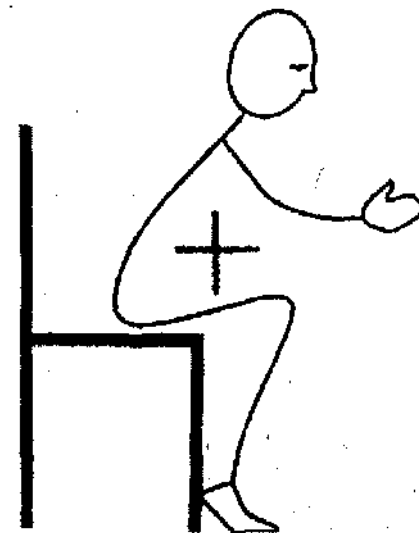
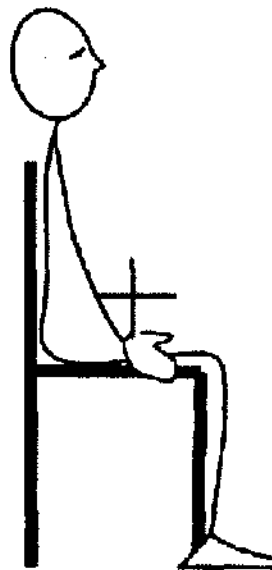
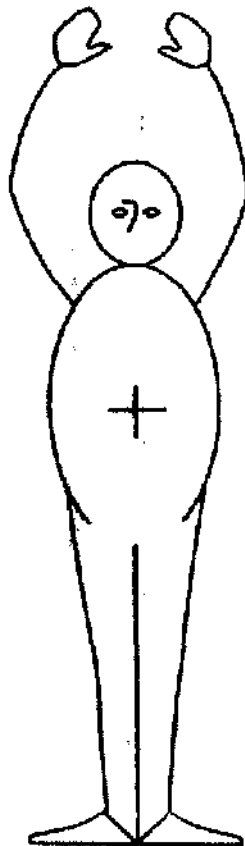
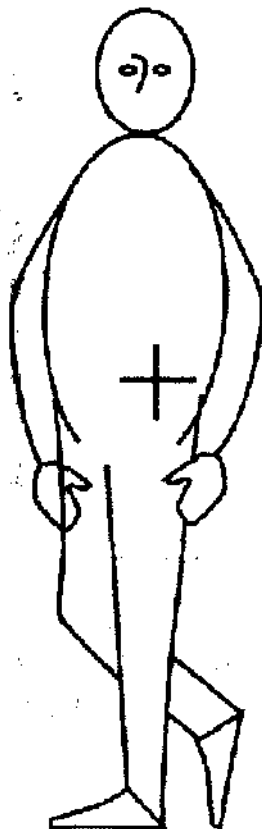
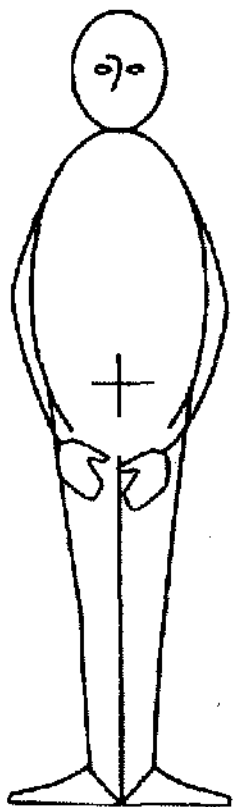
б)



2. Соблюдение правильной осанки сохраняет равновесие тела и снижает нагрузку на позвоночник

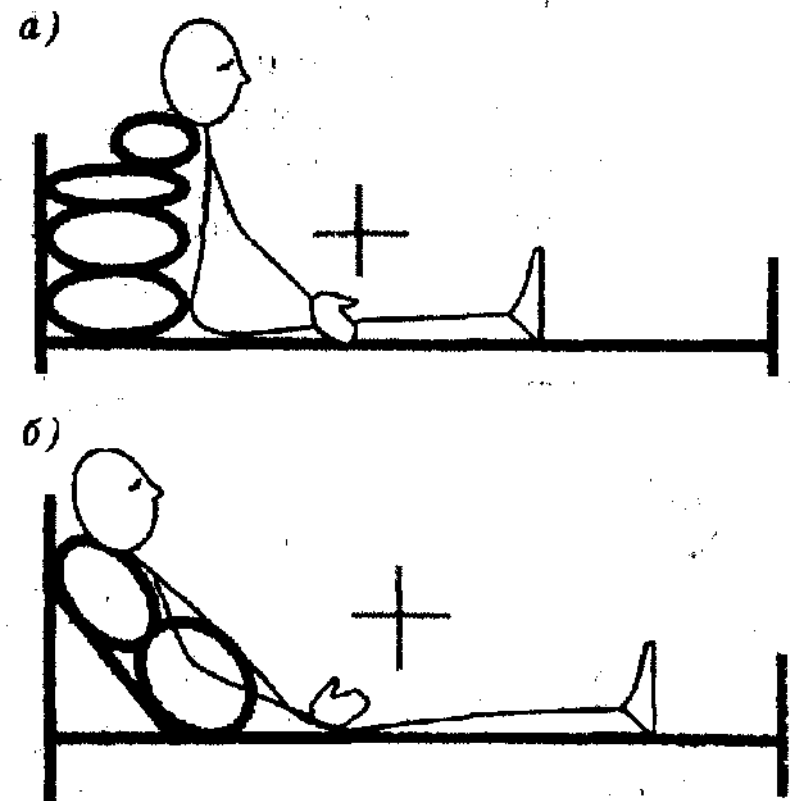
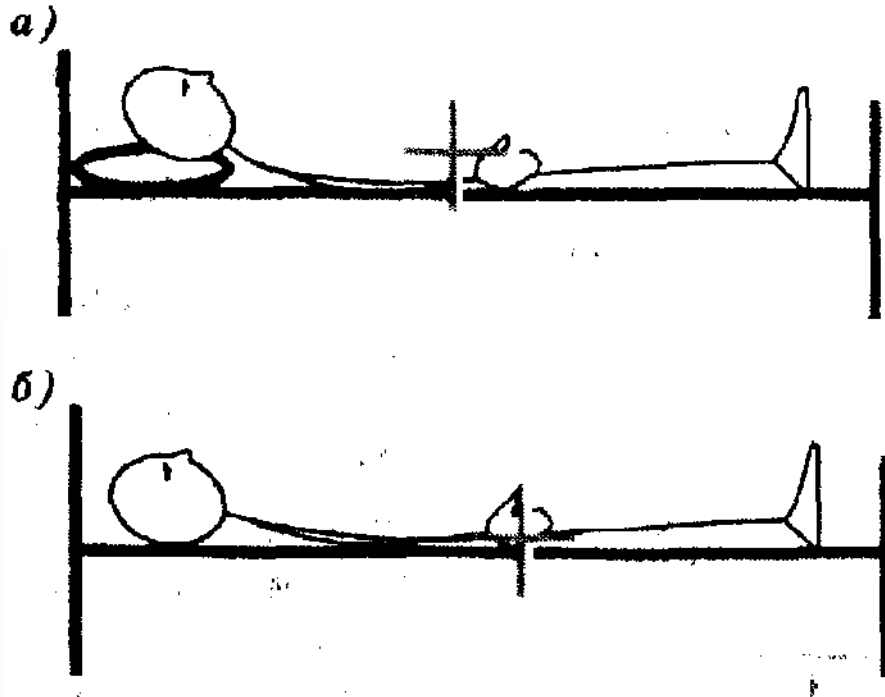
Физика...

правила эргономики



Физика...

правила эргономики



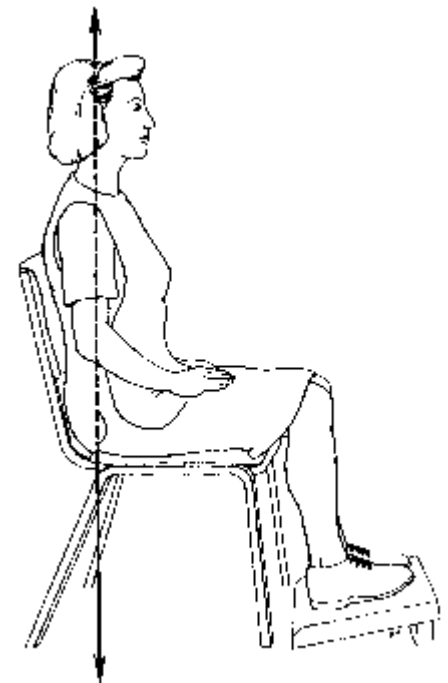
Правильная биомеханика в положении сидя



- ▶ Колени должны быть чуть выше бедер;
- ▶ Спина должна быть прямой, а мышцы живота — напряженными;
- ▶ Плечи должны быть расправлены и расположены симметрично бедрам;

Высота стула и его глубина подобраны правильно, если:

- ▶ $\frac{2}{3}$ длина ваших бедер находится на сиденье,
- ▶ стопы без напряжения касаются пола.



Правильная биомеханика тела в положении стоя



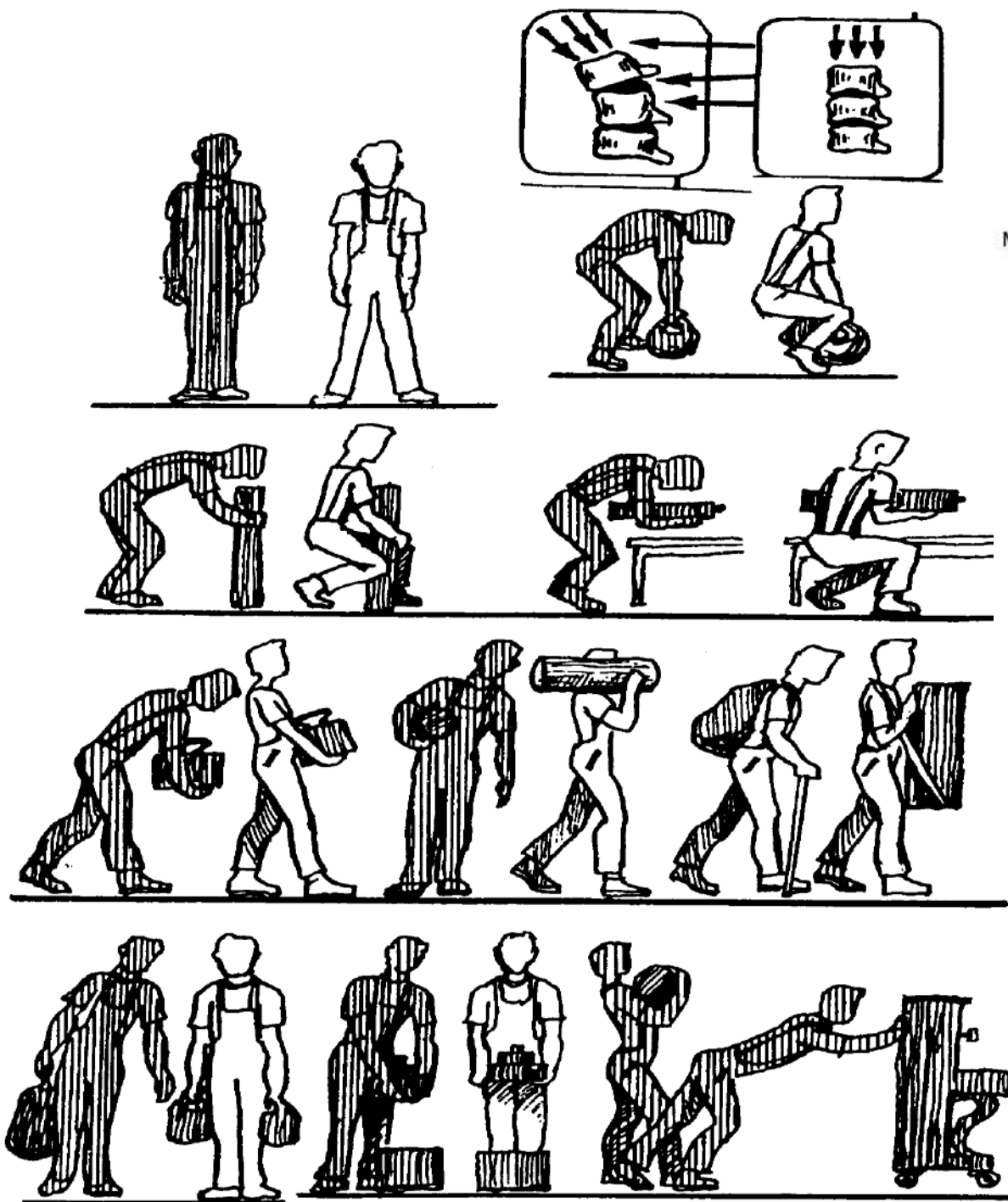
- ▶ Колени должны быть расслабленными так, чтобы коленные суставы двигались свободно,
- ▶ Масса тела должна быть распределена равномерно на обе ноги,
- ▶ Ступни должны быть расставлены на ширину плеч,
- ▶ Расположите плечи в одной плоскости с бедрами.



Правильная биомеханика при поднятии тяжестей

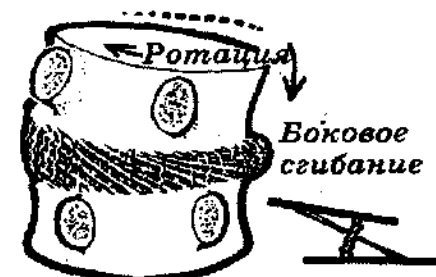
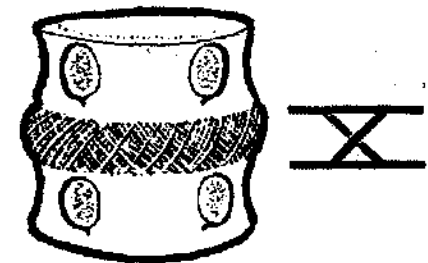


1. Перед поднятием тяжестей расположите стопы на расстоянии 30 см друг от друга, выдвинув одну стопу слегка вперед (этим достигается хорошая опора и уменьшается опасность потери равновесия и падения),
2. Встаньте рядом с человеком, которого вам нужно будет поднимать, так, чтобы вам не нужно было наклоняться вперед,
3. Прижимайте поднимаемого человека к себе в процессе подъема,
4. Сгибайте только колени, поднимая человека, сохраняя туловище в вертикальном положении,
5. Не делайте резких движений.



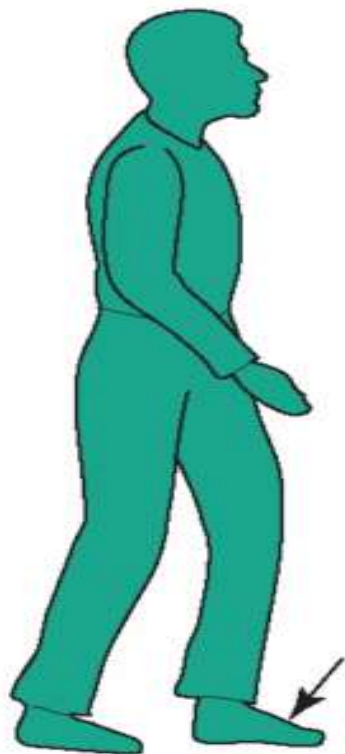
А

Межпозвоночный диск

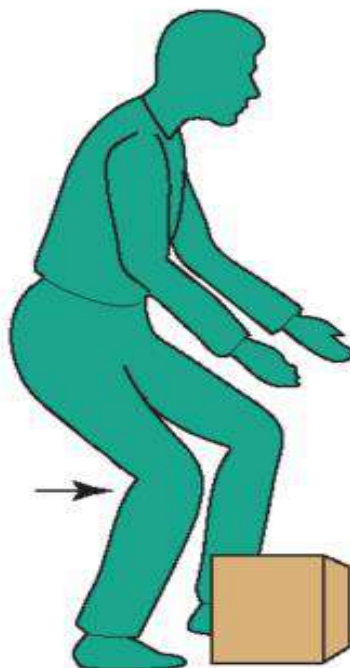


Б

Правила биомеханики



Ноги на ширине
плеч



Сгибайте колени,
а не спину



Держите предмет
ближе к телу

Вспомогательные средства для перемещения пациентов



Подбор трости



Преимуществом телескопической трости является возможность ее регулировки по высоте. Для пациентов с нарушением координации следует рекомендовать трости со смещенным центром тяжести.

Ручка трости должна быть нескользящей, лучше из шероховатого медицинского пластика.

При обхвате ручки трости пальцы пациента не должны упираться в ладонь.

Наконечник трости должен быть не менее 3-5 см в диаметре. Альтернатива – многоопорная трость. В зимнее время лучше использовать сменные наконечники типа «антилед».



сменный наконечник
типа «антилед»



Шагающие и переставные ходунки

Ролаторы



- Различают шагающие и нешагающие модели ходунков.
- Нешагающие модели имеют жесткую конструкцию, действующую как единое целое.
- Шагающие модели имеют шарниры, позволяющие смещать стороны ходунков по отношению друг к другу, что позволяет пациенту при перемещении вперед одной части ходунков опираться на вторую их сторону.
- Ходунки-ролаторы служат для комфортного передвижения по открытым территориям.



Удержание пациента с помощью рук



1. Одиночный запястный захват



3. Захват рукой



5. Захват «Ладонь в ладонь» с захватом большого пальца



2. Двойной запястный захват



4. Захват пальцами



6. Захват «ладонь в ладонь» без захвата большого пальца



Приемы эргономичного перемещения пациента



- «Медвежьи объятия» – захват и поддержка пациента при подъёме со стула, кровати, при перемещении.
- Попросить пациента охватить работника за талию, придерживать его за плечи.
- Подтянуть пациента к краю так, чтобы его ноги коснулись пола.
- Поставить одну ногу между коленями пациента, другую - по направлению движения.
- Прижать пациента в позе «объятия», плавно поднимать его, не дергая и не поворачивая.
- Не давить пациенту под мышками!
- Предупредить его, что на счет «три» Вы поможете ему встать.

Приемы эргономичного перемещения пациента



- ▶ Подмышечный захват
- ▶ Встаньте сбоку лицом к сидящему пациенту.
- ▶ Поставьте одну ногу рядом, а другую, слегка развернув стопу, впереди ног пациента, фиксируя его колени.
- ▶ Проведите одну кисть в дальнюю подмышечную впадину пациента, а вторую кисть проведите в направлении сзади и кпереди ладонью вверх (большой палец находится снаружи, вне подмышечной впадины).
- ▶ Убедитесь, что у Вас есть возможность свободно перемещать массу вашего тела с одной ноги на другую и Вы стоите удобно.
- ▶ Попросите пациента, помогите ему наклониться вперёд от бедра так, чтобы его плечо, находящееся ближе к Вам, твёрдо упиралось в Ваше туловище.



Приемы эргономичного перемещения пациента



- ▶ Встать рядом с пациентом.
- ▶ Одной рукой держать его за руку методом захвата рукой, другой рукой поддерживать пациента за локоть или талию.

Средства эргономичного перемещения



- ▶ Скользящая двухсторонняя простыня – медицинское приспособление из специальной прочной ткани размерами 180х60см, обладающей низким трением и способностью к легкому скольжению по различным сухим и влажным поверхностям.
- ▶ Используется для уменьшения чрезмерной физической нагрузки при перемещении пациента в горизонтальной плоскости в пределах кровати, для изменения положения в постели, перемещения с поверхности на поверхность и эффективно облегчает труд медицинских работников.



Средства эргономичного перемещения



- ▶ Удерживающий пояс
- ▶ Эргономическое приспособление, представляющее собой многослойный пояс с 4 ручками-креплениями и замком.
- ▶ Он необходим для уменьшения физической нагрузки на медицинского персонала при перемещении и передвижении пациентов



Эргономические носилки (fleximove)





Падение



- ▶ событие, в результате которого человек оказывается непреднамеренно лежащим на земле, полу или каком-либо другом более низком уровне.
- ▶ внезапная, непреднамеренная и неконтролируемая потеря равновесия, в результате которой человек оказывается на нижерасположенной поверхности или предмете.
- ▶ **Падение с поддержкой** – падение пациента в присутствии медперсонала, пытавшегося минимизировать последствия падения.
- ▶ **Случайное падение** – падение, вызванное внешними причинами.
- ▶ **Профилактика падений** - это стратегия уменьшения риска падений. Она должна быть:
 - всесторонней и многоплановой
 - поддерживать политику по созданию более безопасной окружающей среды и снижению факторов риска.
 - стимулировать проведение инженерно-технических работ по устранению потенциальных опасностей
 - повышать осведомленность людей и отдельных сообществ в отношении факторов риска.



Процесс профилактики падений



Исполнители	Мероприятия	Время
1. Врач приемного отделения	Первичная оценка риска падений в соответствии с факторами риска	В приемном отделении
2. Врач	Комплексная оценка риска падений и назначение режима профилактики падений	После поступления в коечное отделение
3. Медсестра	Маркировка пациента, палаты и ИБ при высоком риске. Профилактика падений в соответствии с категорией риска	После назначения врача
4. Врач	Контроль необходимости переоценки риска падений	Ежедневно

Критерии повторной оценки риска падения



а) пациент с высоким риском падения: 51 и выше баллов по шкале Морзе.	1 раз в сутки до тех пор, пока не снизится на 50 или ниже баллов.
б) Если произошло падение - не учитываются падения без вреда во время игр детей.	оценить риск падения минимум 1 раз.
с) После операции, анестезии, седации, инвазивной процедуры.	оценить риск падения минимум 2 раза (после операции и позже в течение 12 часов).
д) При приеме медикаментов, повышающих риск падения. - седативные; - гипнотические; - диуретики; - нейролептики; - антидепрессанты; - противосудорожные средства.	оценить риск падения минимум 1 раз.
е) При заторможенном, затуманенном, встревоженном состоянии, делирии, лунатизме, атаксии, дистонии, гиперкинезе, с историей судорог, эпилепсии, ДЦП и др. состояниях, повышающих риск падения.	оценить риск падения минимум 1 раз.
ф) При недержании мочи, учащенном мочеиспускании.	оценить риск падения минимум 1 раз.

Факторы повышенного риска падений



- ▶ Возраст старше 65 лет;
- ▶ Нарушения зрения и равновесия у пациента;
- ▶ Нарушения походки;
- ▶ Лекарственная терапия, включающая прием диуретиков, транквилизаторов, седативных, снотворных препаратов и анальгетиков;
- ▶ Ортостатическая реакция, сопровождающаяся головокружением, при переходе пациента из положения лежа в положение сидя или стоя;
- ▶ Импульсивное и беспокойное поведение;
- ▶ Замедленная реакция: неспособность пациента быстро принимать решение в случае возникновения опасности падения;
- ▶ Спутанность сознания или дезориентация;
- ▶ Падения в последние 3 месяца до госпитализации;
- ▶ Передвижение на каталке, с помощью костылей, вспомогательных средств;
- ▶ Передвижение с помощью посторонних людей;
- ▶ Мышечная слабость



Мероприятия, воздействующие на окружающую обстановку



- установка сигнализации около кровати и её тестирование;
- ограничение степени открывания окон;
- установка устройства сигнализаций на выходах;
- усовершенствование системы вызова медицинского персонала;
- использование низких кроватей для пациентов с риском падения, а также использование ограничителей на кровати;
- использование эргономичной мебели;
- назначение надлежащих вспомогательных устройств для передвижения;
- оборудование ванных комнат и туалетов специальными поручнями;
- усовершенствование освещения;
- использование защитных заслонов/ограждений;
- расположение пациентов со значительным риском ближе к посту медицинских сестер.



Мероприятия, воздействующие на персонал



- ▶ ознакомление сотрудников со стратегией по снижению риска падения;
- ▶ усовершенствование системы доступа пациентов к персоналу;
- ▶ инструктаж персонала, вовлеченного в лечебный процесс мер по снижению риска падения;
- ▶ обучение персонала правилам реагирования на факт падения.



rendering - 3dsmax, c4d, maya

Мероприятия, воздействующие на пациента



- проводить занятия с пациентом на тему «профилактика падений»;
- включить в лечебную программу упражнения, позволяющие восстановить способность к передвижению;
- приложить все усилия по повышению самообслуживания пациента;
- восстановить режим сна;
- проводить эффективную обезболивающую терапию;
- ознакомить пациента с приемами релаксации, медитации;
- предложить занятия, отвлекающие внимание, например: возможность чтения книг, просмотра телепередач и т.д.



Ортостатическая проба



► Необходимое оборудование: стетоскоп, тонометр, часы с секундной стрелкой

положение пациента	Процедура
лежа на спине в течение 5 минут	• измерить уровень артериального давления на правой руке • определить стетоскопом ЧСС на верхушке сердца в течение 60 секунд
резко встает	• не снимая манжетки тонометра, немедленно измерить уровень АД и ЧСС • спросить пациента, не испытывает ли он головокружение/ дурноту* • не снимая манжетки тонометра, но каждый раз выпуская из нее воздух, несколько раз (3-5 раз) с 2-х минутными интервалами в положении стоя (в течение 10 мин.) измерить уровень АД и ЧСС, затем в положении лежа** * если необходимо для безопасности пациента, использовать помощь ** если пациент не может стоять, измерить уровень АД и ЧСС в положении сидя, но учесть, что чувствительность теста снижается
Оценка пробы	
найти разницу между значениями АД и ЧСС, измеряемыми стоя (или сидя) и лежа	
Интерпретация риска падения	
➤ показатели АД и ЧСС в положении стоя значительно не изменяются	проба отрицательная: риск падения не повышен
➤ ортостатическая гипотензия: снижение САД >20 мм рт.ст. или ДАД >10 мм рт.ст. и/или ➤ увеличение ЧСС >20 уд.в мин.	проба положительная: риск падения повышен

Шкала риска падений Морзе



Факторы	Наличие	Кол-во баллов
Падение в анамнезе	нет	0
	есть	25
Сопутствующие болезни	нет	0
	есть	15
Наличие у пациента с ограниченной функцией ходьбы дополнительного приспособления для перемещения	Отсутствие при условии постельного режима	0
	Костыли или трость	15
	Придерживается при перемещении за мебель	30
Наличие у пациента внутривенного катетера	нет	0
	есть	20
Функция ходьбы	норма/постельный режим/обездвижен	0
	слабая	10
	нарушена (нуждается в посторонней помощи)	20
Понимание пациентом своих возможностей и ограничений	Больной в полной мере осознает свои ограничения	0
	Больной переоценивает свои возможности или забывает о них	15

Подсчет вероятности травматизма по шкале Морзе



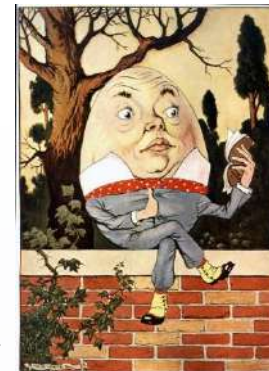
Вероятность травматизма	Сумма полученных баллов	Меры профилактики
Нет риска	<10	Стандартный медицинский уход
Низкая степень вероятности	10-20	Стандартный медицинский уход
Средняя степень	25-45	Нуждаются в стандартизированных мероприятиях для профилактики падений
Высокая степень	>50	Индивидуальные специфические мероприятия для профилактики падений

Кто такой Хампти-Дампти?

Шалтай-Болтай – Humpty Dumpty



Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
All the King's horses
And all the King's men,
Couldn't put Humpty together again.



*Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!*



Оценка риска падения по шкале Хампти-Дампти (для детей)



Параметр	Критерии	Бал
Возраст	Младше 3-х лет	4
	От 3 до 7 лет	3
	От 7 до 13 лет	2
	От 13 до 18 лет	1
Пол	мужской	2
	женский	1
Диагноз (Отягощающие обстоятельства)	Неврологические нарушения	4
	Нарушения оксигенации (дыхательные нарушения, обезвоживание, анемия, анорексия, обморок, головокружение и т.д.)	3
	Психологические и поведенческие расстройства (гиперактивность, гиперактивность, и т.д.)	2
	Другое	1
Когнитивные расстройства	Не осознает своих ограничений	3
	Забывает об ограничениях	2
	Ориентируется в собственных способностях	1
Факторы окружающей среды	В анамнезе случаи падения с детских или взрослых кроватей	4
	Пациент использует вспомогательные средства: костыли, ходунки, трость, коляска	3
	Лежащий пациент/на руках (у мамы или др. ухаживающего лица)	2
	Пациент ходит самостоятельно	1
Состояние после	до 24 часов	3

операции/ седации/ анестезии/ инвазивной процедуры	до 48 часов	2
	Более 48 часов/не проводилось	1
Использование медикаментов	Одновременное применение медикаментов (2 и более): - Седативные (за исключением пациентов ОАРИТ, находящихся в медикаментозной седации и под действием миорелаксантов): Диазепам (Реланиум) - Снотворные - Противосудорожные препараты: Карбамазепин, Вальпроевая кислота (Конвулекс, Депакин, Энкорат), Ламотриджин (Лам. Подсчет вероятности травмат...ин) - Барбитураты: Фенобарбитал, Бензобарбитал - Фенотиазины: Хлорпромазин (Аминазин), Левомепромазин (Тизерцин) - Антидепрессанты - Слабительные/Диуретики: Лактулоза (Дюфалак), Фуросемид (Лазикс), Маннитол (Маннит), Ацетазоламид (Диакарб) - Наркотики: Морфин, Фентанил, Тримеперидин (Промедол)	3
	Использование 1 медикамента из вышеперечисленных групп	2
	Другие медикаменты/не принимает медикаменты	1
Общее количество баллов:		

Результат оценки риска падения по шкале Хампти-Дампти



Балл	Уровень риска	Действия среднего медицинского персонала
7-11	Низкий риск (Н)	ПМ: Профилактические меры
12-23	Высокий риск (В)	ВР: Меры для пациентов высокого риска падения

Общие меры профилактики падения



▶ Старшая медицинская сестра отделения должна:

- проводить обучение медицинских сестер/брата уходу за пациентами с высоким риском падения;
- обеспечить расположение пациентов с высоким риском падения ближе к посту медицинской сестры;
- обеспечить наблюдение/сопровождение пациентов с высоким риском падения на манипуляции, в туалет и во время других процедур;
- сообщать инженеру по технике безопасности о дополнительных рисках падения (например, неровный пол, отслойка кафеля и т.д.).

▶ Сестра-хозяйка должна:

- обеспечить работу кнопки вызова (сообщить техническим службам в случае неисправности);
- каждые 30 дней проверять, работают ли все кнопки вызова.

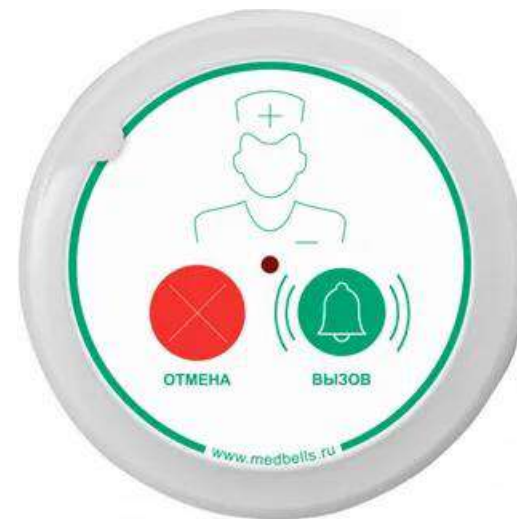
▶ Санитарка должна:

- по указанию медицинской сестры или по просьбе пациента сопровождать пациента;
- незамедлительно реагировать на вызовы пациентов;
- содержать в чистоте окружающую среду пациентов;
- немедленно вытереть разлитую жидкость, обеспечить сухость пола;
- размещать **желтую вывеску/знак** о мокром (только что вымытом) поле при проведении уборок.
- убирать с проходного пути пациента провода, шнуры и другие предметы;
- по указанию медицинской сестры фиксировать койки в наиболее низком положении, заблокировать тормозами;
- включать свет для пациента в мало освещенных местах (обеспечить достаточное освещение).

Меры по снижению риска: Низкий риск падения



- ▶ Установить высоту кровати на нижнем положении;
- ▶ Закрепить кроватьные колеса, ходунки, инвалидное кресло в устойчивом положении;
- ▶ Поставить коляску и др. вспомогательные предметы рядом с пациентом;
- ▶ Обеспечить хорошее освещение;
- ▶ Сообщить техническим отделам о неисправностях (например, если не работает кнопка вызова);
- ▶ Напомнить, чтобы пациент носил нескользкую обувь;
- ▶ При сопровождении пациента, сообщить персоналу другого отделения об его/ее риске падения.



Меры по снижению риска: Высокий риск падения



- ▶ Если высокий риск (51 и выше баллов у взрослых, 12 и выше у детей) - на браслет пациента наклеить **полоску красного цвета** (не закрывая текст) или надеть браслет **красного цвета** (при наличии);
- ▶ Наклеить соответствующий знак снаружи палаты:
 - на входной двери палаты у взрослых установить знак - красный квадрат;
 - на входной двери палаты у детей установить знак Хампти-Дампти;
- ▶ Провести дополнительное обучение пациента/лица по уходу;
- ▶ Совершать обходы в палату каждые 2 часа, особенно ночью, в моменты пробуждения;
- ▶ Поднять боковые ограждения / борты койки;
- ▶ Сопровождать в туалет;
- ▶ Сопровождать пациента после операции, родов, анестезии, седации, инвазивной процедуры;
- ▶ По мере возможности разместить пациента в палате, ближайшей к посту;
- ▶ Постараться обеспечить присутствие лица по уходу или санитарки;
- ▶ Ознакомить пациента и/или лиц по уходу о принимаемых лекарственных средствах, об их влиянии на падение (головокружение, слабость);
- ▶ Средний медицинский персонал должен завести специальную форму и провести повторную оценку риска падения по шкале Морзе для взрослых и по шкале Хампти-Дампти для детей

Действия персонала в случае падения пациента



1. Не двигать пациента до осмотра на наличие травм; успокоить, если он в сознании.
2. Позвать на помощь персонал отделения, в котором произошло падение, сообщить лечащему /дежурному врачу.
3. Если пациент жалуется на боль в шее или головную боль, либо при подозрениях на травму шейного отдела позвоночника обеспечить неподвижность головы с помощью подручных средств. Обязательно проверить, может ли пациент свободно дышать, есть ли носовое кровотечение, при котором кровь и сгустки могут попасть в дыхательные пути.
4. При рвоте голову следует осторожно повернуть на бок; пальцем, обернутым платком или марлевой салфеткой, необходимо удалить остатки рвотных масс из полости рта и глотки, чтобы они не мешали свободному дыханию.
5. **Врачебный осмотр**, документированный в ИБ, должен включать:
 - ▶ основные показатели жизнедеятельности;
 - ▶ жалобы пациента и анамнез падения с обязательным указанием времени обнаружения пациента и времени осмотра;
 - ▶ описание внешних повреждений;
 - ▶ назначенные исследования (общий анализ крови, сахар крови, коагулограмма, ЭКГ и др.) и консультации (невролог, травматолог, хирург или другой специалист) в зависимости от ситуации;
 - ▶ назначенные и проведенные лечебные мероприятия, связанные с падением;
6. В первые 4 часа после падения необходимо контролировать основные показатели жизнедеятельности и оценивать неврологические симптомы каждые 30-60 минут.
7. Пациентов с высоким риском кровотечений (на химиотерапии, получающих антикоагулянты или антиагреганты и др.) и вероятностью отсроченной черепно-мозговой травмы необходимо наблюдать каждые 4-6 час. в течение 3 суток.

Протокол падения



Протокол падения

- ▶ В случае падения пациента дежурная медсестра с участием лечащего или дежурного врача заполняет рапорт о падении и в течение двух рабочих дней передает его старшей медсестре, которая визирует его у заведующего отделением.
- ▶ При необходимости к составлению рапорта привлекаются лица, ставших свидетелями падения, используются видеозаписи и листы наблюдения.
- ▶ Рапорт не является частью истории болезни и предназначен только для анализа безопасности пациентов в стационаре.
- ▶ Добросовестное и подробное описание события позволит в дальнейшем предусмотреть дополнительные меры по профилактике падений.

ФИО _____

Дата рождения _____ № палаты _____

Дата падения _____ время падения _____

Место падения _____

Кто обнаружил _____

В каком состоянии (без сознания, в сознании) _____

Версия падения персонала _____

Версия падения пациента _____

Визуальный осмотр (наличие видимых повреждений) _____

Жалобы пациента на болевое ощущение: да / нет

Если да: локализация боли: _____

Характер боли (при движении, в покое, при прикосновении) _____

Принятые меры (вызов помощи, госпитализация) _____

Комментарии: _____

Подпись медсестры _____



Поддержание гигиены тела пациента. Утренний туалет

Обязанностью медицинского сообщества является удовлетворение базовых потребностей человека



Рис. 1. Пирамида Маслоу

Общие понятия



Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни.

Личная гигиена (индивидуальная) – раздел гигиены, изучающий вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в его личной жизни и деятельности, разрабатываются и проводятся мероприятия гигиенического воспитания, пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни в целях повышения гигиенической культуры населения.

В прикладном смысле, **личная гигиена** – это комплекс мер, направленных на поддержание чистоты тела и уход за ним.



Возможные последствия длительного постельного режима



- пролежни;
- атрофия мышц;
- запоры;
- мышечные контрактуры;
- почечные камни;
- застойные пневмонии;
- недержание мочи;
- гингивиты, стоматиты, парадонтоз;
- ухудшение слуха;
- синуситы;
- депрессивные состояния.



Принципы ухода за тяжелобольным



Цель помощи – помощь в поддержании гигиены тела, профилактика развития инфекционных и трофических осложнений, обеспечение комфорта.

Принципы ухода

**Безопас-
ность**

предупреждение
травматизма
пациента

**Конфиден-
циальность**

подробности
личной жизни не
должны быть
известны
посторонним

**Уважение
чувства
достоинства**

выполнение всех
процедур с согласия
пациента,
обеспечение
удинения , если
необходимо

Общение

расположение
пациента и членов
его семьи к беседе,
обсуждение хода
предстоящей
процедуры и плана
ухода в целом

**Независи-
мость**

поощрение
каждого пациента
к
самостоятельности

**Инфекцион-
ная
безопасность**

осуществление
соответствующих
мероприятий

Рекомендации по уходу за тяжелобольным



Рекомендации при дефиците личной гигиены больного:

- оценить способность самоухода;
- уточнить степень участия и предпочтения;
- побуждать и поощрять пациента на самостоятельные действия;
- оказать помощь пациенту в проведении туалета тела;
- помощь при подмывании, мытье головы;
- своевременная смена нательного и постельного белья.

Общие рекомендации по уходу за тяжелобольным

- Больной – остается личностью со своим характером и интересами!
- Поместите, если возможно, больного в отдельную комнату или выделите ему место у окна;
- Доступ к кровати со всех сторон;
- Рядом с постелью кроватью поставить тумбочку и стул;
- Звонок вызова медсестры в зоне досягаемости;
- Застежки и завязки одежды больного должны быть спереди;
- Проветривайте комнату больного 5–6 раз в день в любую погоду на 15–20 минут, укрыв больного;
- Активизация пациента (при возможности)

- Гигиенический уход за тяжелобольными проводится утром, а также после приема пищи и при загрязнении тела.
- Периодически должны быть организованы стрижка и бритье больных.
- Чем тяжелее больной, тем сложнее за ним ухаживать, труднее выполнять любые манипуляции по уходу за полостью рта, ушами, глазами, носом и т.п.

Общий алгоритм ухода за тяжелобольным



**Учитывая
основные
принципы
ухода за
пациентом,
подготовка и
окончание
процедуры
включает
следующие
этапы**

Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры.

(объяснять необходимо в доступной для пациента форме, такой разговор помогает снять эмоциональное напряжение, создать доверительную обстановку, мотивирует пациента к сотрудничеству)

Получить согласие пациента на проведение процедуры.

(соблюдаются права пациента на информацию)

Обеспечить пациенту конфиденциальность (отгородить ширмой).

(соблюдение основных принципов ухода)

Вымыть и осушить руки.

(соблюдение инфекционной безопасности)

Подготовить необходимое оснащение.

Использовать перчатки

(соблюдение инфекционной безопасности)

Объем независимых сестринских вмешательств



- ▶ процедуры личной гигиены (смена постельного и нательного белья, гигиена кожи, утренний туалет);
- ▶ общая гигиена помещений (генеральная уборка процедурного кабинета, проветривание палат, кварцевание);
- ▶ удовлетворение физиологических потребностей (кормление пациента, прием адекватного количества жидкости);
- ▶ удовлетворение физиологических отпавлений (подача судна, мочеприемника);
- ▶ общение с пациентом, его родственниками по вопросам здорового образа жизни, личной гигиены, досуга.

Выбор метода мытья кожи



Использование тряпочек и емкостей (тазики) для мытья пациентов приводит к случаям ИСМП, так как они являются резервуаром для размножения бактерий с множественной лекарственной устойчивостью



Использование специальных одноразовых средств (салфетки, гели, пенки) не только предотвращают развитие ИСМП, но и ухаживают за кожей, обладая защитными и регенеративными свойствами



Умывание пациента



Целью умывания пациента является поддержание личной гигиены.

Показанием для этой процедуры будет дефицит или невозможность самоухода, а также тяжелое состояние пациента.

Оснащение:

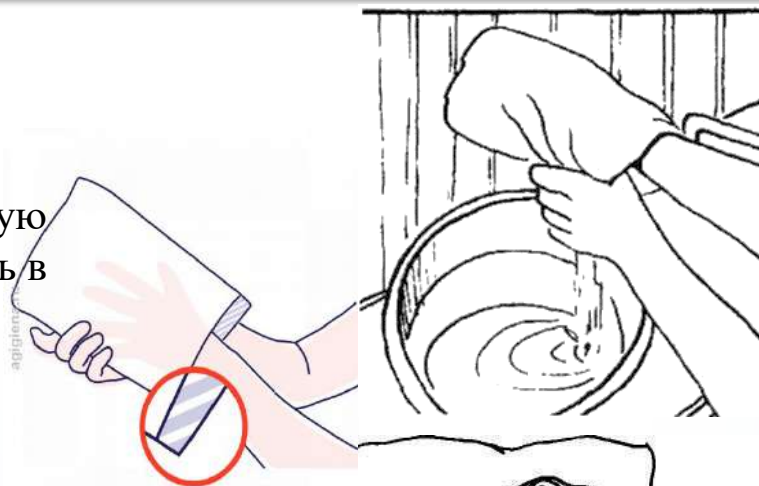
1. емкость с теплой ($35-37^{\circ}\text{C}$) водой,
2. полотенце,
3. махровая рукавичка,
4. клеенка,
5. пеленка.



Выполнение процедуры



1. Придать пациенту положение Фаулера, накрыть ему грудь пленкой;
2. Взять в руки полотенце (махровую рукавицу), половину его смочить в емкости с теплой водой, отжать;
3. Протереть лоб, веки, щеки, нос, подбородок, шею пациента
4. Осушить второй половиной полотенца лицо и шею пациента в той же последовательности мягкими промокательными движениями
5. Снять пленку с груди пациента, положить в мешок для использованного белья
6. Помочь пациенту занять удобное положение.
7. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно



Бритье



- ▶ Смочить салфетку в воде, отжать и положить её на щёки и подбородок пациента на 5-10 мин (или смочить лицо).
- ▶ Осмотреть лицо для выявления родинок, родимых пятен, очагов воспаления (эти места нужно «обходить»).
- ▶ Нанести на кожу лица крем или пену для бритья, равномерно распределить его с помощью помазка.
- ▶ Вести станок вниз, оттягивая кожу кверху; брить сначала одну щеку, потом под носом, затем другую щеку, под нижней губой и область шеи под подбородком.
- ▶ Смочить салфетку водой, отжать её и протереть кожу лица.
- ▶ Осушить кожу лица сухой салфеткой легкими промокательными движениями и смочить кожу лосьоном.
- ▶ Дать зеркало, чтобы пациент мог увидеть себя.

Уход за полостью рта и зубами



- Несвоевременная гигиена полости рта может привести к появлению запаха изо рта, воспалительным процессам: стоматиту, гингивиту, кариесу.
- Слизистая оболочка полости рта может быть раздражена или иметь налет у ослабленных и лихорадящих пациентов. Налет состоит из слизи, слущенных клеток эпителия, бактерий, разлагающихся остатков пищи.
- Ежедневный осмотр и проведение гигиенических процедур полости рта помогут создать и поддержать комфорт пациенту.



Если пациент в сознании

- оказать помощь в уходе за полостью рта

Если пациент беспомощен

- полоскание рта после каждого приема пищи / приступа рвоты;
- чистка зубов (зубных протезов) вечером и утром;
- очищение промежутков между зубами 1 раз в день (лучше вечером).

Уход за полостью рта



- ▶ **Часто пациенты без сознания не могут глотать слюну.** Скопление слюны провоцирует развитие бактериальных осложнений.
- ▶ Уход за полостью рта у таких больных необходимо каждые 2 ч
- ▶ **Выполнение процедуры:**
 1. Приготовить мягкую зубную щетку для чистки зубов / марлевую салфетку на зажиме или палочке.
 2. Салфеткой, смоченной в антисептическом растворе, протереть язык, снимая налет, в направлении от корня языка к его кончику.
 3. Салфеткой, смоченной в антисептическом растворе, протереть внутреннюю поверхность щек, пространство под языком, десны пациента. Повторить не менее 2-х раз.
 4. Сухими тампонами промокнуть ротовую полость пациента.
 5. При сухости языка смазать его стерильным глицерином.
 6. Обработать последовательно верхнюю и нижнюю губы тонким слоем вазелина (для профилактики трещин на губах).



Промывание полости рта



- ▶ Промывание полости рта проводят с помощью шприца, резинового баллона, кружки Эсмарха (предложена немецким врачом Фридрихом фон Эсмархом (1823-1908)) с резиновой трубкой и стеклянным наконечником.
- ▶ Порядок выполнения процедуры:
 1. Подготовиться к проведению процедуры: разложить необходимое оснащение, надеть перчатки.
 2. Набрать в кружку Эсмарха тёплый антисептический раствор и подвесить её на 1 м выше головы больного.
 3. Голову больного повернуть набок (иначе он может захлебнуться!), шею и грудь прикрыть клеёнкой, к подбородку подвести лоток.
 4. Оттянуть угол рта шпателем, ввести наконечник в преддверие рта и струёй жидкости под умеренным давлением промыть его.
 5. Промыть поочерёдно левое, затем правое защёчное пространство (щеку оттягивать шпателем).
 6. Аспирировать раствор с помощью электроотсоса (или самостоятельно пациент)
 6. Снять перчатки, вымыть руки.



Уход за зубами



- ▶ Для чистки зубов лучше использовать зубную пасту, содержащую фтор, укрепляющий эмаль зубов и препятствующий развитию кариеса.
- ▶ Зубная щетка должна быть мягкой, не травмирующей десну.
- ▶ Нитью для очищения промежутков между зубами нужно пользоваться, не прилагая значительных усилий, поскольку это может привести к повреждению десен и кровоточивости.
- ▶ Завершая уход за полостью рта, обязательно очистить щеткой язык, снимая с него налет, содержащий бактерии.
- ▶ При невозможности прополоскать рот, необходимо использовать аспиратор для удаления жидкостей.

Средства гигиены полости рта:

- Зубные щетки
- Зубочистки
- Флосс (зубная нить)
- Зубные пасты.
- Зубные эликсиры



Уход за зубными протезами



- Чистить протезы после каждого приема пищи и не реже 2-х раз в день;
- Очищать поверхность зубной щеткой с мягкой щетиной и специальной зубной пастой (или детским мылом);
- Не реже 2 раз в неделю необходима обработка специальными дезинфицирующими средствами;
- Замачивать протезы на ночь в отдельной емкости;
- Не использовать горячую воду;
- Не высушивать протезы;
- Позволить в течение дня находиться в протезе (лучше дикция)



Обработка полости рта Pagavit/Пагавит



Пагавит — стерильные ватные палочки для ухода за ротовой полостью.

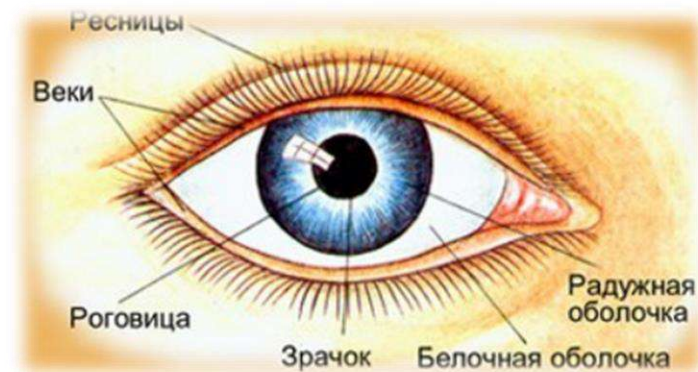
Пропитаны глицерином, лимонной кислотой, натуральным экстрактом лимона и 0,1% -м натрием бензоатом.

Применяются для ухода за пациентами без сознания, после тяжёлых операций, при лихорадке, при дефиците самоухода.

Оптимальны для ухода за полостью рта пациентов с брекетами, а также для увлажнения ротовой полости пациентов перед и после операций.



Уход за глазами

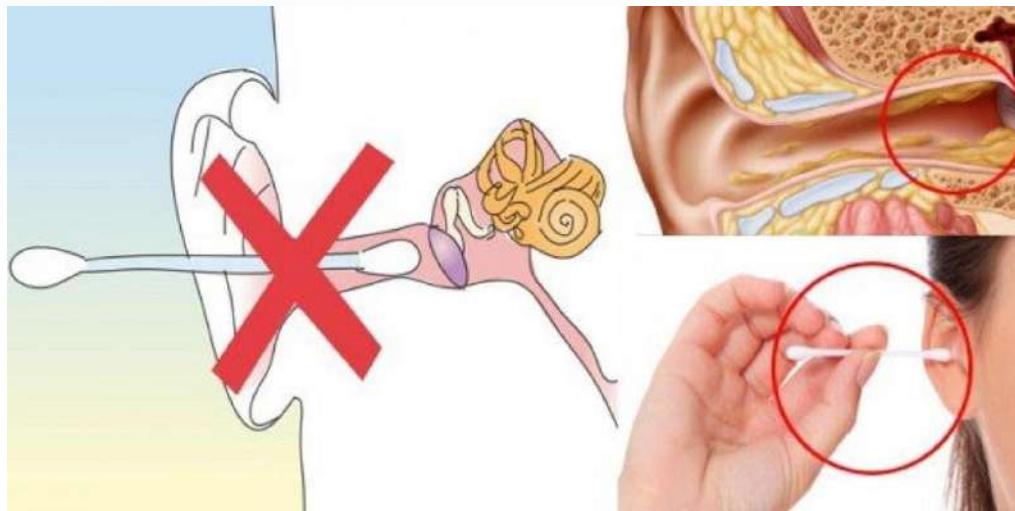
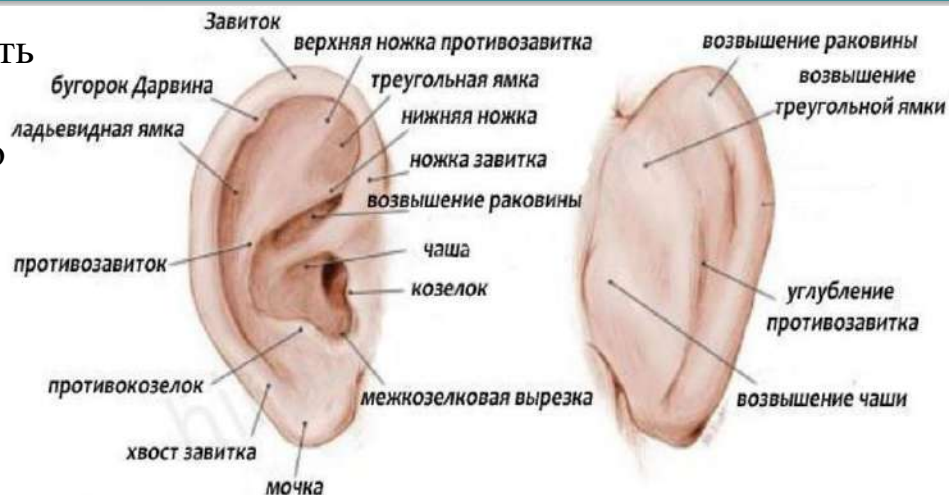


- Туалет глаз осуществляется не реже 2 раз в день и при необходимости (выделения);
- Используются салфетки (тампоны) с водорастворимым раствором антисептика;
- Отдельные салфетки (4 – 6) для каждого глаза;
- Направление движений «от уха к носу»

Уход за ушами



- Избыточное количество серы может образовывать серные пробки (шум в ушах, снижение слуха).
- **Уход за здоровыми ушами** требует регулярного мытья ушной раковины и наружного слухового прохода теплой водой с мылом.
- Нельзя чистить наружный слуховой проход острыми предметами, которые могут повредить барабанную перепонку или стенку слухового прохода (в т.ч. ватной палочкой).
- Серную пробку удаляет врач.

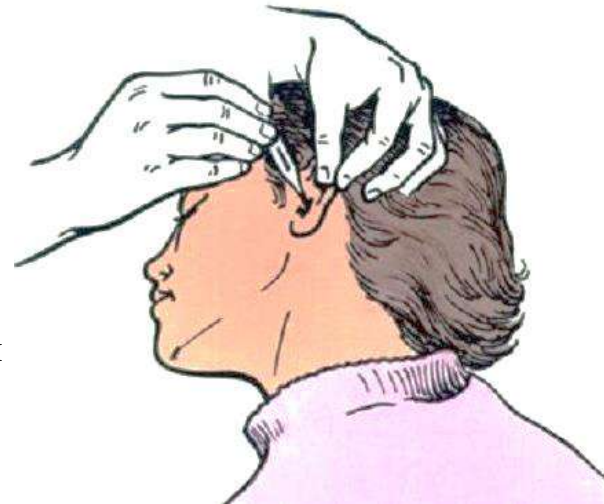


Уход за ушами



► Выполнение процедуры

1. Помочь пациенту занять удобное положение.
2. Прикрыть его шею и плечо полотенцем
3. Надеть перчатки
4. Попросить пациента наклонить голову в сторону, противоположную обработке
5. Набрать в пипетку 3 % раствор перекиси водорода. Оттянуть левой рукой ушную раковину назад и вверх. Правой рукой закапать в наружный слуховой проход 2—3 капли. Оставить пациента в таком положении на 1—2 мин.
6. Ввести в слуховой проход вращательными движениями сухую турунду, оттянув при этом ушную раковину назад и вверх. Вывести турунду обратно.
7. Повторить процедуру несколько раз, меняя турунды
8. Обработать влажным тампоном, смоченным в теплой воде, ушную раковину, затем тщательно просушить ее сухими ватными тампонами. Сбросить использованные тампоны в лоток для последующей утилизации
9. Обработать другое ухо таким же образом
10. Помочь пациенту занять положение, удобное для пребывания в постели.
11. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно



Уход за слуховым аппаратом

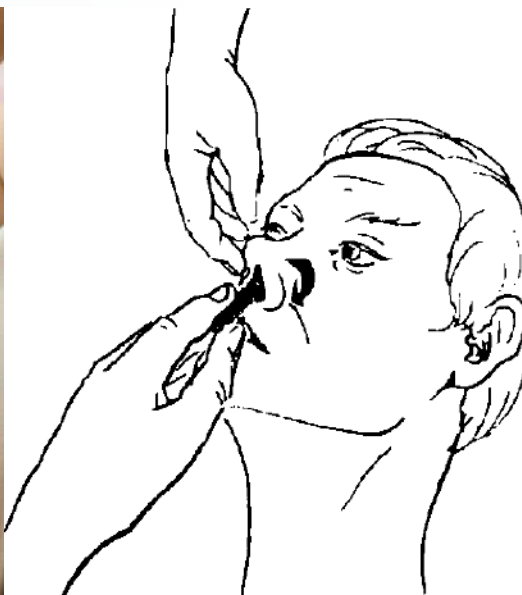
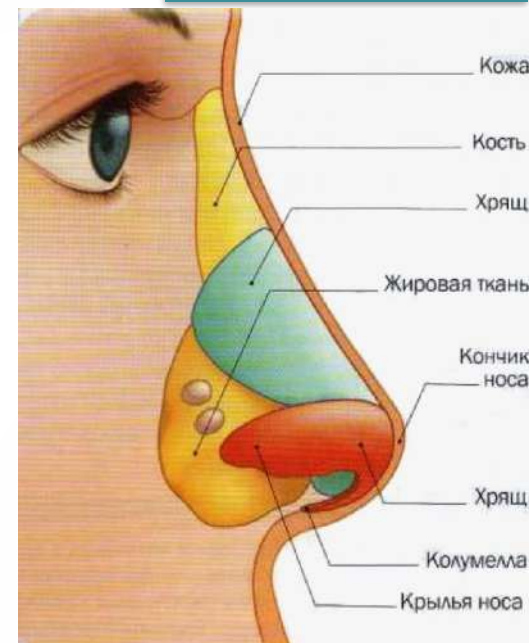


- Протирайте слуховые аппараты мягкой сухой тканью.
- Не мойте слуховые аппараты водой или другими жидкостями.
- Протирать антисептиками категорически запрещается!
- Для просушки используйте специальные сушильные камеры.
- Выключайте аппараты, когда пациент их не использует.
- Следить за чистотой фильтров микрофона.
- Не подвергайте слуховые аппараты воздействию высоких температур и повышенной влажности.
- Ежедневно очищать слуховые аппараты от ушной серы.
- Не оставляйте слуховые аппараты рядом с источниками тепла, **рентгеновского и электромагнитного излучения.**
- На ночь снимайте слуховой аппарат.

Уход за носом



- ▶ Не реже 1 раза в день.
- ▶ Объяснить пациенту цель процедуры, получить согласие;
- ▶ Взять турунду пинцетом, смочить в вазелиновом масле / глицерине, слегка отжать.
- ▶ Ввести вращательными движениями в носовой ход на 4-6 см на 1-3 минуты, приподнимая кончик носа пациента.
- ▶ Извлечь турунду вращательными движениями из носового хода.



При выраженной ринорее аспирация по Зондерману или Пройду



Уход за волосами



► Необходимо расчёсывать волосы несколько раз в день. Щётка или расческа должны быть с затупленными, лучше редкими зубьями, чтобы не поранить голову и не причинить боль.

► Легче расчёсывать волосы, когда пациент сидит. Расчёсывая лежачего пациента следует повернуть его голову в одну, затем в другую сторону.

► Не реже 1 раза в неделю необходимо мыть голову и волосы.



Стрижка волос



► Необходимое оснащение:

1. Ножницы, машинка для стрижки волос.
2. Таз для сжигания волос, спички.
3. Спиртовой раствор антисептика.

► Порядок выполнения процедуры:

1. Подготовиться к проведению санитарно-гигиенической обработки: разложить необходимое оснащение.
2. Постелить на табуретку (кушетку) клеёнку, усадить на неё больного и покрыть ему плечи полиэтиленовой пелёнкой.
3. Снять волосы машинкой для стрижки волос, при кожном заболевании волосистой части головы — остричь волосы над подготовленным тазом.
4. Сжечь волосы / утилизировать в отходы класс Б.
5. Обработать ножницы, бритву.



Уход за ногтями



Больные еженедельно должны стричь ногти на пальцах рук и не реже 2 раз в месяц на пальцах ног.

1. Добавить в лоток с тёплой водой жидкое мыло и опустить в него на 2–3 мин кисти / стопы пациента (поочерёдно по мере обрезки ногтей).
2. Поочерёдно извлекая пальцы пациента из воды, вытирать их и аккуратно подрезать ногти.
3. Обработать руки / стопы пациента кремом.
4. Протезинфицировать ножницы и щипчики раствором антисептика.



Руки



Ноги



Уход за промежностью



- ▶ Использование индивидуальных / одноразовых гигиенических средств;
- ▶ Чрезмерное увлечение мылом и сильное трение кожи наружных половых органов могут привести к возникновению воспалительных процессов кожи;
- ▶ Мыть гениталии достаточно 2 раза – утром и вечером, а также после опорожнения (у женщин – после каждого мочеиспускания).
- ▶ Естественные складки у тучных людей при увлажнении обрабатывают присыпкой, при сухости кожи используют увлажняющий крем.



ООО "Медика-Крым"



Уход при ограниченной подвижности



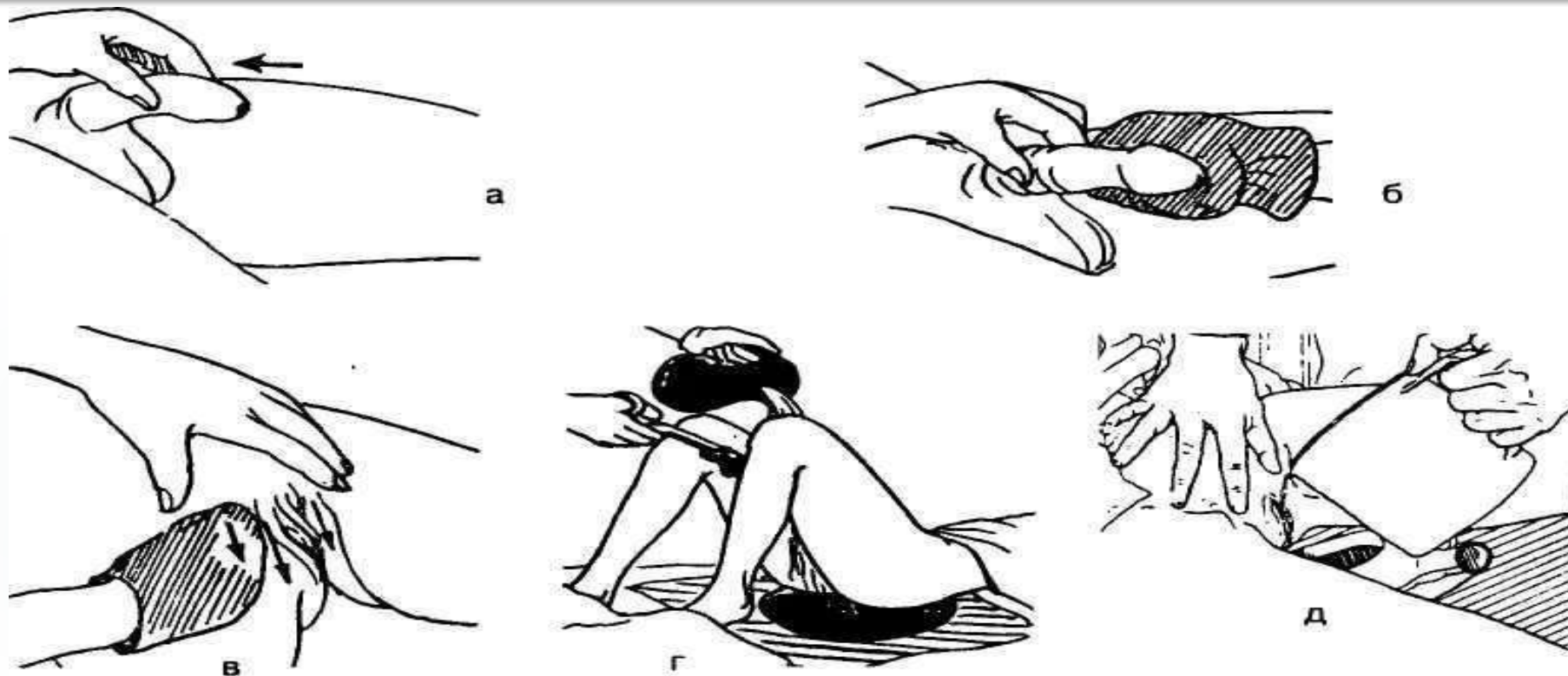
д



е



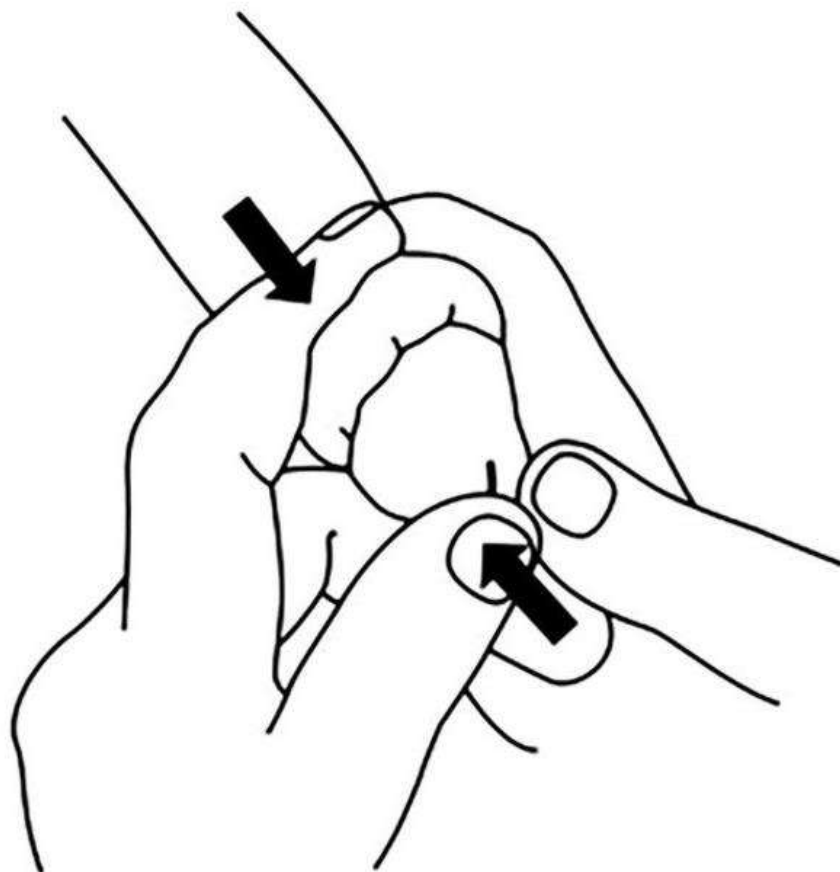
Уход за промежностью: мужчины



▶ Аккуратно отодвинув пальцами левой руки крайнюю плоть, обнажают головку полового члена, **обрабатывают** его, а также кожу полового члена, мошонку, паховые складки, область заднего прохода, межъягодичную складку, меняя салфетки по мере загрязнения. Просушивание проводят в той же последовательности.

▶ От мочеиспускательного канала к мошонке

Профилактика парафимоза и баланопостита



Уход за промежностью: женщины



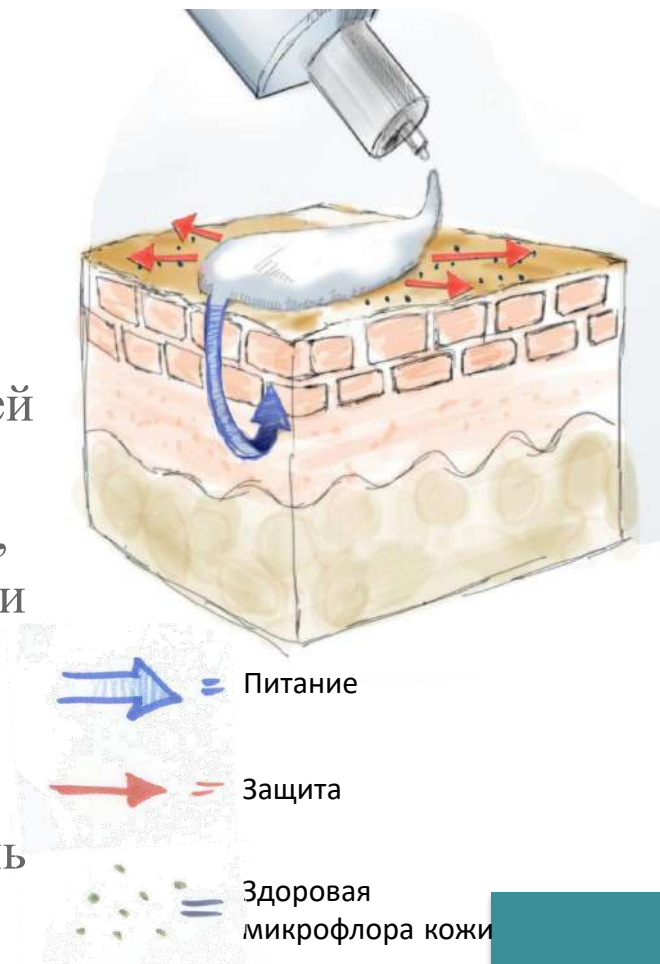
- ▶ Пациентке приподнимают таз, под крестец подкладывают судно, оставляют, прикрыв одеялом;
- ▶ Для гигиенических мероприятий необходимо встать сбоку, взяв в одну руку емкость с теплой водой, а в другую руку – зажим с марлевым тампоном (салфеткой).
- ▶ Поливая из емкости на половые органы, следует последовательно обрабатывать их по направлению от лобка к анальному отверстию: область лобка, наружные (большие) половые губы, паховые складки, промежность, область анального отверстия, межъягодичную складку.
- ▶ Салфетки меняют по мере загрязнения.
- ▶ По окончании процедуры части тела просушивают марлевыми салфетками (тампонами) в той же последовательности.



Уход за промежностью



- Проводится ежедневно, по мере загрязнения, регулярно, но не менее двух раз в день;
- Проводится с целью предотвращения развития пролежней, контактного дерматита ассоциированного с недержанием мочи и кала;
- Проводится с помощью профессиональных средств, медицинских изделий для ухода за кожей
- Используется абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки), подгузники, впитывающие трусы, урологические прокладки и вкладыши и др.), препятствующие увлажнению кожи, уменьшающие ее инфицированность при недержании мочи и кала.
- 3 подгузника в течение дня и 1 подгузник на ночь с последующей бережной гигиенической процедурой



Последовательность одевания подгузника на больного



Уход за кожей



- ▶ **Очистка;**
- ▶ **Стимуляция кровообращения;**
- ▶ **Гигиенический и эмоциональный комфорт.**

- Умывать лицо не реже 2-х раз в день – утром и вечером.
- Мытье головы, душ или ванна (если возможно) – 1 раз в неделю.
- Влажное обтирание кожи – ежедневно не реже 3-х раз в день.
- Мытье рук – перед каждым приемом пищи.
- Мытье ног – не реже 1 раза в 3 дня.



вода доходила

больной мог упереться

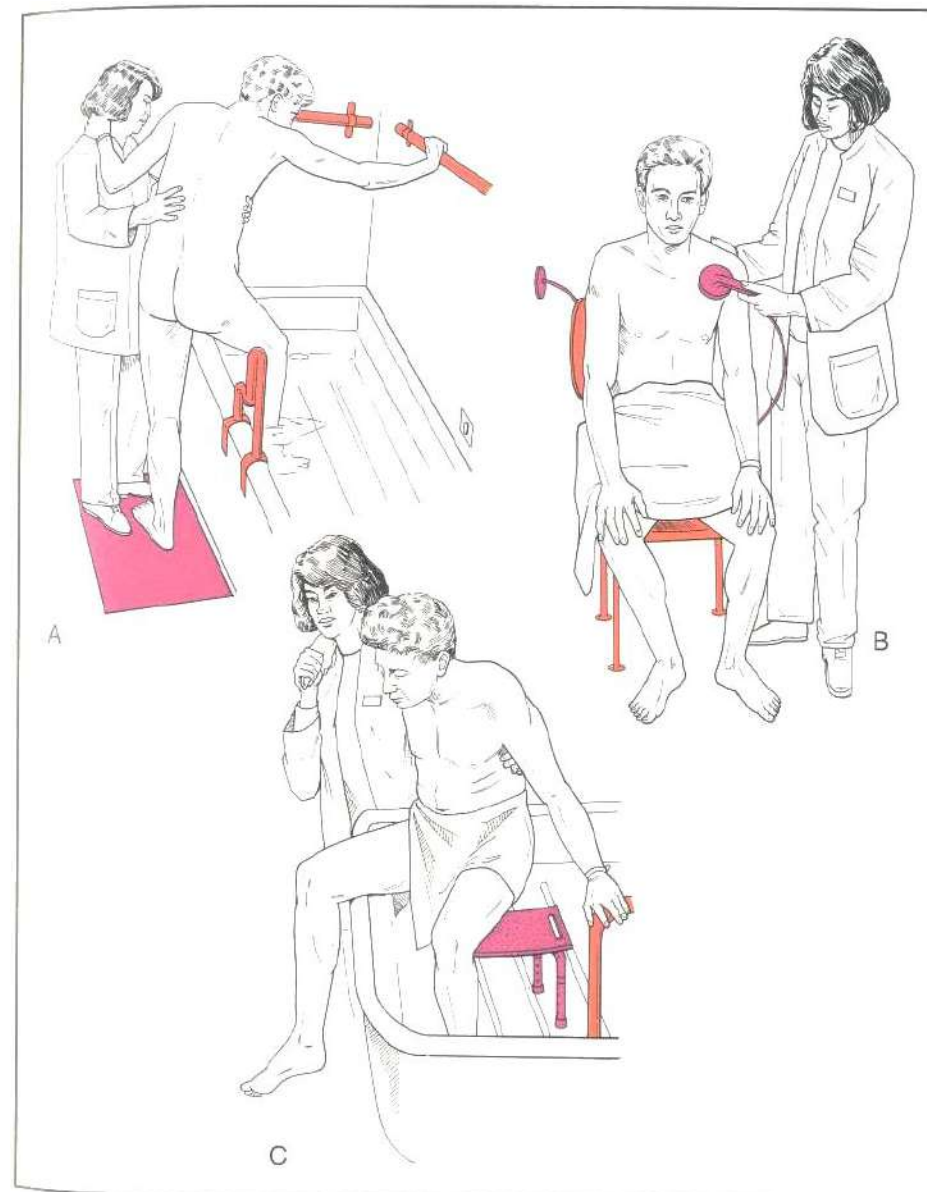
1. Придать больному положение в ванне полусидя так, чтобы до верхней трети его груди;
2. В ножной конец ванны поставить деревянную подставку, чтобы в неё ногами, не скатился и не соскользнул.
3. Если больной не может мыться самостоятельно, вымыть его в последовательности: **голова – туловище – руки – паховая область – промежность – ноги.**
4. Помочь пациенту выйти из ванны, вытереть его в том же порядке.
5. Одеть пациента в чистую одежду.
6. Обработать ванну дезинфицирующим средством, дезинфицировать мочалку.



Гигиенический душ



1. Помочь пациенту раздеться и усадить его на табурет (скамеечку) в душевой кабинке (ванне), поддерживая под локти.
2. Если больной не может мыться самостоятельно, вымыть его, используя индивидуальные мыло и мочалку, в такой последовательности: **голова – туловище – руки – паховая область – промежность – ноги.**
3. Помочь пациенту выйти из душевой кабинки (ванны), вытереть его в том же порядке.
4. Одеть пациента в чистую одежду.
5. Обработать душевую кабину (ванну) дезинфицирующим средством, дезинфицировать мочалку.



Уход за естественными складками



- ▶ **Мацерация кожи** - размягчение и разрыхление тканей вследствие действия на них жидкости.
- ▶ **Опрелость** — воспаление кожи в складках, возникающее при трении влажных поверхностей.
- ▶ Развиваются под молочными железами, в межягодичной складке, подмышечных впадинах, между пальцами ног при повышенной потливости, в паховых складках.
- ▶ Их появлению способствует избыточное выделение кожного сала, недержание мочи.
- ▶ При опрелости кожа краснеет, её роговой слой как бы размокает и отторгается, появляются мокнущие участки с неровными контурами, образуются трещины.



Опрелости



Здоровая кожа

Легкая опрелость

**1 стадия -
эритема**



Умеренная опрелость

Средняя опрелость

**стадия -
мокнутие**



Тяжелая опрелость

Тяжелая опрелость

**3 стадия -
эрозия**



Профилактика опрелостей



- ▶ Поддержание оптимальной температуры в палате – не выше +22 0 С.
- ▶ Проветривание.
- ▶ Использование чистого, сухого х/б белья.
- ▶ Регулярный туалет кожи тёплой водой
- ▶ Подмывание после каждого мочеиспускания и дефекации.
- ▶ Воздушные ванны для складок кожи, прокладки между пальцами ног или рук.
- ▶ При недержании мочи и /или кала применять подгузники и регулярно их менять.





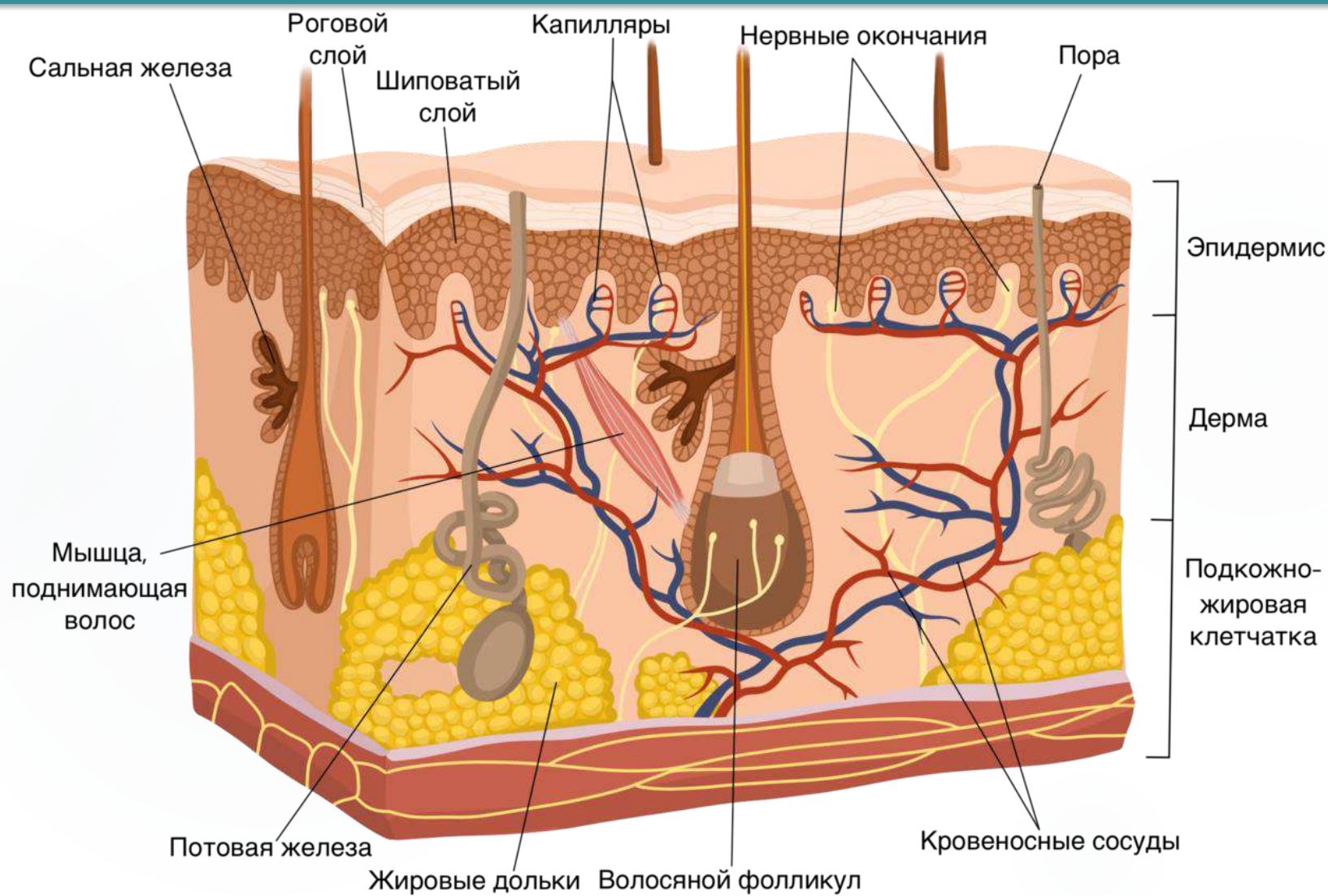


ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

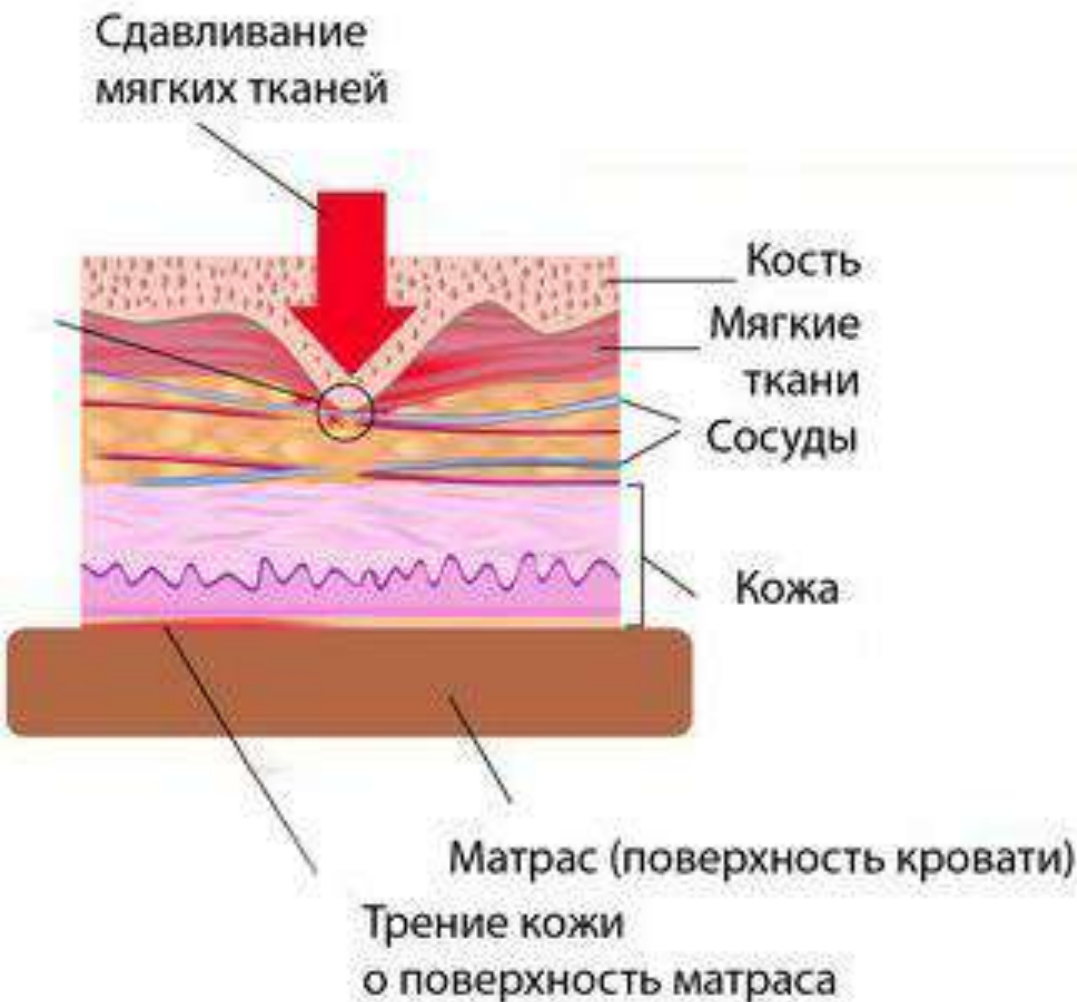


Профилактика пролежней

Строение кожи

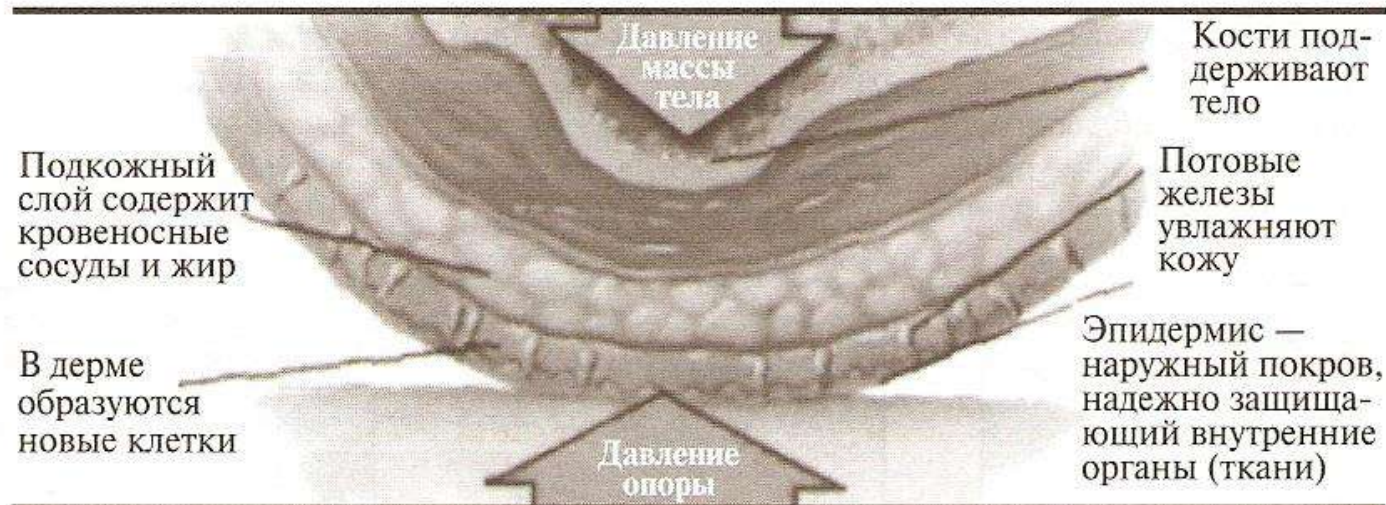


Пролежень

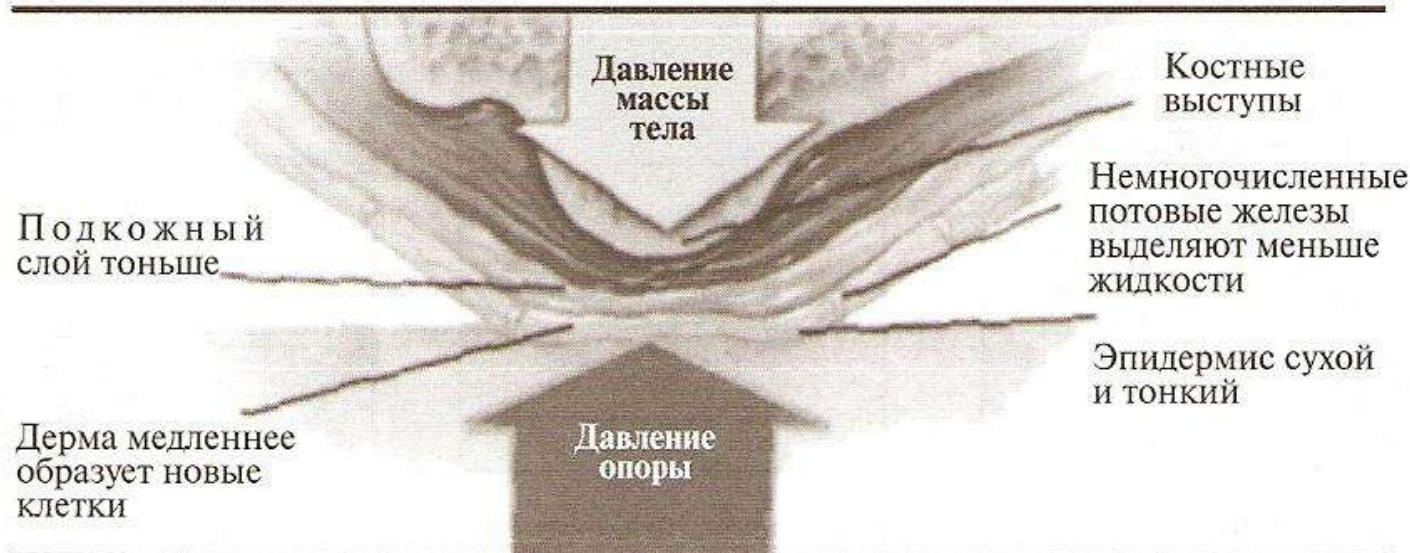


- лат.- **decubare** – лежать
- дистрофические, язвенно-некротические изменения мягких тканей, в результате их длительного сдавливания.
- Пролежень возникает в результате локальной недостаточности кровоснабжения (ишемии) и обусловленной этим смертью клеток (некрозом).
- Непрерывное давление 70 мм рт.ст. в течение 2 часов вызывает необратимые изменения в тканях.

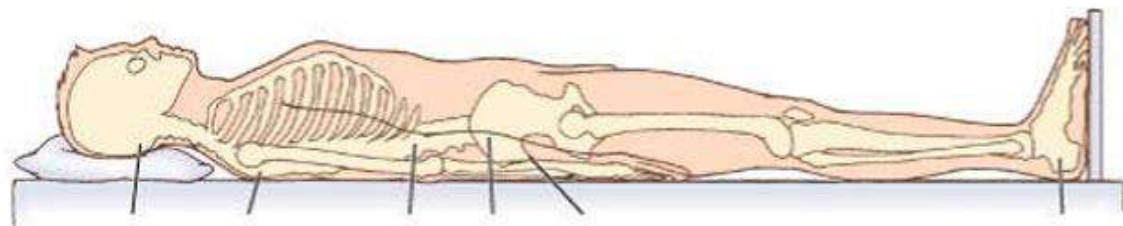
ЗДОРОВАЯ КОЖА



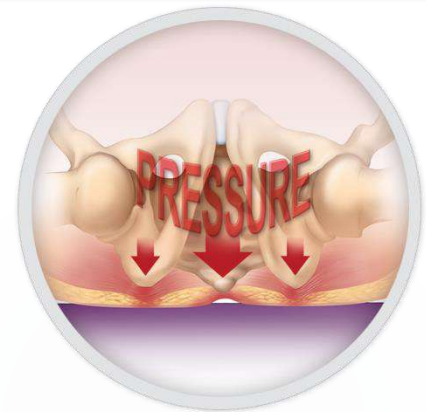
ХРУПКАЯ КОЖА



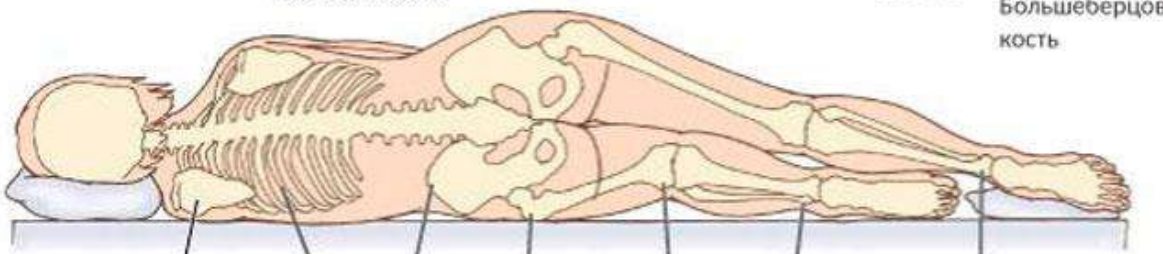
Места возникновения пролежней



Затылок Лопатка Позвоночник Крестец и копчик



Лобная кость Нижняя челюсть Грудина Костные выступы таза Коленная чашечка Большеберцовая кость



Лопатка Рёбра Гребень подвздошной кости Большой вертел бедренной кости Наружная лодыжка Наружная поверхность коленного сустава Внутренняя лодыжка



Лопатки

Ягодицы

Подушечки пальцев

Пятки

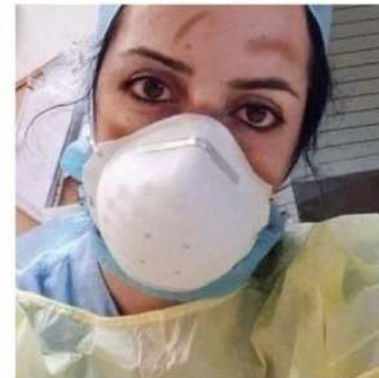
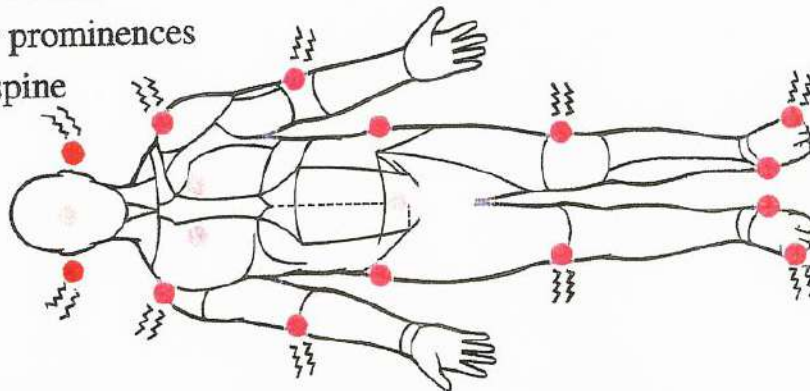


SKIN ALERT

Stop, Check, Document

Heels
Occiput
Toes
Sacrum
Posterior buttock
Over bony prominences
Thoracic spine
Scapula

STOP
CHECK HOT SPOTS
INFORM
DOCUMENT



Стадии пролежней

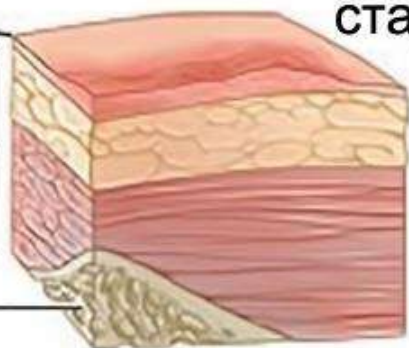


кожа

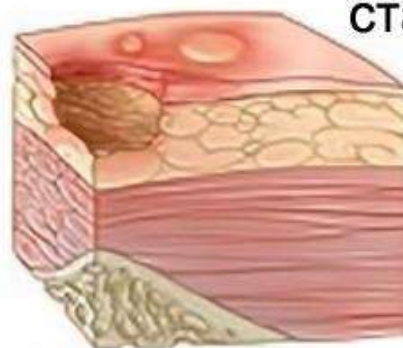
мягкие
ткани

кость

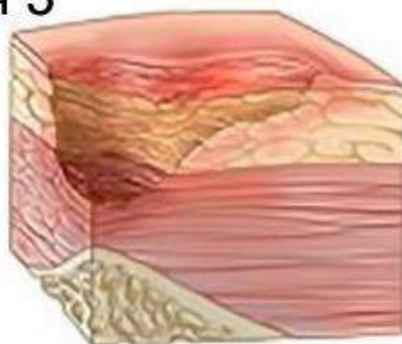
стадия 1



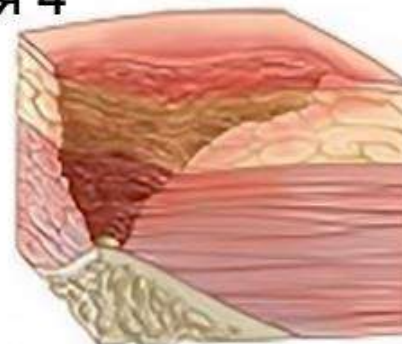
стадия 2



стадия 3



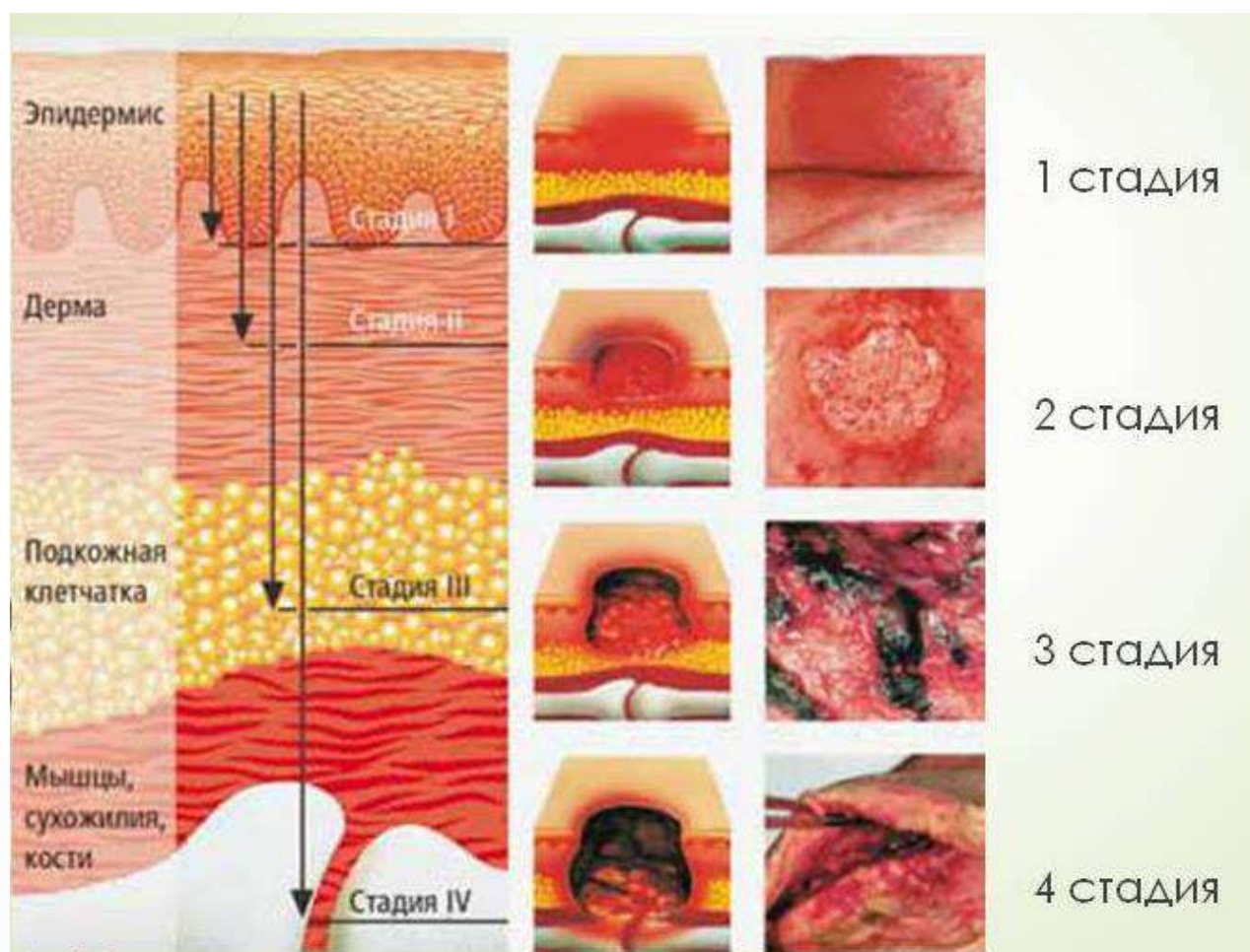
стадия 4



Клиника развития пролежней



- ▶ **1 стадия:** устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены.
- ▶ **2 стадия:** стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное (неглубокое) нарушение целостности кожных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку.
- ▶ **3 стадия:** разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу; могут быть жидкие выделения из раны.
- ▶ **4 стадия:** поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в которой видны сухожилия и/или костные образования.

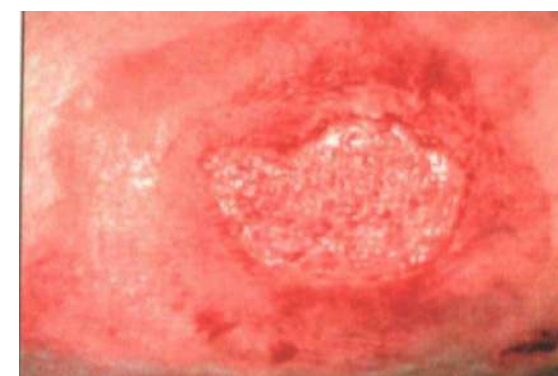


1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия



Внутренние факторы риска



↙ **обратимые**

истощение
ограничение подвижности
анемия
недостаточное употребление
протеина, аскорбиновой кислоты
обезвоживание
гипотензия
недержание мочи и/или кала
неврологические расстройства (сенсорные, двигательные)
нарушение периферического кровообращения
истонченная кожа
беспокойство
спутанное сознание
кома

↘ **необратимые**

{ старческий возраст



Внешние факторы риска

обратимые

плохой гигиенический уход
складки на постельном и\или
нательном белье
поручни кровати
средства фиксации пациента
травмы позвоночника, костей таза,
органов брюшной полости
повреждения спинного мозга
неправильная техника перемещения пациента в кровати
применение цитостатических лекарственных средств

необратимые

обширное
хирургическое
вмешательство
продолжительностью
более двух часов

Риски развития пролежней шкала Norton (Нортон) – 1962



Физическое состояние	Хорошее – 4	Удовлетворительное – 3	Плохое – 2	Очень плохое – 1
Душевное состояние	Ясное – 4	Безучастное – 3	Спутанное сознание – 2	Ступор – 1
Активность	Ходит без помощи – 4	Ходит с помощью – 3	Инвалидное кресло – 2	Лежачий – 1
Подвижность	Полная – 4	Немного ограниченная – 3	Значительно ограничена – 2	Отсутствует – 1
Недержание	Нет – 4	Иногда – 3	Моча -2	Моча и кал – 1

14 баллов и ниже – риск развития пролежней

Шкала Ватерлоо (Waterlow) – 1985



Телосложение: масса относительно роста		Тип кожи	
Среднее	0	Здоровая	0
Выше среднего	1	Папиросная бумага	1
Ожирение	2	Сухая	1
Ниже среднего	3	Отечная	1
Пол		Липкая (повышенная температура)	1
Мужской	1	Изменение цвета	2
Женский	2	Трещины, пятна	3
Возраст		Особые факторы риска	
14-49	1	Нарушение питания кожи (кахексия)	8
50-64	2	Сердечная недостаточность	5
65-74	3	Болезни периферических сосудов	5
75-81	4	Анемия	2
Более 81	5	Курение	1

Шкала Ватерлоо (продолжение)



Недержание		Аппетит	
Полный контроль, через катетер	0	Средний	0
Периодическое	1	Плохой	1
Через катетер, недержание кала	2	Питательный зонд, только жидкости	2
Кала и мочи	3	Не через рот, анорексия	3
Подвижность		Неврологические расстройства	
Полная	0	Диабет, инсульт, множественный склероз	4,5,6
Беспокойный, суетливый	1	Обширное оперативное вмешательство	
Адаптивный	2	Более 2 часов на столе	5
Ограниченная подвижность	3	Ортопедическое (ниже пояса, позвоночник)	5
Иннертный	4	Лекарственная терапия	
Прикован к креслу	5	Цитостатические препараты	4
		Высокие дозы стероидов	4
		Противовоспалительные	4

Оценка по шкале Ватерлоо



- ▶ нет риска 1 – 9 баллов;
- ▶ есть риск 10 баллов;
- ▶ высокая степень риска 15 баллов;
- ▶ очень высокая степень риска 20 баллов.



Оказание помощи. Вопросы профилактики



Приложение к приказу
Минздрава России
от 17.04.02 № 123

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Протокол ведения больных.
Пролежни (I.89)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56819—
2015

НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

Общие подходы к профилактике пролежней:

1. своевременная диагностика риска развития пролежней
2. своевременное начало выполнения всего комплекса профилактических мероприятий
3. адекватная техника выполнения простых медицинских услуг, в т. ч. по уходу.

Направления профилактических мероприятий



- ▶ уменьшение давления на костные ткани;
- ▶ предупреждение трения и сдвига тканей во время перемещения пациента или при его неправильном размещении («сползание» с подушек, положение «сидя» в кровати или на кресле);
- ▶ наблюдение за кожей над костными выступами;
- ▶ поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности (не слишком сухой и не слишком влажной);
- ▶ обеспечение пациента адекватным питанием и питьем;
- ▶ обучение пациента приемам самопомощи для перемещения;
- ▶ обучение близких.

Размещение в кровати



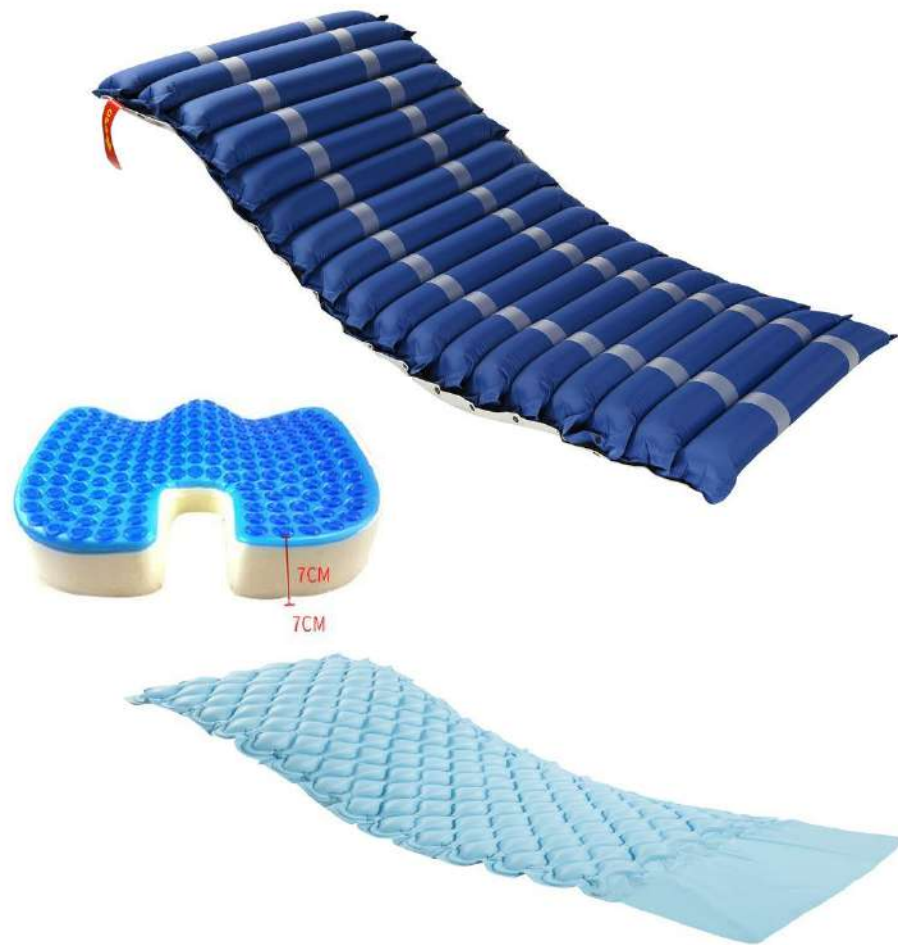
- ▶ Кровать – функциональная;
- ▶ Поручни с обеих сторон;
- ▶ Устройство для приподнимания изголовья кровати;
- ▶ Специальный матрац: не панцирная сетка;
- ▶ Высота кровати должна быть на уровне середины бедер ухаживающего за пациентом.
- ▶ Пациент, перемещаемый или перемещающийся в кресло, должен находиться на кровати с изменяющейся высотой, позволяющей ему самостоятельно, с помощью других подручных средств перемещаться из кровати.



Противопролежневый матрац



- ▶ Выбор зависит от степени риска развития пролежней и массы тела пациента.
- ▶ При низкой степени риска может быть достаточно поролонового матраца толщиной 10 см.
- ▶ При более высокой степени риска, а также при имеющихся пролежнях разных стадий нужны другие матрацы.
- ▶ При размещении пациента в кресле (кресле-каталке) под ягодицы и за спину помещаются поролоновые подушки, толщиной 10 см.
- ▶ Под стопы помещаются поролоновые прокладки, толщиной не менее 3 см
- ▶ Постельное белье – хлопчатобумажное.
- ▶ Одеяло – легкое.



Под уязвимые участки необходимо подкладывать валики и подушки из поролона.



Изменение положения тела



осуществлять каждые 2 часа, в т. ч. в ночное время, по графику:

- ▶ низкое положение Фаулера,
- ▶ положение «на боку»,
- ▶ положение Симса,
- ▶ положение «на животе» (по согласованию с врачом).
- ▶ Положение Фаулера должно совпадать со временем приема пищи.

Сестринские вмешательства	Кратность
1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не менее 1 раза в день (утром) по шкале Ватерлоу	Ежедневно 1 раз
2. Изменение положения пациента каждые 2 часа: 8-10 ч. – положение Фаулера;	Ежедневно 12 раз
10-12 ч. – положение «на левом боку»;	
12-14 ч. – положение «на правом боку»;	
14-16 ч. – положение Фаулера;	
16-18 ч. – положение Симса;	
18-20 ч. – положение Фаулера;	
20-22 ч. – положение «на правом боку»;	
22-24 ч. – положение «на левом боку»;	
0-2 ч. – положение Симса;	
2-4 ч. – положение «на правом боку»;	
4-6 ч. – положение «на левом боку»;	
6-8 ч. – положение Симса	

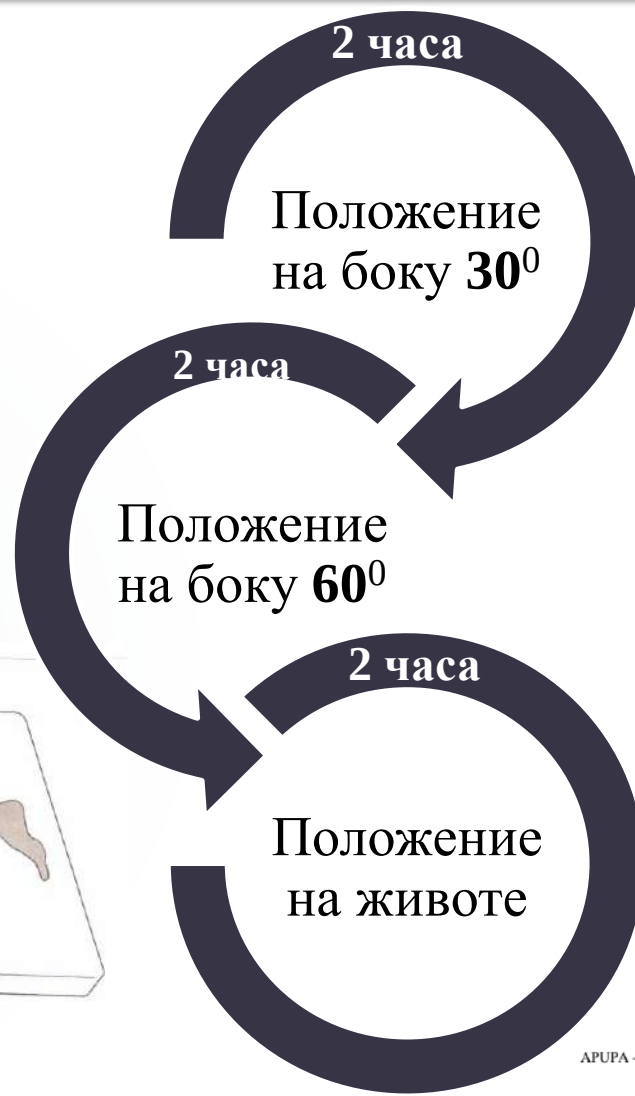
Обеспечение подвижности



на боку в 30°



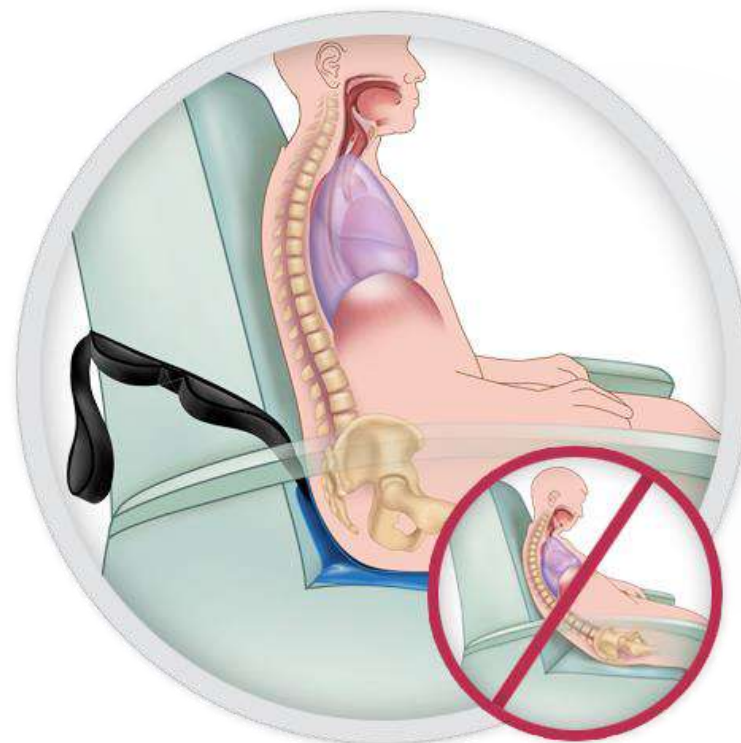
положение Симса



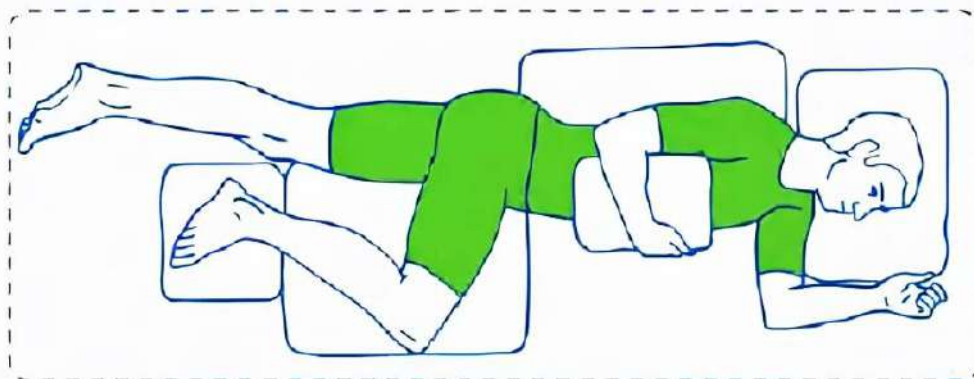
на боку в 60°

Положение пациентов на боку в 90° **НЕДОПУСТИМО**

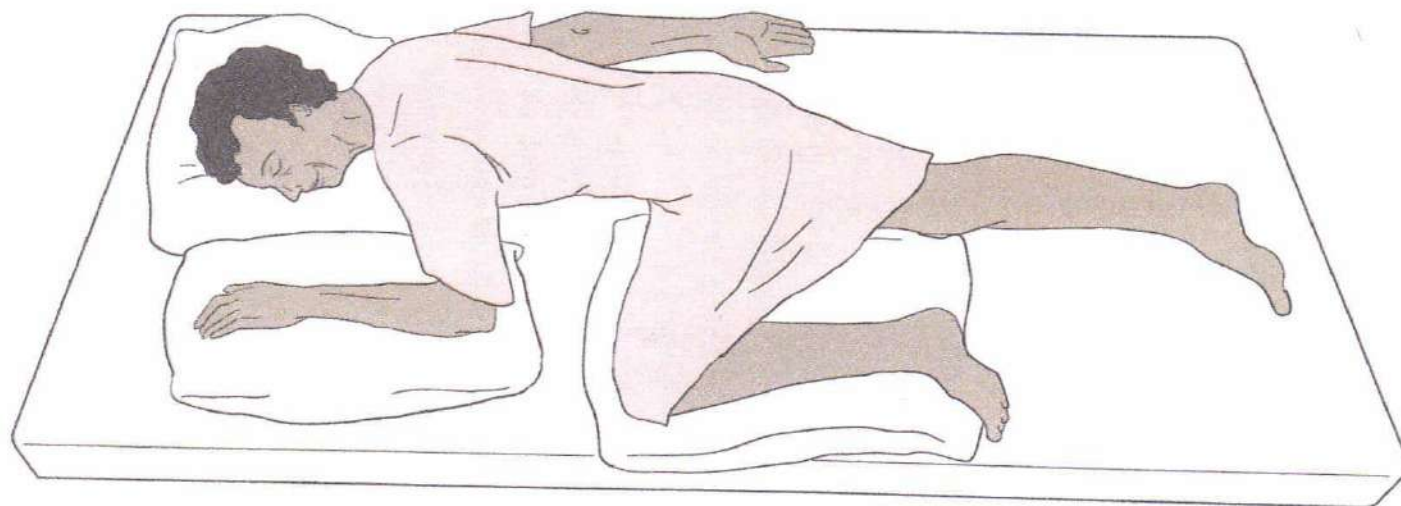
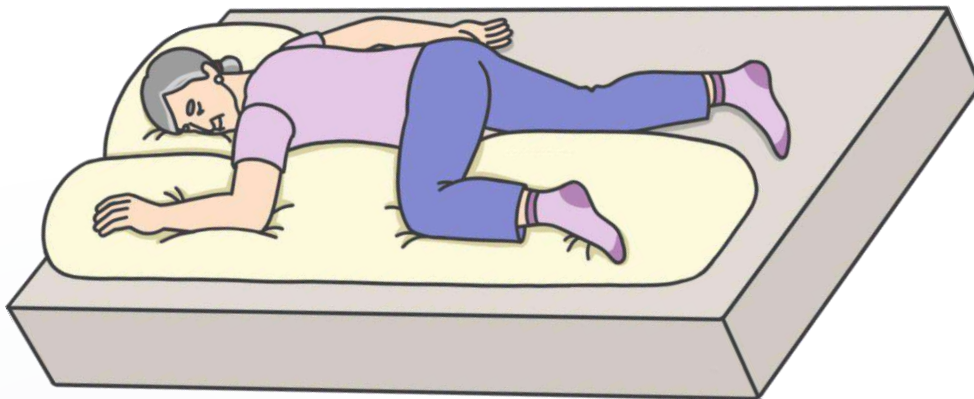
Положение Фаулера



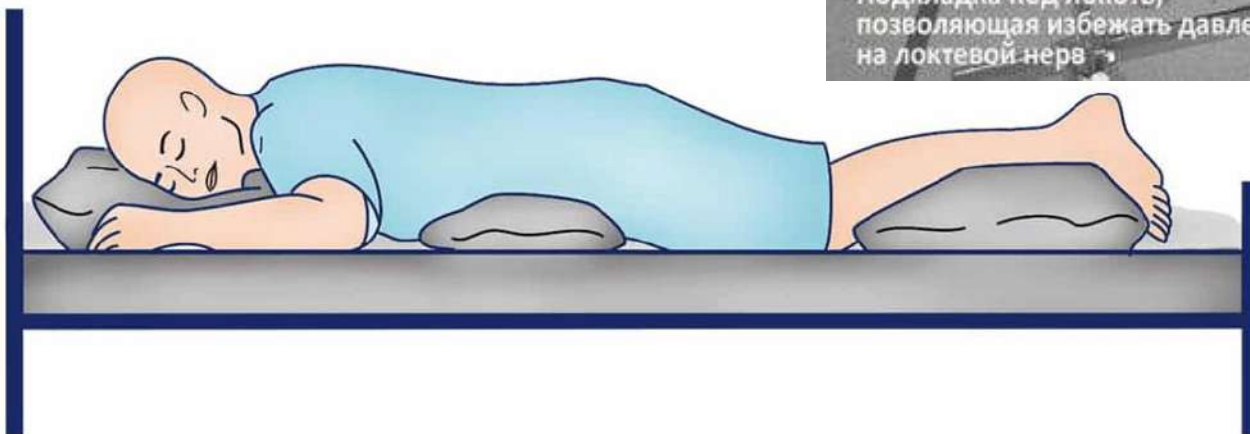
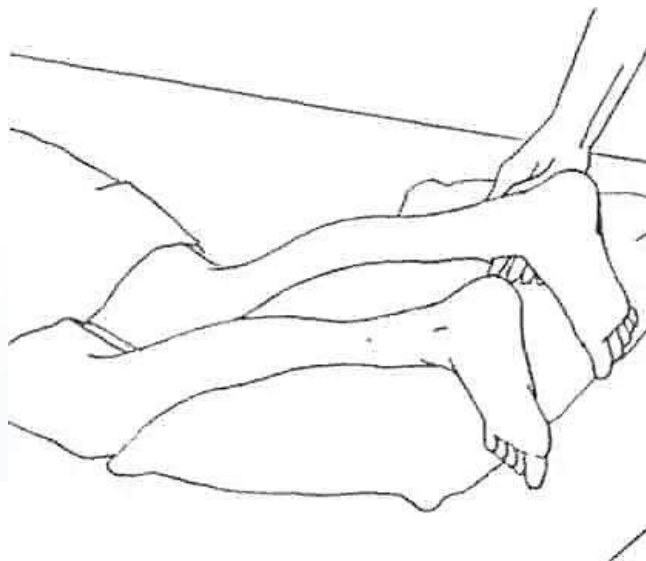
Положение на боку (левом / правом)



Положение Симса



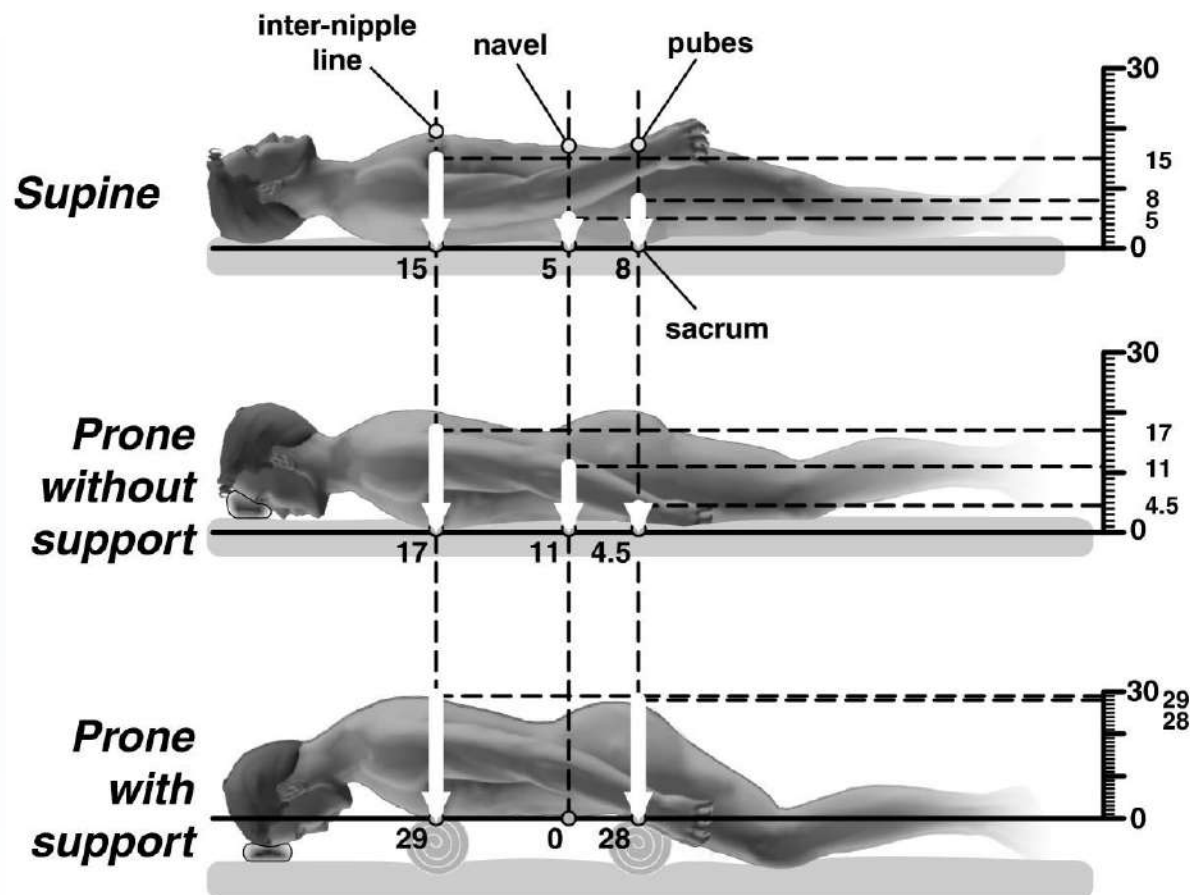
Положение на животе Pron-position



Изменение давления на кожу и мягкие ткани в зависимости от положения пациента



Contact Pressure (cmH₂O)



Тест «пальцем»



- ▶ Рекомендуется в качестве критерия для планирования временных интервалов изменения положения тела пациента;
- ▶ Нажать пальцем на кожу в подкостной области;
- ▶ Непроходящее после нажатия покраснение указывает на нарушение микроциркуляции крови.



Рекомендации отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».

Продолжение



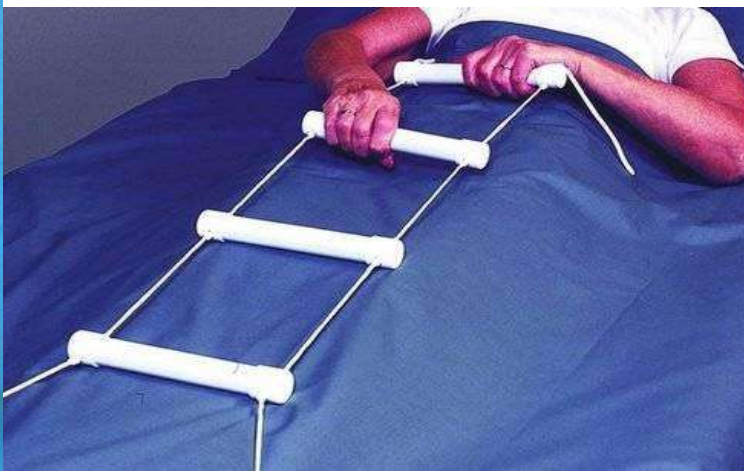
- ▶ Перемещение пациента осуществлять бережно, исключая трение и сдвиг тканей, приподнимая его над постелью, или используя подкладную простыню.
- ▶ Не допускать, чтобы в положении «на боку» пациент лежал непосредственно на большом вертеле бедра.
- ▶ Не подвергать участки риска трению. Массаж всего тела, в т. ч. около участков риска (в радиусе не менее 5 см от костного выступа) проводить после обильного нанесения питательного (увлажняющего) крема на кожу.
- ▶ Мытье кожи проводить **без трения и кускового мыла**, использовать жидкое мыло. Тщательно высушивать кожу после мытья промокающими движениями.
- ▶ Использовать непромокаемые пеленки и подгузники, уменьшающие чрезмерную влажность.

Рекомендации отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».

Продолжение



- Максимально расширять активность пациента: обучить его самопомощи для уменьшения давления на точки опоры. Поощрять его изменять положение: поворачиваться, используя поручни кровати, подтягиваться.



Научить родственников и других лиц, осуществляющих уход, уменьшать риск повреждения тканей под действием давления



- ▶ регулярно изменять положение тела;
- ▶ использовать приспособления, уменьшающие давление (подушки, поролон, прокладки);
- ▶ соблюдать правила приподнимания и перемещения: исключать трение и сдвиг тканей;
- ▶ осматривать всю кожу не реже 1 раза в день, а участки риска – при каждом перемещении;
- ▶ осуществлять правильное питание и адекватный прием жидкости;
- ▶ правильно осуществлять гигиенические процедуры: исключать трение

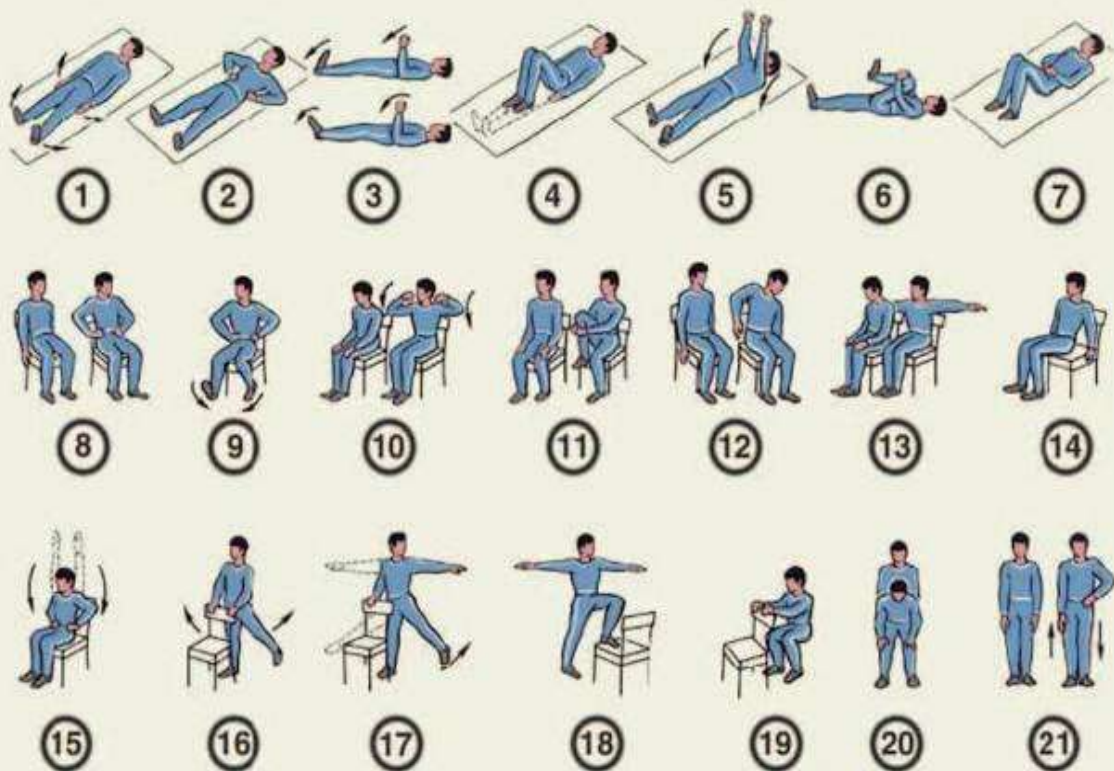


Рекомендации отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».

Продолжение



- ▶ Не допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при чрезмерном увлажнении - подсушивать, используя присыпки без талька, при сухости - увлажнять кремом;
- ▶ Постоянно поддерживать комфортное состояние постели: стряхивать крошки, расправлять складки;
- ▶ Обучить пациента дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять их каждые 2 часа.



Общая схема лечения пролежней

Первичная оценка общей ситуации:

- место образования пролежня, степень тяжести, общее состояние раны;
- оценка статуса пациента.

Лечение

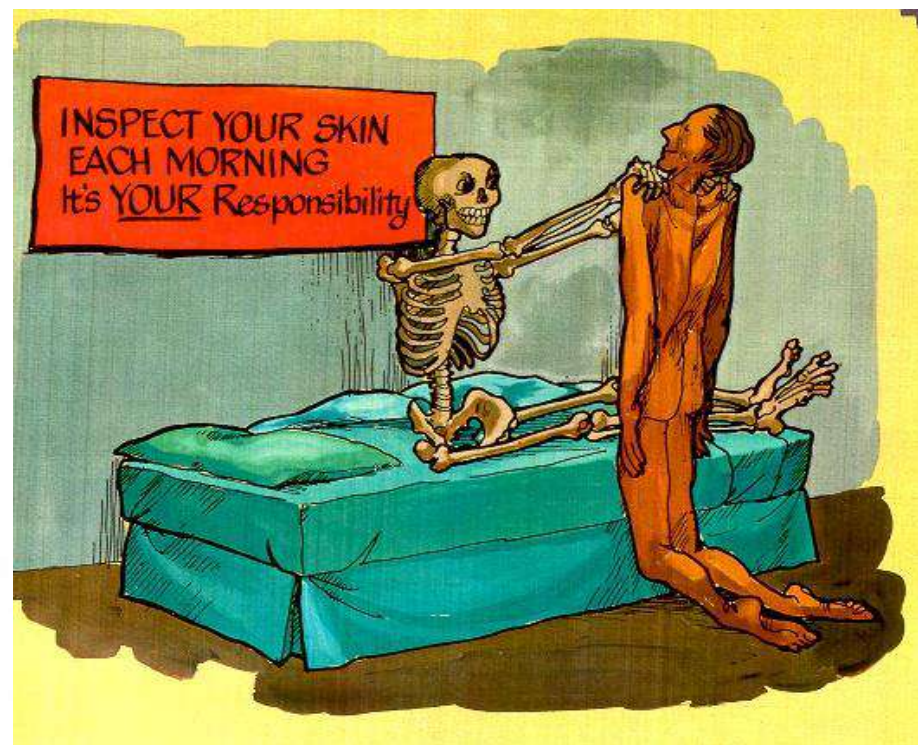
Этиологическая терапия: полное устранение давления на пролежень до заживления.

Местная терапия: адекватная обработка и лечение раны.

Зажил ли пролежень?

ДА: контроль и продолжение терапии согласно плану лечения.

НЕТ: тщательная проверка качества выполняемых мероприятий, особенно снятие нагрузки.



Основные группы средств для местного лечения пролежней



Обеззараживающие

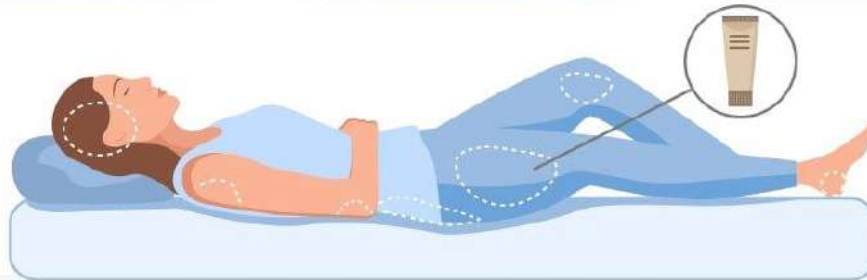
Антибактериальные

Противовоспалительные

Заживляющие

Некролитические

Усиливающие
микроциркуляцию



Выбор средств в соответствии со стадией развития пролежней

1-я стадия



Антисептики, препараты
для усиления
микроциркуляции

2-я стадия



Антисептики, средства
для улучшения микроциркуляции,
антибиотики, заживляющие,
противовоспалительные

3-я и 4-я стадии



То же + некролитические
средства

Смена нательного белья



Дезинфекция постельных принадлежностей



- ▶ Смена белья не реже 1 раза в 7 дней и по мере загрязнения!
- ▶ У родильниц смена белья каждые 3 дня и по мере загрязнения
- ▶ Обязательна после каждого убытия пациента (выписка, перевод, смерть), а также по эпид. показаниям.
- ▶ Дезинфекционной обработке также подлежат кровать и тумбочка пациента (все «личное пространство»).
- ▶ Проводится в дезинфекционной камере (при применении гигиенических наматрасников допускается сан. обработка матрасов в отделении).
- ▶ «В случае использования для покрытия матрасов чехлов из материала, допускающего влажную дезинфекцию, камерная обработка не требуется».
- ▶ Тапочки больных перед выпиской подвергают камерной дезинфекции или обработке разрешенными для этих целей дезинфицирующими средствами.

